به نام خدا

کتاب

بهداشت و تغذیه مادر و کودک

نویسنده :

پریوش حلم درشت، اسماعیل دل پیشه

فصل اول

کلیات

بهداشت مادر و کودک رشته ای از بهداشت عمومی است که مراقبت و محافظت کامل از زنان و کودکان را به عهده دارد هدف کلیه برنامه های بهداشت مادر و کودک تامین و نگهداری سلامت جسمی و روانی و اجتماعی مادران و کودکان جامعه است که از طریق ارائه خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه ای و بهزیستی عمل می‌کند به عبارت دیگر در بالا بردن سطح بهداشت و بهزیستی مادر و کودک و پرورش استعداد و توانایی آن برای زندگی بهتر و تطابق کلی و مناسب تر با محیط موثر است

با توجه به اینکه بهداشت مادر و کودک مراقبت کامل و کافی و مداوم و همه جانبه مادران و کودکان را در طول زندگی و به قولی دیگر داستان حمایت از نسلی به نسل دیگر را با هدف پروراندن نسل سالم تر و بهتر دربرمی‌گیرد دامنه فعالیت بسیار گسترده ای دارد که به شرح زیر قابل بررسی و مطالعه است

مراقبت های پیش از ازدواج زمانی که دختر و پسر جوان بنا بر علاقه و دوستی می خواهم با هم ازدواج کنم خدمات بهداشت مادر و کودک آغاز می شودو مشورت های پیش از ازدواج با هدف پیشگیری از ازدواج نامناسب چه از نظر اجتماعی که از نظر پزشکی انجام می‌شود و همین اقدامات عبارتند از

۱-بررسی سوابق اجتماعی روانی و خانوادگی داوطلبین ازدواج

۲-معاینات کامل پیش از ازدواج به منظور پی بردن به ناهنجاری ها و بیماری های گوناگون ارثی و اکتسابی قابل درمان و غیرقابل درمان

۳-زن و مرد و تفهیم اینکه توجیه صلاحیت ازدواج الزاماً نباید توجیه کننده صلاحیت اجتماعی اقتصادی و روانی آنان برای مادر شدن یا پدر شدن باشد و در اینجا نقش خدمات آموزشی و تنظیم خانواده در مراحل پیش از ازدواج و پس از آن روشن می شود

در برنامه مترقی بهداشت خانواده زن و مرد همیشه باید مراقبت حاملگی ها وتولدها باشم و مسلماً تولدهای خواسته پدر و مادر بهترین تولدهاست در این صورت باز هم اهمیت فاصله‌گذاری مناسب بین ازدواج‌های زود رفت و اولین تولد و بین تولد های پی در پی روشن می شود و برنامه بهداشت مادران چنین رسالتی را به عهده می‌گیرد که برای سلامت مادر و نوزاد خدمات تنظیم خانواده را نیز ارائه دهد

مراقبت های دوران بارداری

هدف اصلی این گونه مراقبت‌ها آن است که حتی المقدور دوران بارداری به خوبی سپری و به سلامت پایان پذیرد و از مرگ و میر نوزادان و مادران که در اثر عوارض حاملگی ممکن است ایجاد شود تا آنجا که امکان دارد جلوگیری و بالاخر از ناراحتی های روحی و جسمی دوران حاملگی و زایمان و نیز روز های بعد از زایمان کاسته شود

اگرچه حاملگی انداز طبیعی ولی در اثر آن تغییرات زیادی در کلیه دستگاه های بدن زن حامله به وجود می‌آید نه تنها بارداری تغییرات جسمی در مادر ایجاد می‌کند بلکه زن از نظر روحی نیز تغییر و تحول پیدا می کند احساسات مادر نسبت به خودش ،جنین یا نوزادش و همچنین همسرش تغییرات مهمی هستند که در جریان حاملگی و تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد تا با پیدایش اولین علائم غیر عادی اقدامات لازم برای حفظ سلامتی او به عمل آید

مراقبت های دوران بارداری باید با آگاهی به موقع از وضع غیر عادی زن باردار و مواظبت کامل او به منظور کاهش مخاطرات حاملگی و مرگ و میر مادر و جنین ارائه شود در چنین صورتی با توجه به اینکه بزرگترین علل مرگ و میر مادران در کشور ما خونریزی عفونت و مسمومیت های حاملگی است باید زنان باردار تحت مراقبت‌های لازم قرار گیرند و اصول این رقابت‌ها معمولا عبارتند از:

۱- تشخیص آبستنیی

۲-باتوجه به شرح کامل زن باردار از نظر اجتماعی پزشکی و سابقه زایمانی او

۳- معاینه مرتب و مداوم زن باردار دفعات این معاینه با توجه به نیروی انسانی و تسهیلات پزشکی منطقه و شرایط بهداشتی زن باردار متفاوت است ولی به هر حال علاوه بر معاینه کامل در اولین مراجعه آزمایش های لازم برای کنترل وزن، فشار خون و ورم پا در تمام دفعات مراجعه زن باردار باید انجام پذیرد که مراقبت ها باعث می‌شود که آبستنی های آسیب پذیر به موقع تشخیص داده شود و تحت مراقبت در آید

منظور از آبستنی آسیب پذیر آن است که در آن امکان مخاطرات حاملگی و تهدید سلامت مادر و نوزاد بیشتر باشد به نحوی که نوزاد احتمال ابتلاء بیشتری به نقایص جسمی عقلی و اجتماعی که مانع رشد و تکامل استعداد و یادگیری طبیعی می‌شود خواهد داشت که این موارد ممکن است مربوط به دوره پیش از زایمان یا زایمان یا پس از آن باشد و وجود عوارض در نتیجه توارث یا محیط نامطلوب که با هم یا به طور جداگانه تاثیر میکنند به وجود آید

۳- مراقبتهای دوران زایمان و پس از آن ده غالب کشورهای پیشرفته، میزانهای مرگ و میر کودکان به دلیل مراقبتهای ویژه به نیا کاهش شدید داشته است. ولی متاسفانه در اکثر ممالک در حال توسعه، اغلب زایمانیا شیوه های سنتی و بدون توجه و رعایت اصول بهداشتی انجام می پذیرد.

در ایران نیز در بسیاری از موارد زایمانها در منازل و توسط ماماهای محلی در شرایط نامطلوب و غیربهداشتی انجام می گیرد. بنابراین بهبود مراقبتهای حین زایمان و پس از آن به منظور پیشگیری از خونریزیهای ناشی از زایمان و عفونتهای پس از آن، یکی از مسائلی است که می بایست ارائه دهندگان خدمات بهداشت مادر و کودک به آن توجه کنند، چه بسیاری از سهل انگاریها که در حین زایمان و پس از آن باعث بروز عوارض بسیار وخیمی می شود. گرچه ممکن است بعضی از این عوارض مختصر باشند و در خیلی از موارد به کلی بهبود یابند، ولی برخی اوقات نیازمند جراحیهای سخت و زحمات بسیاری هستند و متأسفانه گاهی نیز به مرگ منجر میگردند.

وجود اصول صحیح پرستاری پس از زایمان چه در بیمارستان و چه در منزل و توجه به بهداشت شخصی، استراحت، خواب، اجابت مزاج، وضع ادرار، وضع ترشح دستگاه تناسلی در مادر، مواظبت از پستانها و معاینات مرتب پس از زایمان تأثیرات کاملا مثبتی بر سلامت مادر و کودک دارد.

۴- مراقبت از کودکان در سنین مختلف اگر هدف نهایی خدمات بهداشتی را تأمین سلامت اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه بدانیم و این هدف آرمانی را در مقابل این حقیقت قرار دهیم که در مناطق کمتر توسعه یافته دنیال از جمعیت زیر ۵ سال هستند و زیر ۱۴ سال، متوجه می شویم که کودکان اکثریت عظیمی از میلیاردها انسان روی زمین را تشکیل می دهند که به طور طبیعی نیازمندیهای بیشتری به خدمات بهداشتی دارند.

نگاهی به جمعیت ایران که دارای رشد سریعی است نشان می دهد که اکثریت جمعیت در گروههای سنی پایین قرار دارند. توجه به این گروه سنی در هر جامعه، سرمایه گذاری برای آینده | مملکت است. باید دانست که در بعضی از جوامع، کودکان بیمار با عمر کوتاه خود که ناشی از پدیده عدم تساوی انسانها در مقابل سلامت و مرگ است، بار سنگینی بر دوش اجتماعند و برعکس کودکان سالم و برخوردار از مزایای بهداشت و فرهنگ و طول عمر، بزرگترین سرمایه یک کشورند. بنابراین هر گونه اقدامی در جهت توجه به کودکان گامی برای به وجود آوردن

مهمترین ساخت و بهترین بافت اجتماعی در آینده است.توجه به رشد و تکامل طبیعی دوران کودکی به وسیله ی تغذیه ی خوب و حمایت بهداشتی ممتد ومداوم ،نمایانگر سرمایه گذاری موثر در بهداشت و سلامت آینده آنان

اهم اقدامات بهداشتی که تحت پوشش بهداشت مادر و کودک برای این گروه سنی می توان انجام داد به شرح زیر قابل ذکرند:

۱- تأمین تغذیه کافی و مناسب

۲ - محافظت در مقابل عفونت و بیماریها

۳- محافظت در برابر سوانح

۴- انجام معاینات دوره ای منظم

۵- رفع هر نوع نقص جسمانی و روانی در صورتی که وجود داشته باشد

۶ - تشخیص زودرس و درمان هر نوع بیماری که ممکن است کودک به آن مبتلا شود

۷ - فراهم کردن محیط روانی رضایت بخش برای کودکان

۸- تأسیس درمانگاههای بهداشت کودکان برای حل مشکلات جسمانی، روانی و عاطفی آنان.

لازم به یادآوری است که رسالت بهداشت مادر و کودک تنها در پایین آوردن میزان مرگ و میر اطفال نیست بلکه می بایست این موضوع را نیز در نظر گرفت که اگر این میزان پایین می آید چه کسی و با چه کیفیتی زنده می ماند؟ به عبارت دیگر چگونه خدماتی باید وجود داشته باشد تا کودک به جمیع تواناییهای جسمی، عقلی، روانی و عاطفی خود برسد. در اینجا باید به این مفهوم اتکا داشت که مبارزه با بیماریهای واگیر گروهی را به اسم «از مرگ رستگان»

در جامعه دید می آورد و رسالت بعدی بهداشت مادر و کودک این است که چگونه این گروه کثیر «از مرگ رستگان»را به افرادی فهیم و توانا تبدیل کند.

مراقبت از کودکان معلول و عقب افتاده

از آنجا که کودکان معلول و عقب مان زندگی لذت می برد، شاد باشد و از بهداشتی و درمانی لازم و برنامه ر زندگی امیدوار ساخت تا آنان احساس کنند که می شناسد. زیرا لازمه وجود جامعه خوب از کودکان داشته باشد و از آنها در همه جا کودکان معلول و عقب مانده حق دارند به همان اندازه که یک کودک سالم و باهوش از،شاد باشد و از زندگی خود لذت ببرد، بدین جهت لازم است با اقدامات های لازم و برنامه ریزیهای آگاهانه و اجرای پی درپی آنها، این گونه کودکان را به ان احساس کنند که جامعه به آنها علاقه دارد احتیاجاتشان را میشناسند .زیرا لازمه وجود جامعه خوب آن است که درک آگاهانه ای از مشکلات این قبیل کودکان داشته باشند و از آنها در همه جا حمایت کند و در رفع معلولیت وعقب ماندگیشان کوشا باشد.سهم اقدامات بهداشت مادر و کودک در این زمینه نیز در خور توجه است

۶- تنظیم خانواده هدف از اجرای برنامه های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، تأمین و حفظ سلامت و بهداشت مادران و کودکان آنان، ارتقای کیفیت زیست افراد خانواده و بهبود شرایط زندگی اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی جوامع است. با کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان و تعداد موارد سقط جنینهای عمدی به علت حاملگیهای ناخواسته، فراهم کردن شرایط و امکانات بهتر برای رشد جسمی، روانی و اجتماعی کودکان و مطلوبتر شدن وضع اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی افراد خانواده و نهایتا جامعه، اهداف مورد نظر برنامه حاصل می شود.

برای تحقق این اهداف، یا آمیزش جنسی را باید تقلیل داد و یا اینکه روشهایی به کار برد که با وجود آمیزش جنسی، لقاح و آبستنی انجام نگیرد. راه اول اصولا عملی نیست زیرا یکی از مشخصات ویژه رفتاری انسان، میل زیاد او به آمیزش و ارضای تمایلات جنسی است. از این رو بشر کوشیده است تا روشهایی ابداع کند که ضمن عمل جنسی، از لقاح و تولید مثل جلوگیری شود.

روشهای متعددی برای جلوگیری از بارداری وجود دارد که شکلهای نسبتا ساده تا اعمال جراحی و بستن لوله های ناقل اسپرم در مرد و و لوله های فالوپ در زنان را در بر می گیرد. از جمله روشهای رایج پیشگیری از حاملگی، می توان اینها را نام برد: نزدیکی منقطع، استفاده از پوشش لاستیکی(کاندوم)، قرصهای ضدبارداری، آمپولهای ضد بارداری، متدریتمیک (روشی که در آن، زن و شوهر در فاصله زمانی که امکان باروری در دوره ماهانه قاعدگی وجود دارد، از نزدیکی خودداری می کنند) ، دیافراگم مهبلی (وسیله گنبدی شکلی که معمولا از جنس لاستیک بوده و قبل از نزدیکی، داخل مجرای زنانگی گذاشته می شود)

، کلاهک دهانه زهدان (این وسیله شبیه دیافراگم مهبلی است ولی برخلاف آنکه تمامی قسمت بالاي مهبل را می پوشاند، فقط گلی ازهدان را فرا می گیرد و مانع عبور اسپرماتوزوئیدها از آن می شود و ای . یو. دی (وسیله داخی رحمی که لانه گزینی تخم را در مخاط رحم دچار اشکال نموده و مانع از حاملگر استفاده از داروها و مواد شیمیایی به صورت کرم و ژله و شیاف، اسفنج (جسمی است ماده مصنوعی خاصی که به اسپرم آغشته شده ساخته شده و قبل از نزدیکی در واش می شود) ، حلقه های واژینال (حلقه هایی در اندازه های متفاوت، حاوی هورمونهای زنانه که به منظور پیشگیری از حاملگی در واژن قرار داده می شود)

نورپلانت (کپسولها فورمونهای زنانه که در زیر پوست بازو و یا ساعد کاشته می شود و به مدت چند می تواند از باردار شدن پیشگیری کند)

، شستشوی مهبلی (در این روش، مهبل با آر محلولهای کشنده نطفه شسته می شوند تا مانع حاملگی شود)

، بستن لوله ها(این روش عبارت از بستن لوله ناقل نطفه در مرد و یا لوله تخمدان در زن بوسیله عمل جراحی است)

فلسفه ضرورت خدمات بهداشت اهمیت و ضرورت اجرای برنامه های بهداشت مادر و کودک را می توان از دیدگاههای مختلف بررسی کرد

بعد عملی: براساس مبانی کلی بهداشت و اصول شناخته شده پیشگیری از بیماری هابا توجه به مبانی کلی بهداشت که عبارت از اجرای مسائلی غیردرمانی، تکیه بر اصل رفتار پذیری انسان در به وجود آوردن باورها و عادات بهداشتی و فراهم کردن شرایط مناسب محیط انسانی است، اصل اساسی در مراقبتهای بهداشتی مادر و کودک به کارگیری عوامل وتوجه به مسائلی است که زمینه ایجاد دو جریان را به نحو زیر فراهم می سازد:

- حرکت مطلوب رشد و تکامل انسان از آغاز زندگی تا پایان کودکی که در آن مهمترین سیر منحنی رشدی، به خصوص تکامل مغز صورت می گیرد.

-جریان حرکت زیستی اجتماعی انسان که با تأمین عوامل مؤثر بر رشد و تکامل افراد یک نسل، زمینه بهبود رشد و پیشرفت نسلهای بعدی فراهم می شود.

ب - بعد آماری: براساس اختلاف میزانهای آمار حیاتی حاصل از اجرای فعال یا غیر فعال برنامه در کشورهای مختلف.

در این زمینه با مقایسه آمار کمترین و بیشترین میزان مرگ و میر مادران باردار، نوزادان و کودکان کشورهای مختلفی که خدمات بهداشت مادر و کودک در آنها با ویژگیهای جدی بودن یا نبودن، فراگیر بودن یا نبودن، و مستمر بودن یا نبودن به اجرا گذاشته می شود، می توان به روشنی نقش ارزنده این زمینه خدمات بهداشتی را دریافت

ج - بعد اجرایی: براساس معیارهای انتخاب اولویت.

می دانیم که یکی از شرایط مهم و اساسی در اجرای خدمات مختلف بهداشتی آن است که هر چه بیشتر با عوامل مختلفی که می توان آنها را معیارهای انتخاب اولویت»

نامید هماهنگ باشد و می بینیم که خدمات بهداشت مادر و کودک به حد کمال از این ویژگیها برخوردار است. ا برخی از این معیارها عبارتند از

ا. کثرت یا کمیت افراد برخوردار شونده از خدمات

۲- کیفیت حیاتی یا آسیب پذیری جمعیت تحت پوشش خدمات

۳. اثرهای آنی و آتی حاصل از اجرای خدمات به استفاده هر چه بیشتر از خود یاری مردم در پیشبرد برنامه و اجرای خدمات

۴- پایداری خدمات عرضه شده بدون نیاز به سازمان حفظ و حمایت مستمر

۵ - تنوع و سهولت عرضه خدمات توجه به ابعاد ذکر شده در می یابیم که اجرای برنامه های خدمات بهداشت مادر و کودک تقاء دهنده، پیشگیری کننده و توانبخش باشد و از این جهت باید هر چه بیشتر و جدیدتر به بسط و گسترش مراقبتهای بهداشتی مادر و کودک توجه شود.چون نگاه نگران یک کودک معصوم سخت تکان دهنده است و امتداد خط این نگاه به آینده ختم می شور عدم توجه و قصور در مراقبتهای بهداشتی لازم از کودکان می تواند عامل بسیار مهم در ایجاد حلقه ی معیوب بین رشد نامناسب یک نسل و به وجود آمدن نسلهای ناسالم بعدی باشد

فصل دوم

ساختمان و کار دستگاه تناسلی در انسان

یکی از مهمترین خصوصیات حیات، تولید مثل است. توانایی تولید مثل در انسان معمولا بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی حاصل می شود که آن را بلوغ می نامند. در هنگام بلوغ تولید و ترشح هورمونهای جنسی مانند تستوسترون در مرد و استروژن و پروژسترون در زن به مقادیر قابل توجهی افزایش می یابد و به واسطه اثرات آنها، صفات ثانویه جنسی بروز می کند. از جمله صفات ثانویه در جنس مذکر، اینها هستند: رشد و نمو آلت تناسلی، کیسه بیضه، بیضه ها و تولید یاخته های بالغ جنسی در بیضه ها، بم شدن صدا و رویش مو در ناحیه پوست صورت، زیربغل، سینه و شرمگاه، کاهش ذخایر چربی بدن و ستبر شدن ماهیچه ها و از صفات ثانویه در جنس مؤنث، رشد و نمو پستانها، رویش مو در شرمگاه و زیربغل، شروع قاعدگی، تولید یاخته های بالغ جنسی، رشد رحم، لوله های رحم و مهبل، افزایش بافت چربی در پستان و ناحیه لگن، رشد و نمو غده ها و مجاری شیری.

از آنجا که در بررسی مسائل مربوط به دوران حاملگی به ویژه در بیان مرحله های گوناگون زایمان، آشنایی فراگیران عزیز با ساختمان دستگاه تناسلی زنان بسیار ضروری به نظر می رسد لذا در این فصل ضمن نگرش بسیار مختصر و کوتاه بر دستگاه تناسلی جنس مذکر، به بررسی جزئیات کار دستگاه تناسلی در زنان خواهیم پرداخت.

دستگاه تناسلی مردان: دستگاه تناسلی مردان شامل بیضه ها، مجاری بیضه ها، غدد ضمیمه آنها (پروستات، غده های کوپر، کیسۀ منی) و آلت تناسلی است.

آلت تناسلی

این عضو در جلوی کیسه بیضه قرار گرفته است.

بیضه ها بیضه ها که در ترشح هورمونهای مردانه و تولید اسپرماتوزوئید نقش عمده دارند اعضایی هستند بیضی شکل و پهن که تعداد آنها دو عدد و طول آنها حدود ۵ سانتی متر است و درون کیسه بیضه جای دارند. لایه خارجی بیضه از بافت لیفی متراکم و سفیدی ساخته شده که سپید پرده نامیده می شود. این لایه در کنارۀ عقبی بیضه به داخل آن وارد می شود و دیوار قایم و ناتمامی را ایجاد میکند که خود به چند دیواره تقسیم می شود و بافت بیضه را به ۲۵۰ تا ۴۰۰ لپک تقسیم میکند. هریک از این لپکها حاوی یک تا سه لوله پیچاپیچ باریک به نام لوله های اسپرم ساز هستند. | یاخته های جنسی نر، که در مراحل مختلف تکامل هستند، در داخل این لوله ها یافت می شوند. گذشته از یاخته های جنسی، یاخته های دیگری به نام یاخته های سرتولی در بیضه یافت می شوند که مسئول محافظت و تغذیه اسپرماتوزوئیدها هستند. یاخته های بینابینی الیدیگ نیز به صورت پراکنده ای در بین لوله ها قرار گرفته اند و مسئول ترشح هورمونهای مذکر هستند.

لوله های اسپرم ساز پس از الحاق به یکدیگر لوله های مستقیم بزرگتری را به وجود می آورند که به نوبه خود پس از تداخل، شبکه توری شکلی را به نام شبکه بیضه می سازند که یاخته های جنسی پس از ساخته شدن در لوله های اسپرم ساز به درون آن ریخته می شوند.

از شبکه بیضه در حدود۲۰لوله ی کوچک ومارپیچ خارج میشور که پس از عبور ازسپید پرده به اپیدیدیم میپیوندند.اپیدیدیم هر بیضه لوله مارپیچی است که قسمت اول تشکیلات مربوط به مجاری بیضه را تشکیل میدهد.

مجرای منی در ادامه اپیدیدیم است که ترشحات کیسه های منی پس از الحاق به این مجرا، مجرای انزال را به وجود می آورد که از طریق این مجرااسپرماتوزوئید و ترشحات کیسۀ منی به پیشابراه می ریزد. پیشابراه لوله ای است که ادرارو مایع منی از آن عبور می کند. این لوله از مثانه شروع و به سوراخ خارجی مجرا منتهی می شود (شکل 1).

کیسه های منی

کیسه های منی دو کیسه غشایی مارپیچ کوچک هستند که در عقب مثانه ونزدیک گردن قرار گرفته اند. این کیسه ها برخلاف عقیده عمومی محل ذخیره اسپرمها نیست (مقدار کمی از اسپرمها بم و قسمت اعظم آن در مجرای منی بر و آمپول آن ذخیره می شود) بلکه غده هایی هستند که ماده

ای موکوسی حاوی فروکتوز، اسیدهای آمینه و ویتامین C تراوش می کنند که جهت تغذیه ی اسپرماتوزوئیدها به کار می روند. این ترشحات در موقع انزال به مایع منی اضافه

احتمالا با واکنش قلیایی خود به همراه ترشحات پروستات، نقشی در حفاظت

اسپرماتوزئیدها در برابر محیط اسیدی مهبل به عهده دارند.

پروستات

غده ای است مخروطی شکل به اندازه انجیر که در زیر مثانه واقع شده است. مایع مترشحه از پروستات، رقیق، شیری رنگ و قلیایی است و به مایع منی افزوده می شود. به دلیل واکنش قلیایی که دارد در خنثی کردن محیط اسیدی مهبل نقش مؤثری ایفا می کند.

غده های کوپر

دو غده کوچک به اندازه نخود هستند که پایینتر از پروستات و در طرفین پیشابراه قرار دارند. این غده ها مایعی قلیایی ترشح می کنند که جزئی از مایع منی است.

دستگاه تناسلی زنان دستگاه تناسلی زنان را در قسمت مشخص تشکیل می دهد.

۱- دستگاه تناسلی خارجی که بیشتر عهده دار روابط تناسلی است. اعضای تناسلی خارجی زنان که جمعة فرج نامیده می شود شامل برجستگی ونوس، لبهای بزرگ، لبهای کوچک ، کلیتوریس غده های اسکن و بارتولن و پرده بکارت است.

برجستگی ونوس

برآمدگی مدوری در جلوی شرمگاه و ناشی از انباشتگی چربی در زیر پوست است. این برآمدگی پس از بلوغ با موهای زهار پوشیده می شود.

لبهای بزرگ و لبهای کوچک

لبهای بزرگ در چین متشکل از بافت چربی و پوست است که لبهای کوچک را می پوشانند. البهای کوچک نیز دو چین کو چک پوستی هستند که درون لبهای بزرگ قرار گرفته و دهلیز را که دهانه پیشابراه و مهبل در آن باز می شوند، در بر می گیرند.

کلیتوریس

عضو بسیار کوچک نعوظی است که در حقیقت معادل آلت تناسلی در نزد مردان است. این عصر از دو جسم نعوظی کوچک تشکیل شده و در ساختمان آن جسم کوچک به نام حشفه کلیتوریس شرکت دارد که مملو از انتهای اعصاب حسی است. این عضو در تحریک جنسی زن مهم است

غده های اسکن و بارتولن

سراخ پیشابراه توسط غده های متعدد وکوچک اسکن احاطه شده است.این غده ها معادل غده ی پروستات در مرد هستند وترشحات آنها توسط دو مجرا که در طرفین سوراخ خارجی پیشابراه باز می شوند به خارج می ریزند.

غده بارتولن نیز که دو غده خوشه ای به اندازه و شکل لوبیای کوچک هستند، بین لبهای کوچک و دیواره مهبل قرار گرفته اند. این غدد معادل غده های کوپر در مرد هستند و ماده موکوسی مترشحه از آنها هنگام مقاربت، اثر نرم و لغزان کننده دارد.

پرده بکارت

پرده ارتجاعی است که تا حدی مجرای مهبل را مسدود می کند و اندام تناسلی خارجی را از اندام تناسلی داخلی جدا میکند. این پرده در بعضی از افراد ممکن است به طور مادر زادی کاملا بسته باشد که در این صورت خون قاعدگی در پشت پرده جمع می شود و دردآور است که با سوراخ کردن پرده، خون خارج می شود. پرده بکارت معمولا به اشکال مختلف حلقوی، شبکه ای و غیره دیده می شود که با اولین مقاربت پاره و خونریزی مختصر و گاهی شدید ایجاد میکند.

۲- دستگاه تناسلی داخلی که مسئول رشد و نمو و زایمان جنین است شامل مهبل، رحم، لوله های رحم و تخمدانهاست. اعضای داخلی توسط رباطهایی به یکدیگر و همچنین به جدار لگن اتصال دارند (شکل ۲). .

مهبل

یک مجرای عضلانی است به طول تقریبی۱۰سانتی متر که محیط خارج را به داخل رحم ربط می دهد. مسیر آن به طرف عقب و بالا است. از این مجرا خون قاعدگی و طفل در موقع زایمان عبور می کنند. در موقع مقاربت نیز آلت وارد این مجرا می شود. قسمت تحتانی مهبل از دو طرف شب به وسیله عضلات محکمی احاطه شده است که می توانند با انقباض و انبساط خود اندازه ی آن را تغییر دهند. قسمت فوقانی مهبل متسع تر است. مهبل از لایه های نازک مخاطی پوشیده شده است که می تواند به خوبی در حین مقاربت یا زایمان گسترش یابد. در بالای مهبل، گردن رحم یا دهانه زهدان قرار دارد. وقتی آن را با انگشت لمس کنیم نظیر غضروف بینی سفت است که کاملا از دیواره نرم مهبل مشخص می باشد.غددی که در قسمت رحمی دهانه ی زهدان قرار دارند مواد لزجی در مجرا ترشح می کنند که اسپرم می تواند در آن شنا کند وبه جلو رانده شود.

رحم یا زهدان

رحم عضوی است گلابی شکل که جدار آن از ماهیچه های ضخیمی ساخته شده است. این عضو در قسمت قدامی حفره لگن به حال معلق در بالای مثانه و جلو رکتوم قرار گرفته است. در حالت عادی طول آن حدود

۵/۷ سانتی متر و عرض آن ۵ سانتی متر است. قسمت پایین رحم که در داخل مهبل قرار دارد، سر یا گردن رحم نامیده می شود. تنه یا جسم رحم در بالای گردن رحم واقع است و قسمتی از تنه رحم که بالاتر از محل دخول لوله های رحمی به تنه رحم قرار گرفته است به ته رحم موسوم است.

دیواره رحم از ۳ لایه ساخته شده است. لایه خارجی که همان صفاق پوشاننده رحم است. لایه میانی، بافت ماهیچه ای رحم، کلفت و ضخیم است. لایه داخلی از بافت پوششی و

بافت همبند تشکیل شده است . ضخیم می شود تا تخم بارور شد

کا شده است و آندومتر نامیده می شود. آندومتر در مدت دوره های ماهیانه و تا تخم بارور شده در آن جای گیرد. اگر حاملگی پیش نیاید مخاط ضخیم شده تداری خون دفع می شود و همین خون است که قاعدگی را سبب می شود. در مواقعی ساری صورت گیرد تخم بارور می شود و داخل مخاط رحم لانه گزینی و شروع به رشد و

د کند. رحم نیز برای جا دادن آن بزرگ می شود، به طوری که در پایان حاملگی وزن رحم تقریبا به یک کیلوگرم می رسد، در صورتی که در حال عادی وزن رحم در حدود ۶۰ گرم است. بعد از زایمان تدریجا تا ۶ هفته الی دو ماه به اندازه طبیعی خود می رسد. بنابراین کار رحم عبارت از حمایت جنین در حالت رشد و خارج کردن آن بعد از تکمیل اعضا در موقع زایمان است.

لوله های رحم لوله های رحم یا لوله های فالوپ، دو لوله قابل انعطاف و شبیه ترومپت هستند که از ته رحم شروع و به طرفین آن کشیده می شوند. طول این لوله ها در حدود ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر است و دیواره آنها مانند دیواره رحم از ۳ لایه مخاطی، ماهیچه ای و سروز تشکیل شده است. لوله های رحم از ۴ قسمت متمایز تشکیل شده اند که از داخل به خارج عبارتند از: ا- قسمت رحمی

داخل جداری که در جدار رحم قرار دارد و سوراخ آن به داخل حفره رحم باز می شود.

۲- تنگه که بلافاصله بعد از قسمت رحمی قرار گرفته و تنگترین قسمت لوله است. ۳- آمپول (حباب) که گشادتر از سایر نقاط است.

۴- ناحیه شیپوری که به محوطه شکم باز می شود. این قسمت از لوله توسط زوایدی شبیه انگشت به نام شرابه احاطه شده است. قسمت شرابه دار لوله به طرف تخمدان خم و به آن نزدیک شده است ولی ضرورتی ندارد که حتما با آن تماس مستقیم پیدا کند. شرابه ها عهده دار جذب تخمک و هدایت آن به داخل لوله ها هستند. لوله های رحمی نیز تخمک و یا تخم را توسط حرکات مژه های یاخته های لایه مخاطی و همچنین حرکات دودی لوله های رحمی به محوطه رحم منتقل می کنند.

تخمدانها

دانها دو عضو بادامی شکل هستند که در حفره شکمی در دو طرف زهدان، نزدیک به انتهای می رحم قرار دارند. طول تخمدانها حدود ۴ سانتی متر، عرض آنها ۲ سانتی متر و طولشان /۵ سانتی متر است. ساختار و کارکرد تخمدانها در سنین مختلف متفاوت است.

مهمترین اعمال تخمدانها عبارت از ترشح هورمونهای زنانه، تولید و تکامل تخمک و تخمک گذاری است.

استروژن و پروژسترون در هورمون اساسی تخمدان هستند که ترشح آنها تحت کنترل هورمونهای غده هیپوفیز مانند

F.S.H و LH قرار دارد. هورمون FSH (هورمون محرک فولیکول موجب رشد فولیکولهای تخمدان (هر تخمدان شامل تعداد زیادی فولیکول است که تولید و تکامل هر تخمک با رشد و به اصطلاح رسیدن یک فولیکول همراه است و ترشح بیشتر استروژن می شود. با افزایش مقدار استروژن در خون، ترشح FSH هیپوفیز دچار وقفه می شود و ترشح LH (هورمون جسم زرد) افزایش می یابد که موجب تخمک گذاری می شود.

در جریان رشد و تکامل یاخته هایی که منجر به پیدایش اوول یا تخمک می شوند (او وژنز)، از هر یاخته ابتدایی تنها یک تخمک حاصل می شود. حال آن که در جریان رشد و تکامل یاخته هایی که منجر به پیدایش گامتهای نر یا اسپرماتوزوئید می شوند، (اسپرماتوژنز) از هر یاخته ابتدایی، ۴ اسپرماتوزوئید تولید می شود. یک تخمک در مقایسه با اسپرماتوزوئید خیلی بزرگتر است. هر ماه در حدود اواسط دوره ماهانه تخمک گذاری انجام می شود، بدین معنی که فولیکول بالغ پاره و تخمک از تخمدان خارج می شود.

بعد از تخمک گذاری تغییرات مشخصی در فولیکول صورت می گیرد. ابتدا در فولیکول خونریزی کمی ایجاد می شود که به تشکیل لخته می انجامد. سپس یاخته های مفروش کنند فولیکول تکثیر می شوند و یک توده یاخته ای به نام جسم زرد به وجود می آورند. جسم زرد مسئول ترشح هورمونهای استروژن و پروژسترون است فعالیت جسم زرد در صورتی که تخم در رحم مستقر شود تا 3 ماه ادامه می یابد و پس از آن جفت با ترشحات هورمونی خود جایگزین جسم زرد می شود و جسم زرد به تدریج تحلیل می رود. در صورتی که حاملگی ایجاد نشود جسم زرد ۸ تا ۱۰ روز پس از تخمک گذاری شروع به تخریب می کند. همراه با تخریب جسم زرد مقدار ترشح هورمونهای پروژسترون و استروژن تدریجا کاهش می یابد و در نتیج آندومتر تغییر می کند و قاعدگی آغاز می شود. همراه با کاهش ترشح هورمونهای جسم زرد از وقفه ای آنها نیز بر هیپوفیز کاهش می یابد و این امر موجب ترشح مجدد FSH از هیپوفیز می شود که رشد و نمو فولیکولهای جوان را تأمین می کند

در ۵ روز اول شروع قاعدگی، هیپوفیز شروع به ترشح FSH میکند که از طریق جریان خون به تخمدانها می رسد و موجب رشد و نمو چند فولیکول می شود ولی معمولا فقط یکی از این فولیکولها در حدود روز چهاردهم قاعدگی به بلوغ کامل می رسد و تخمک گذاری را انجام می دهد.

لازم به یادآوری است که در محل جسم زرد قدیمی، جای زخم التیام یافته سفید رنگی باقی می ماند که آن را جسم سفید مینامند.

قاعدگی

قاعدگی عبارت است از خونریزی فیزیولوژیک دوره ای رحم که معمولا هر ۴ هفته یک بار طی دوران استعداد باروری زنان و در غیاب حاملگی اتفاق می افتد. به عبارت ساده تر وقتی تخمک رها شده از تخمدان نتواند به وسیله اسپرم بارور شود، جدار رحم به علت عدم ایجاد حاملگی و مستقر نشدن تخم، متلاشی می شود و به داخل محوطه رحم می ریزد که به صورت خون قاعدگی از مجرای مهبل بیرون رانده می شود. قاعدگی از سن بلوغ شروع و تا زمان یائسگی ادامه می یابد. این دوران در حدود ۳۵ سال است.

یک دوره قاعدگی از ۲۲ تا ۳۵ روز متغیر است و طبیعی تلقی می شود ولی معمولا این دوره ۲۸ روز است، روز شروع خونریزی قاعدگی را روز اول دوره ماهانه و آخرین روز دوره ماهانه را روز قبل از شروع قاعدگی بعدی محسوب می دارند. مدت قاعدگی به طور متوسط ۵ روز و میزان خون قاعدگی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر متغیر است. هر دوره قاعدگی دارای ۳ مرحله تکثیری، ترشحی و قاعدگی است .

مرحله تکثیری: این مرحله از روز پنجم قاعدگی شروع و تا زمان تخمک گذاری ادامه می یابد. تخمک گذاری در اواسط قاعدگی با حدود روز چهاردهم قاعدگی ایجاد می شود. در این مرحله مخاط داخل رحم ضخیم و شبکه عروقی و نقدهای آندومتر که به علت قاعدگی قبلی از بین رفته است تدریجا ترمیم می شود.

مرحلة ترشحی: در طی این مرحله، میزان پروژسترون خون به تدریج بالا می رود (همزمان با آن میزان استروژن نیز به مقیاس کمتری بالا می رود) و در نتیجه آندومتر واجد شرایط لازم و کافی برای لانه گزینی تخم می شود. اگر حاملگی ایجاد نشود و تخم در رحم مستقر نشود، میزان پروژسترون مترشحه از تخمدان کاهش می یابد و در نتیجه تغییرات تخریبی در آندومتر ایجاد و قاعدگی آغاز می شود.

مرحلة قاعدگی : این دوره از روز اول خونریزی تا روز چهارم دوره ماهانه به طول می انجامد ، در مرحله قاعدگی، آندومتر قدیمی به علت عدم ایجاد حاملگی و مستقر نشدن تخم، متلاشی می شود و به داخل محوطه رحم می ریزد و سپس آندومتر جدیدی جایگزین آن می شود که تدریجا برای لانه گزینی احتمالی تخم بعدی آماده می گردد.

قاعدگی یک عمل طبیعی بدن است و آن را نباید یک بیماری با حالت غیر طبیعی دانست، ولی زندگی امروزی بشر ، از مجرای طبیعی خود خارج شده، ناراحتیها و فشارهای زندگی، این عمل طبیعی زن را به صورت مشکلی در آورده است و در نتیجه ناراحتیهای ناشی از قاعدگی، مانند قاعدگیهای دردناک، قاعدگی با فواصل زیاد و فقدان قاعدگی روز به روز زیاد. می شود.

بنابراین رعایت اصول بهداشت فردی باعث احساس بهبودی بیشتر در دوران قاعدگی خواهد بود. از این رو دختر یا بانوی قاعده باید به مقدار کافی استراحت و خواب داشته باشد. غذاهای ساده، مقوی و زود هضم بخورد. هوای تازه استنشاق کند؛ خود را از تغییرات هوابه خوبی محافظت کند. ورزشهای سبک انجام دهد و سعی کند که زندگی آرام، معقول و بدون شتاب داشته باشند

یائسگی

در اصطلاح علمی، پایان یافتن دوره امکان تولید مثل را در زنان که با از دست دادن فعالیت تخمدانها و قطع قاعدگی و بعضی تغییرات بدنی و روانی دیگر مشخص می شود، یائسگی می خوانند که معمولا در سنین ۴۰ تا ۵۰ اتفاق می افتد. معمولا قاعدگی به تدریج از بین می رود بدین طریق که ابتدا نامرتب و مقدار خونریزی کم می شود و بالاخره به کلی متوقف می گردد بعضی ها نیز ممکن است یکدفعه قطع شود. علائم مشخصی برای دوران ذکر نشده است ولی برخی از زنان در این دوره دچار پاره ای عوارض روحی و عصبی زودگذر می شوند .

فصل سوم

عوارض و ناراحتی های شایع در دوران بارداری

1.تهوع

حالت تهوع معمولا در سه ماه اول حاملگی وجود دارد. در حدود نیمی از مادران حامله دچار حالت تهوع می‌شوند. خوردن نان خشک یا بیسکوئیت حس تهوع را کم می کند . اگر مادر سعی کند که معده اش خالی نباشد ، حالت تهوع کمتر خواهد بود مادر هرگز نباید خود را تحریک به استفراغ کند.

بعضی از مادران هر روز مختصری استفراغ می‌کنند ولی این حالت خود به خود از بین می رود. اگر استفراغ مادر ادامه پیدا کرد و مخصوصا اگر در نتیجه استفراغ وزن مادر کم شد، باید از پزشک کمک گرفت.

۲- سوزش معده و احساس ترش کردن

ترش کردن حالتی است که شخص در قسمت بالای معده و مری احساس سوزش می کند که ممکن است همراه با آروغ زدن باشد. این احساس سوزش هیچ رابطه ای با قلب ندارد در اثر تنبلی در فعالیت معده و روده و پس زدن شیره معده به داخل مری حاصل می شود در اصل حالت خفیفی از سوء هاضمه است. اولین قدم برای برطرف کردن این حالت دقت در رژیم غذایی و حذف غذاهای چرب و دیرهضم است. در ضمن باید از تندخوری و پرخوری نیز اجتناب شود

بعضی از بانوان آدامس میجوند و خوب می شوند و گاهی با خوردن یک قاشق مربا بعد از غذا ناراحتیشان برطرف می شود. در صورت ادامه این حالت و بروز ناراحتیهای بیشتر بایستی به پزشک مراجعه شود.

۳- نفخ شکم

انبساط روده و معده در اثر تجمع گاز در آنها نفخ نامیده می شود. نفخ ممکن است به تنهایی یا همراه با ترش کردن رخ دهد. علت نفخ این است که چون بزرگی زهدان و فشار آن مانع حرکت طبیعی محتویات روده با سرعت معمولی است، لذا باکتریهای روده فعالیت زیاد و غیر عادی و ایجاد نفخ می کنند.

رژیم غذایی مناسب و پرهیز از غذاها و سبزیجاتی که پرحجم و نفخ أور هستند مانند کلم، خیار، بادمجان، گوجه فرنگی، کلم پیچ، حبوبات و پیاز، درمان نفخ شکم در دوران بارداری است. این ناراحتی همچنین توسط داروهایی که عمل هضم و جذب غذا را تسریع میکند برطرف می شود.

۴- ویار حاملگی

یک میل هوسانه است که نسبت به بعضی از مواد و غذاها پیدا می شود. اگرچه این حالت را بعضی از زنان غیر آبستن نیز دارند ولی به طور مسلم و بار مخصوص حاملگی است. حالت ویار نه تنها نسبت به مواد غذایی عادی بلکه گاهی به مواد دیگری که جزو غذاها نیستند و برای بدن نیز مضرند پیدا می شود، مانند گچ دیوار، خاک روی زمین و زغال، ترشیجات و غذاهای ترش جمله موادی هستند که زنان باردار میل و رغبت زیادی به خوردن آنها نشان می دهند.

۵_ کمخوابی و بی خوابی

اگر چه اوایل حاملگی معمولا با خواب راحت و زیاد توأم است، ولی هفته های آخر آن اغلب همراه با کم خوابی و یا بی خوابی است. عوامل متعددی از جمله حرکات بچه در داخل شکم، تنگی نفس، گرفتن عضلات و فکر زایمان موجب این ناراحتی می شوند. برای برطرف کردن آن، اجتناب از پرخوری و نوشیدن مایعات زیاد، قدم زدن در هوای آزاد قبل از خواب و حمام کردن مفید است

تعداد معدودی از زنان حامله ممکن است در هفته های آخر دورة حاملگی مجبور به استفاده از داروهای مسکن خواب آور شوند که مصرف این گونه داروها حتما بایستی تحت نظر پزشک معالج باشد

۶- یبوست

یکی از عوارض بسیار شایع دوران بارداری یبوست است و علت آن بیشتر مربوط به کند شدن حرکات روده در اثر فشار رحم بر روی دستگاه گوارش است. اگر مادر حامله قبلا هم دچار ناراحتی گوارشی و یبوست بوده است، در دوران حاملگی یبوست او زیادتر خواهد شد. زیرا مادر در دوران حاملگی کمتر راه می رود و بیشتر استراحت می کند، عضلات صاف بدن فعالیت کمتری دارند و جنین که در حال رشد است به روده فشار می آورد. در صورتی که یبوست مادر ادامه پیدا کند ممکن است منجر به پیدایش بواسیر شود. اگر مادر حامله دچار یبوست شد نباید داروهای ملین مانند روغن کرچک و مسهلهای نمکی و شیاف مصرف کند بلکه باید مایعاتی مانند آب میوه به مقدار زیاد بنوشد، میوه ها و سبزیجاتی که مواد زاید و جذب نشدنی دارند مصرف کند، به تمرین و ورزش بپردازد و متحرک باشد. مادر باید سعی کند عادت همیشگی اجابت مزاج خود را انجام دهد ولی هیچ گاه نباید برای دفع مدفوع به خود فشار بیاورد.

۷- واریس پاها

واریس نتیجه اتساع وریدهای سطحی (عروقی خونی که خون بدون اکسیژن را به قلب می رساند) ران و ساق پاست و اکثرا نتیجه اضافه وزن پیدا کردن در دوران حاملگی است. درد و ناراحتی ناشی از واریس را می توان با بالا نگه داشتن پا و ساق و ران کم کرد. مادر باید پاهای خود را روی صندلی یا عسلی یا چند عدد بالش قرار دهد، پوشیدن جورابهای مخصوص واریس نیز کمک می کند.

۸_ انقباض عضلات پا

انقباض ناگهانی عضلات ساق پا ممکن است در دوران حاملگی اتفاق افتد. این انقباض و گرفتگی عضلات پا ممکن است در نتیجه کم شدن جریان خون در پاها یا کم بودن کلسیم و علل ناشناخته دیگر باشد. بانوی حامله باید هر روز مواد غذایی سرشار از کلسیم مانند شیر مصرف کند و یا قرصهای کلسیم بخورد مالش دادن عضلات پا نیز انقباض عضلات را متوقف می کند. اگر مادر به هنگامی که در حال استراحت است، پاهای خود را بالا نگه دارد، این انقباضات کمتر خواهد شد

۹_ورم دست و پا

تورم مختصر در ناحیه قوزک پا و یا ساق پا، نزد اغلب زنان باردار تاحدی طبیعی است و بعد از زایمان برطرف می شود ولی اگر ورم زیادتر شده و قسمتهای دیگر مانند دست و پا صورت را فرا گیرد بایستی درصدد درمان آن برآمد. بسیاری از مادران بدون این که متوجه تورم قسمتهای مختلف بدن خود شوند، گاهی از این که کفش پایشان تنگ شده و یا این که انگشتر به دستشان نمی رود به طبیب خود مراجعه می کنند. علت عمده ورم ساق و قوزک پا، زیاد شدن فشار خون وریدی است که گاهی در اثر ایستادن مداوم روی پاها ولی بیشتر به علت فشار رحم روی وریدهای لگن ایجاد می شود، البته جمع شدن زیاده از حد نمک در بلمان نیز عامل مهم دیگری در پیدایش ورم است

تورم مختصر قوزک پا احتیاج به درمان خاصی ندارد و خود به خود با استراحت و رزیم غذایی مناسب از بین می رود ولی چنانچه میزان تورم زیاد و مخصوصا دستها و صورت را فرا گرفته باشد باید تحت نظر پزشک متخصص دقیقا معاینه و مداوا شود، مسلما رژیم غذایی کم نمک در برطرف کردن ورم پا، رل بسیار مهمی بازی می کند. تورم زیاد بدن، همراه با فشارخون بالا و آلبومین در ادرار از علایم مسمومیت بارداری هستند و مادرانی که مبتلا می شوند باید شدیدا مراقبت شوند و تحت درمان کامل قرار گیرند

۱۰- بواسیر

بواسیر در اثر بزرگ و گشاد شدن سیاهرگهای اطراف مقعد ایجاد می شود. در طول حاملگی، نه علت رشد رحم، از جریان خون سیاهرگی در ناحیه راست روده کاسته می شود. بدین طریق میزان برگشت خون ناحیه راست روده به قلب کاهش می یابد و زمینه مساعدی برای تولید بواسیر به وجود می آید. ناگفته نماند که حاملگی به تنهایی نمی تواند موجب بواسیر شود، مگر اینکه همراه با یبوست باشد. زیرا مدفوع سفت و زور زدن در هنگام دفع مدفوع دو عامل اساسی ایجاد بواسیر است. تحت چنین شرایطی سیاهرگها بزرگ، متسع و دردناک و اغلب موج خارش و خونریزی خفیف در اطراف مقعد می شود.

بنابراین اولین اقدام برای درمان بواسیر برطرف کردن یبوست است. استفاده از حوله گرم در اطراف مقعد نیز در رفع موقت این ناراحتی بی تأثیر نیست. اگر بواسیر زیاد و یا با خونریزی توأم باشد برای درمان قطعی مراجعه به پزشک الزامی است.

۱۱- تنگی نفس و ناراحتیهای تنفسی

بر اثر فشاری که رحم بزرگ شده به ششها وارد می کند، در دو ماه آخر دورة حاملگی، تنگی نفس امری عادی است. برای درمان تنگی نفس، اگر خفیف باشد، مادر حامله در حالی که روی تختخواب دراز کشیده است می تواند با قرار دادن تعدادی بالش در پشت خود به نحوی که سر و شانه بالاتر قرار گیرند استراحت کند. بهتر است پنجره های اتاق، مخصوصا در فصل تابستان باز نگه داشته شوند تا هوای تازه در اتاق جریان داشته باشد. در غیر این صورت هوای اتاق چندین بار در روز باید تهویه شود.

اگرچه تنگی نفس در اواخر دوره حاملگی کاملا طبیعی است، ولی اگر شدت آن به حدی باشد که در موقع حرکت و بالا رفتن از پله باعث ناراحتی شود مسئله را باید با پزشک در میان گذاشت. زیرا تنگی نفس ممکن است علاوه بر فشار رحمی، به علت امراض قلبی و یا ریوی باشد و در این صورت مادران بایستی به طور دقیق معاینه شوند و تحت درمان قرار گیرند.

معمولا یک یا دو هفته قبل از زایمان به علت پایین آمدن سر بچه به داخل ناحیه لگن، از شدت تنگی نفس کاسته می شود.

۱۲- ترشحات خونی و لکه بینی

وقتی زن حامله می شود، قاعدگی قطع و وجود هرگونه لکه بینی یا خونریزی غیر طبیعی تلقی می شود. یکی از علل شایع لکه بینی و خونریزی در سه ماهه اول حاملگی، سقط جنین و علایم تهدید به سقط است، به خصوص اگر با دردهای شکمی همراه باشد

در نیمه دوم حاملگی، لکه بینی و خونریزی رحمی ممکن است مربوط به سقط شدن جنین، بچه خوره، ضعیف شدن و نارسایی جفت، جدا شدن جفت و یا جفت سرراهی باشد در صورت لکه بینی و یا خونریزی، باید از انجام کارهای سنگین و حرکت زیاد خودداری و در اولین فرصت به پزشک مراجعه شود. همچنین در صورت وجود ترشحات غیر طبیعی زنانه مانند زیاد شدن میزان ترشحات، متعفن و بدبو شدن، تغییر کردن رنگ آن و ایجاد خارش در نواحی فرج و قسمت بالای ران، مراجعه به پزشک توصیه می شود.

۱۳- پارگی پوست شکم

در پوست ناحیه شکم بسیاری از زنان باردار خطوط قرمز رنگی ظاهر می شود که بعد از زایمان به سفید مایل به نقره ای در می آید. این خطوط نشانه پاره شدن پوست است که معمولا از نیمه دوم بارداری شروع به ظاهر شدن می کنند و ماههای آخر زیادتر می شوند راجع به علت پارگی پوست شکم، پزشکان عقاید مختلف دارند، برخی از پزشکان عقیده دارند که دلیل پاره شدن گسترش زیاده از حد پوست ناحیه شکم به علت فشار رحم است و برخی دیگر کمی ویتامین را عامل اصلی می دانند آنچه مسلم است این که، پارگی پوست علت واضحی ندارد ولی شاید آنهایی که پوست بدنشان شل است و یا زمینه به خصوصی دارند بیشتر مبتلا می شوند.

وقتی پوست پارگی پیدا کرد دیگر از بین نمی رود، ولی برای پیشگیری، به تجربه ثابت شده است که ماساژ روزانه یا یک روز در میان ناحیه شکم در ماههای اول بارداری با پمادهای ویتامینه و هورمون دار تا حد زیادی از پیدایش پارگی شکم جلوگیری می کند.

۱۴- خارش پوست بدن

گروه نسبتا زیادی از مادران در موقع حاملگی از خارش پوست بدن در نواحی مختلف شکایت میکنند. خارش در ناحیه پوست شکم و دست و پا بیشتر از سایر نقاط است که علت آن ممکن است مربوط به حساسیت بدن به حاملگی باشد. در مواردی که خارش قسمت عمده و با تمام پوست بدن را فرا می گیرد باید به فکر حساسیت بدن نسبت به یک ماده خارجی بود. گاهی ترشحات زنانگی به علت عفونت میکروبی با قارچی زیاد می شود، پوست اطراف فرج و قسمتهای بالای ران تحریک یا قرمز می شود و بعد در همین ناحیه خارش به وجود می آید.

برای تسکین خارشهای معتدل و ملایم پوست، گرفتن دوش مفید و پاشیدن پودر به نواحی خارش دار گامی مؤثر است. در مواقع آلرژی، از خوردن خوردنیهایی که حساسیت ایجاد می کنند مانند تخم مرغ، ماهی، توت فرنگی، گوجه فرنگی و همچنین ادویه جات باید پرهیز کرد اگر خارش پوست بدن زیاد و وسیع باشد و در برابر درمانهای معمولی مقاومت کند، بهتر است به پزشک متخصص پوست مراجعه شود.

۱۵- تکرر ادرار

فشار رحم بر مثانه سبب می شود که در ماههای اول دوران حاملگی تعداد دفعات دفع ادرار زیاد شود و یا مادر فقط حس دفع ادرار داشته باشد، موقعی که رحم تغییر وضع داد. فشار رحم مادر از بین می رود و ممکن است در آخر دوران حاملگی موقعی که جنین در پایین لگن مادر قرار گرفت دوباره ظاهر شود. علت دیگر تکرر ادرار این است که کار کلیه در دوران حاملگی افزایش می یابد ." اگر مادر حامله مقدار نوشیدن مایعات را مخصوصا بعدازظهرها کم کند تعداد دفعاتی که لازم است برای ادرار کردن در شب بیدار شود، کم خواهد شد. اگر تکرر ادرار مادر توأم با سوزش و علامت دیگری است باید با پزشک متخصص خود مشورت کند

علاوه بر مشکلات فوق الذکر، با در نظر گرفتن تغییرات فیزیولوژیکی که در مادران حامله به وجود می آید می توان حدس زد که تغییرات عاطفی و هیجانی نیز در آنان نادر نیست. تغییر خلق، افسردگی موقت، گریه های خود به خود، تحریک پذیری روانی و خستگی فکری و بدنی از جمله مواردی هستند که در دوران بارداری شایع است. بسیاری از این تغییرات بدنی و روانی را می توان برای مادران حاملة توضیح داد و آنان را نسبت به این مسائل آگاه ساخت تا با اطلاع کافی از مسائل و مشکلات دوران بارداری و شناخت راههای پیشگیری از بروز عوارض احتمالی دوران بارداری را به سلامت سپری سازند.

علایم مهم و خطرناک دوران بارداری

زنان حامله ممکن است به طور ناگهانی و یا به تدریج مبتلا به علایمی شوند که سهل انگاری و بی توجهی به آن موجب مخاطراتی برای مادر یا جنین یا هر دو باشد. در چنین مواردی باید هرچه زودتر پزشک متخصص زنان را از وقوع چنین علایمی مطلع کرد. این علایم عبارتند از:

۱- خونریزی یا خروج مایع آمنیوتیک (مایعی که جنین در آن شناور است) از واژن ۲- سردرد، تار شدن ناگهانی دید و پیدایش سرگیجه ۳- خیز و ورم صورت یا دست و پا ۴- درد شکم توأم با تهوع و استفراغ یا بدون آنها ۵- پیدایش تب و لرز

هیچ مادری نباید در مقابل علایم و مسائل ذکر شده در بالا سهل انگاری کند و با توصیه و تجویز مردم به درمان خانگی وستی بپردازد. پزشک متخصص زنان و زایمان است که مقابل علایم فوری و غیر فوری بیمار خود، مراقبت و نظارت و در صورت لزوم به درمان اقدام کند

فصل چهارم

تأثیر عوامل مختلف بر رشد جنین

زندگی جنین از هنگام تشکیل تخم تا تولد، مرحله بسیار حساسی از زندگی انسان را به خود اختصاص می دهد زیرا در این مرحله جنین نسبت به عوامل مختلف بسیار حساس و آسیب پذیر است و به همین جهت بسیاری از ناهنجاریها و همچنین بیماریهای کودک، پس از تولد منشا جنینی دارد.

با توجه به اینکه آگاهی از اثرات سوء عوامل مختلف بر رشد و نمو جنین به منظور پیشگیری و درمان به موقع اهمیت فوق العاده ای دارد، لذا در این فصل اهم این عوامل سوء، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

هدف کلی آشنایی با تأثیر عوامل مختلف بر رشد جنین هدفهای رفتاری از شما انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتوانید:

- اثرات سوء بیماریها، داروها، پرتوها، مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر را بر جنین شرح دهید.

- رابطه سن مادر با رشد و تکامل جنین را بیان کنید. - تأثیرات مثبت تغذیه مناسب و کافی بر رشد جنین را توضیح دهید. - تأثیرات وضع روحی و عاطفی مادر را بر جنین بیان کنید.

۱- بیماریهای عفونی مادر مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که بسیاری از بیماریهای مادر در دوران بارداری، جنین او را تحت تأثیر قرار می دهد و برحسب اینکه جنین در چه مرحله ای از رشد و تکامل باشد،

ضایعات و اختلالات کوتاه یا بلند مدت پدید می آورد. مادرانی که در دوران بارداری به ای مخملک، آنفلوانزا، آبله، آبله مرغان، سل و مالاریا مبتلا می شوند سقط جنین می کنند نوزادان آنها اختلالات جسمانی، عصبی یا قلبی پیدا می کنند. در مواردی نیز دیده شده که نوزادان در هنگام تولد به این بیماریها مبتلا بوده اند. از جمله بیماریهای مسری که در دوران بارداری تان سوء بر جنین دارند و ضایعاتی به بار می آورند می توان به سرخجه، سیفیلیس و سوزاک توکسوپلاسموسیس و سیتومگالو ویروس اشاره کرد.

۲- بیماریهای غیر عفونی مادر بسیاری از بیماریهای غیر عفونی مادر، از جمله فشارخون، دیابت و کم خونی، در صورتی که کنترل و درمان نشوند ممکن است موجب بیماریها و ناهنجاریهایی در جنین شود. طبق بررسیهای انجام شده، مادرانی که فشارخون آنها بالاتر از حد طبیعی است، در مقایسه با مادرانی که این عارضه را ندارند، بیشتر سقط جنین کرده یا نوزادان مرده به دنیا آورده اند. همچنین مادرانی که به بیماری دیابت (

قند)

مبتلا هستند، در مقایسه با مادران سالم، به نسبت بیشتری جنین مرده به دنیا می آورند و چنانچه نوزادان بعد از تولد به حیات خود ادامه دهند، معمولا اختلالاتی در دستگاه گردش خون و تنفسی آنها دیده می شود. ضمنا مادرانی که به کم خونی مبتلا می باشند قادر نیستند اکسیژن کافی به جنین برسانند که این کمبود در رشد جسمانی و عصبی کودک و به ویژه مغز او تأثیر می گذارد و معمولا باعث ضایعات مغزی می شود.

این مواد باشد، مسلما نمی تواند احتیاجات جنین خود را با ...

۳- تغذیه جنین مانند هر موجود زنده ای برای رشد و نمو خود احتیاج به مواد غذایی، و یا . غیره دارد که این احتیاجات توسط مادر و از طریق جفت تأمین می شود بنایا. مادر دچار کمبودهایی در این مواد باشد، مسلما نمی تواند احتیاجات جن در نتیجه مشکلاتی برای جنین پیش می آورد.

مطالعات انجام شده در زمینه اثرات تغذیه بر جنین حاکی از آن اس دوران بارداری دچار کمبود شدید مواد پروتئینی، قندی، چربیها، ویتامینها مقایسه با مادرانی که تغذیه کامل و کافی داشته اند بیشتر با سقط جنین در نارس و بالاخره تولد نوزادانی با وزن کم و با اختلالات جسمانی، عه بوده اند. بنابراین تغذیه مادر در دوران بارداری بسیار با اهمیت است و با کافی باشد تا او دچار کمبودی نشود.

در چنین حاکی از آن است که مادرانی که در و قندی، چربیها، ویتامینها و املاح بوده اند، در

شتر با سقط جنین، تولد نوزادان مرده و یا دلالات جسمانی، عصبی و مغزی مواجه

اهمیت است و باید از نظر کیفی و کمی کافی باشد تا او دچار کمبودی نشود

۴- داروها

مواد دارویی شمشیرهای دولبه ای هستند که یک لبه آن زندگی بهتر و سالمتر انسان را تسهیل و لبه دیگر سلامت او را تخریب می کند. بی تردید جنین که خود کمترین اختیاری در مصرف یا مصرف نکردن آن ندارد، ممکن است بیشترین آسیب را از لبه عارضه زای آن ببیند. بنابراین دستور کلی این است که در دوران بارداری، به خصوص در

هفته ها و ماههای اول، مادر باید از مصرف هرگونه دارویی بدون تجویز پزشک خودداری کند و در صورتی که قبلا به علت بیماری خاصی، دارویی را به طور مداوم مصرف می کرده است باید حتما با پزشک خود مشورت کند و مقدار دارو برحسب شرایط خاص دوران بارداری و با توجه به وضعیت جنین و ضرورت مصرف دارو تجویز شود.

۵- عامل Rh و ناسازگاری خون مادر و جنین

پروتئینی است که به طور ژنتیک در خون نوعی میمون به نام رزوس وجود دارد و به همین جهت آن Rhکه مخفف حرف اول میمون است می نامند. افرادی که دارای Rh (Rh مثبت) هستند، در گلبولهای قرمز خون ماده ای دارند که در برابر سرم خاصی باعث انعقاد خون می شود. برعکس افرادی که دارای عامل Rh منفی هستند این ماده را در خون خود ندارند. بنابراین برای افرادی که خونشان دارای Rh است، اصطلاح Rh امنیت و کسانی که خونشان فاقد عامل Rh است، اصطلاح Rh منفی به کار برده می شود.

اختلال و ناراحتی هنگامی بوجود می آید که زن دارای Rh منفی، از مردی که Rh مثبت دارد باردار شود. در صورتی که جنین دارای Rh مثبت باشد، در ماههای اول بارداری مقداری آنتی ژن به وسیله جفت از جنین به مادر منتقل می شود. برای مقابله با آنتی ژنی که وارد بدن مادر می شود، مادر در برابر وجود عامل خارجی، پادزهر و یا ماده ای به نام آنتی کور ترشح می کند که از

طریق جفت وارد بدن جنین می شود و با چسبیدن به گلبولهای قرمز او باعث بی ثباتی و از بین رفتن آنها می شود. با در نظر گرفتن اینکه نقش گلبولهای قرمز خون انتقال اکسیژن است، از بین رفتن آنها باعث می شود که اکسیژن به طور طبیعی و به مقدار کافی به جنین نرسد.

عواقبی که این ناسازگاری و یا نارسایی به وجود می آورد، معمولا باعث سقط جنین تولد جنین مرده و یا مرگ اندکی بعد از تولد است. در صورتی که جنین به حیات خود ادامه دهد معمولا دچار فلج یا عقب افتادگی ذهنی می شود.

خوشبختانه به علت اینکه مدتی طول می کشد تا Rh مثبت جنین، خون مادر را تحت تاثیر قرار دهد، نوزادان اول معمولا طبیعی و بدون ضایعات و اختلالات ذکر شده متولد

می شوند ولی این اختلالات و ضایعات اغلب در بارداریهای بعدی دیده می شود، مگر آنکه با وسایل و امکاناتی که فراهم است، از بروز آنها جلوگیری شود.

گاهی علاوه بر عامل Rh ناسازگار بودن خون مادر و جنین نیز باعث ایجاد اختلال می شود. این ناسازگاری تقریبا در حالتی اتفاق می افتد که گروه خون جنین A یا B و گروه خون مادر O باشد. به بیان دیگر این اختلال هنگامی رخ می دهد که گلبولهای قرمز جنین دارای آنتی ژن A و یا B باشد و در عین حال در پلاسمای خون مادر، آنتی کور ضد A و یا B وجود داشته باشد. هرگاه آنتی ژنهای A و یا B جنین به مادر منتقل شود، بدن مادر آنها را به عنوان جسم خارجی می نگرد و آنتی کورهای ضد A و یا ضد B را ترشح می کند که این آنتی کورها از راه جفت به جنین | می رسند و در ترکیب با آنتی ژنهای موجود در پوسته گلبولهای قرمز جنین، آنها را همولیز میکنند و در نتیجه بسیاری از نوزادان به علت از بین رفتن گلبولهای قرمز خون، با زردی و یرقان | به دنیا می آیند.

۶- پرتوهای رادیواکتیو

در صورتی که جنین به خصوص در ماههای اول بارداری در معرض پرتوهایی چون اشعهٔ X قرار گیرد، ممکن است دچار اختلالات و ناهنجاریهایی از قبیل ضایعات جسمانی و اختلالات دستگاه اعصاب شود و به همین جهت مادر باردار باید از محلی که در آن پرتوهای رادیواکتیو وجود دارد، نظیر کارکردن در بخش رادیولوژی، اجتناب ورزد. بررسیهای رادیولوژیکی در زنان باردار باید در حداقل زمان انجام گیرد و در صورتی که قرار باشد از قسمتهایی از بدن مانند سینه، رادیوگرافی شود، باید یک پوشش سربی روی شکم و لگن وی گذاشته شود. بهتر است تا آنجا که امکان دارد، برای فرآیندهای تشخیصی از شیوه های فراصوتی به جای پرتو X استفاده شود.

۷- مشروبات الکلی و سیگار برخی از دانشمندان معتقدند چهل هفته زیستن در رحم مادر که هر فردی آن را طی می کند، درست به اندازه تمام مدت عمری که بعدا بر او می گذرد، می تواند سلامت ساز یا مخاطره انگیز باشد. لذا هرگونه بی احتیاطی از طرف مادر، از جمله اعتیاد به الکل و مصرف بیش از حد سیگار، می تواند مشکلاتی دیرپا و دایمی برای جنین وی فراهم کند.

براساس مطالعات انجام شده، اعتیاد والدین به خصوص مادر به مواد الکلی ممکن است موجب عوارضی از قبیل نارسایی عقلی، ضعف عمومی و ناهنجاریهای حسی - حرکتی برای فرزند او شود که مجموعه این مشکلات زمینه سازی شده در جنین را به نام «سندرم الکلی جنین» تعریف کرده و تشخیص داده اند.

در زنان باردار معتاد به سیگار، سقط جنینهای خود به خود شایعتر بوده و رشد جنین تا

اندازه ای مختل شده است و نوزادان به هنگام تولد وزنی کمتر از معمول داشته اند. بنابراین بهتر است مادران در دوران بارداری از کشیدن سیگار خودداری کنند و در مدت که ت ا به او داد اند و قادر به ترک کامل آن نباشند تعداد سیگارهای خود را به ۲ تا ۳ نخ در روز محدود کنند. ضمنا صرف مشروبات الکلی در دوران بارداری به کلی ممنوع است و بهترین اندرز به مادران الکلی، پیشنهاد ترک دایم آن و یا حداقل در ایام حاملگی است

۸- مواد مخدر اثرات سوء مواد مخدر از قبیل هرویین، مرفین و متادون نیز بر جنین و نوزاد قابل توجه است. مطالعات متعدد نشان داده است که مادران معتاد به هرویین و مرفین معمولا نوزادان معتاد به دنیا می آورند. به علاوه مادران معتاد، در مقایسه با مادران غیر معتاد، دارای نوزادانی کم وزن و نارس تر هستند. متادون به عنوان ماده مخدری که برای جایگزینی و ترک هرویین در جامعه ما نیز مورد استفاده قرار می گیرد، در بسیاری از موارد منجر به اعتیاد نوزاد شده است. شدت اعتیاد نوزاد غالبا بستگی به این دارد که مادر چه مقدار و برای چه مدت مواد مخدر استفاده می کرده است. مواردی که مادران قبل از بارداری ترک اعتیاد کرده اند، نوزادان آنها سالم به دنیا آمده و معتاد نبوده اند. براساس تحقیقات انجام شده، مصرف L. S. D ایجاد ناهنجاریهایی در اندام پایینی جنین می کند که میزان وفور آن در جنین مادران معتاد، چندین برابر بیشتر گزارش شده است. بدین جهت به مادران معتاد به مواد مخدر، ترک اعتیاد قبل از باردار شدن را جدا توصیه میکنیم و آنان را نسبت به تولد نوزاد معتاد و با عوارضی از قبیل ناهنجاریهای مادرزادی، نارس بودن و داشتن وزن کمتر از حد معمول، در صورت ادامه اعتیاد، هشدار می دهیم.

۹- سن مادر رشد و تکامل نوزاد با سن مادر و تعداد بارداریهای او رابطه دارد. به طورکلی درصد مرگ نوزادان در صورتی که مادران کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۳۵ سال داشته باشند، بیشتر است. مادرانی که اولین کودک خود را بعد از سن ۳۵ سالگی به دنیا آورده اند در مقایسه با مادران جوانتر، معمولا مشکلات بیشتری در دوران بارداری و در هنگام زایمان داشته و به علاوه نوزادان ناقص و غیر طبیعی بیشتری به دنیا آورده اند.

۱۰- عوامل در حال زایمان در زایمانهای مشکل و به ویژه در زایمانهای نوع بریچ که ابتدا کفل و سپس سر خارج می شود و همچنین در زایمانهایی که مدت درد زایمان بسیار طولانی می شود، امکان ایجاد صدمه های عصبی، نقصهای عضوی و عقب افتادگیهای ذهنی به دلیل فشار زیاد، خونریزی مغزی و همچنین

کمبود اکسیژن در مغز نوزاد، افزایش می یابد. ضمن عوامل دیگری از قبیل زایمان زودرس کم وزن بودن و گاهی وزن سنگین نوزاد در حال زایمان نیز عواقب و نارساییهایی در رشد کودکان به وجود می آورند.

۱۱- ضربه و عوامل مکانیکی ضربه های وارد شده به شکم مادر ممکن است موجب آسیبهایی در جنین و احیانا سقط جنین شود. بنابراین مادران حامله باید در دوران بارداری از ورزشهای سنگین خودداری و از بروز زد و خورد و تصادفات احتمالی، حتی المقدور پیشگیری کنند.

۱۲- وضع روحی و عاطفی مادر

حالات مختلف عاطفی مادر مانند عصبانیت شدید، ترس، نگرانی و اضطراب ممکن است دستگاه عصبی وی را تحت تأثیر قرار دهد که براثر آن، مواد شیمیایی گوناگون به وسیله غدد مختلف ترشح و وارد خون مادر می شود و از طریق جفت، رشد و تکامل طبیعی جنین را تحت الشعاع قرار می دهد. مادرانی که در دوران بارداری اضطراب و نگرانی شدید داشته اند معمولا در این دوران استفراغ شدید دارند و غالبا مدت درد زایمانشان طولانیتر از مادرانی است که اضطراب نداشته اند. همچنین تعداد بیشتری نوزادان نارس به دنیا آورده اند که این نوزادان غالبا ویژگیهایی چو ن، تغذیه نامنظم، نفخ و دل دردهای شدید، بی خوابی شبانه، گریه های ممتد و بالاخره نیاز مبرم به اینکه دائما در بغل گرفته شوند از خود نشان می دهند.

فصل پنجم

مخاطرات حاملگی

اغلب حاملگی ها با عوارض و اختلالات جزئی از قبیل تهوع، یبوست، واریس، تنگی نفس و غیره همراه است که اثرات سوء مهمی بر سلامت مادر و جنین برجای نمی گذارند. لیکن در برخی موارد، مادران حامله با عوارض و بیماریهایی مواجه می شوند که خاص دوران بارداری است و اگرچه در مقام مقایسه با عوارض شایع دوران بارداری بسیار اندکند معهذا برای جنین و مادر ممکن است خطرات جدی داشته باشند. در این فصل مهمترین خطراتی که در دوران بارداری سلامت مادر و جنین را تهدید می کنند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

هدف کلی آشنایی با مخاطرات حاملگی

هدفهای رفتاری از شما انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتوانید:

- سقط جنین را تعریف کنید و علل عمده آن را برشمارید. - مهمترین علایم مسمومیت حاملگی را ذکر کنید و عواقب آن را شرح دهید. - آبستنی خارج از رحم را توضیح دهید و علت آن را ذکر کنید. - انگورک را توضیح دهید، راه تشخیص و اقدامات لازم در این زمینه را بیان کنید. - زمان و علت جدا شدن زودرس جفت را بیان کنید. - علت و علایم جفت سرراهی را توضیح دهید. - ناسازگاری جنین و مادر را در رابطه با گروههای خونی و Rh شرح دهید.

۱- سقط جنین بیرون اوردن فراورده های آبستنی، پیش از آنکه جنین قابلیت زندگی در بیرون را داشته باشد،

سقط خوانده می شود. ناهنجاریهای جنینی، بیماریهای عفونی و مزمن مادر، کمبودهای هورمونی، نارسایی گلوی زهدان، ناهنجاری مادرزادی زهدان و کمبود شدید غذایی از جمله عوامل سقط خودبه خودی به شمار می روند.

۲- مسمومیت آبستنی یکی از عوارض بسیار خطرناک دوران بارداری مخصوصا در ماههای آخر، مسمومیت است. مهمترین علایم این عارضه بالا رفتن فشار خون، پیدایش آلبومین در ادرار، زیاد شدن ناگهانی وزن بدن و تورم شدید دست، پا و صورت است. علایم فوق ممکن است به تنهایی ظاهر شده و یا تواما وجود داشته باشند ولی در هر حال، پیدایش چنین علایمی برای مادر باردار به منزله هشدار جدی است و در صورت مراجعه نکردن به پزشک و درمان اساسی ممکن است عواقب وخیمی داشته باشد. علت این عارضه هنوز به طور قطع معلوم نشده است ولی احتمالا اختلال در عمل کلیه ها، کبد، قلب و عروق در پیدایش آن مؤثرند.

۳- آبستنی خارج از رحم هرگاه پرورش نطفه در جای دیگری به غیر از داخل رحم صورت گیرد، آبستنی خارج از رحم به وجود می آید (شکل 1). به عبارت دیگر در آبستنی نابجا، تخمک بارور

در ابستنی نابجا، تخمک بارور شده پیش از رسیدن به زهدان متوقف می شود و در بیرون از زهدان به رشد خود ادامه می ده

بود و در بیرون از زندان به رشد خود ادامه می دهد. در صورت تشخیص قطعی، عمل جراحی تنها راه معالجه است.

۴- انگورک در بیماری انگورک یا بچه خوره که اغلب در ۱۲ هفته اول آبستنی ایجاد می شود، تمام یا قسمتی از جفت فاسد و تبدیل به توده هایی شبیه به خوشه انگور می شود و بعد از مدتی، تمام حفره داخل رحم به وسیله این توده ها پر می شود و بدین ترتیب جنین از بین می رود. به محض تشخیص قطعی بیماری، انگورک را بایستی بیرون آورد.

۵- جدا شدن زودرس جفت این عارضه هنگامی اتفاق می افتد که جفت کاملا کاشته شده در جدار رحم، قبل از زایمان و بعد از هفته بیستم حاملگی جدا شود با نقص در سیستم عروقی جنین را عامل مؤثری در این امر می دانند. اگر جفت به طور کامل جدا شود، برای نجات جان مادر، بایستی سریعا به آبستنی خاتمه داده شود.

۶- جفت سرراهی این عارضه موقعی بروز می کند که جفت در محل طبیعی خود در زهدان قرار نگرفته باشد، بلکه قسمتی یا تمام آن در قسمت پایینی زهدان واقع شود. درمان مناسب با توجه به شدت بیماری، موقعیت مادر، جنین و سن آبستنی انجام می شود.علاوه بر موارد فوق، به عامل Rh و ناسازگاری خون مادر و جنین نیز در این زمینه می توان اشاره کرد که قبلا درباره آن بحث کردیم.

فصل ششم

مراحل مختلف زایمان

امروزه تقریباً اکثر زایمانها در بیمارستان انجام می گیرد. بیمارستانهای امروزی، به علت مجهز بودن به تسهیلات آزمایشگاهی و وسایل و دستگاههای تخصصی، سالمترین مکان برای وضع حمل می باشند.

از طرفی امروز دیگر نباید خانمی حامله شود و کودکی به دنیا آورد و از چگونگی زایمان اطلاعاتی نداشته باشد. آشنایی مادر به مراحل زایمان، موجب خودیاری مادر می شود. مادری که می داند در مراحل مختلف زایمان چه می گذرد، مسلماً با پزشک خود همکاری بیشتری دارد و زایمان وی ساده تر انجام می شود. اگر پدر هم به چگونگی و سیر زایمان آشنا شود، می تواند مادر را از نظر جسمی و روحی تقویت کند. لذا در این فصل سعی شده است تا با بیانی ساده، چگونگی و مراحل مختلف زایمان برای فراگیران عزیز توضیح داده شود.

علایم زایمان حقیقی در انتهای دوران بارداری، مادر حامله ممکن است دچار دردهایی شود و گمان کند که زایمان حقیقی شروع شده است. برای اینکه معلوم شود چه موقع زایمان حقیقی آغاز می شود باید بدانیم، زایمانن حقیقی موقعی است که:

۱-انقباضهای رحم به طور یکنواخ ، و مرتب انجام گیرد و به تدریج فاصله بین انقباضها کم شود و شدت آنها افزایش یابد. در ابتدا، مادر درد را در قسمت تحتانی پشت خود حس یکند و درد با راه رفتن افزایش می یابد. ۲- خروج غیر طبیعی خون و سوراخ شدن کیسه آب و خروج مایع از واژن نشانه دیگری از زایمان حقیقی است.

۲- اتساع گردن رحم بیش از یک سانتی متر باشد. اگر شروع زایمان حقیقی نباشد، انقباضات رحم نامنظم است و شدت پیدا نمیکند، راه رفتن دردها را کمتر میکند، ترشح مخاطی یا خون از واژن دیده نمی شود و بالاخره گردن رحم باز نشده است.

مراحل زایمان

زایمان که خارج شدن نوزاد و جفت از رحم مادر و گذشتن آنها از مجرای زایمانی است، ۳ مرحله دارد

مرحله اول: از شروع درد و باز شدن تدریجی دهانه رحم تا اتساع کامل آن.

مرحله دوم: از اتساع کامل دهانه رحم تا تولد نوزاد.

مرحله سوم: از تولد نوزاد تا خارج شدن کامل جفت و جمع شدن رحم.

اینک به شرح مختصر هر یک از مراحل فوق می پردازیم:

مرحله اول زایمان

در این مرحله شروع انقباضات رحم سبب کشیده شدن رحم و باز شدن کامل دهانه آن می شود. دهانه رحم که در تمام مدت حاملگی مسدود است، از موقعی که درد شروع می شود، به علت فشاری که کیسه آب روی آن می آورد تدریجاً باز می شود تا موقعی که کاملا متسع شود و راه برای خروج نوزاد فراهم شود. بنابراین مرحله اول زایمان مرحله باز شدن دهانه رحم تـا انـاء کامل آن است.

قطر دهانه رحم که در حالت طبیعی در حدود نیم سانتی متر است، در اتساع کامل به ده سانتی متر می رسد (میزان گشادی دهانه رحم را برحسب پهنای انگشت ذکر می کنند و اتساع کامل به ده کامل در حدود بهنای پنج انگشت است).

انقباض رحم؛ فشار سر کودک و همچنین بعضی از هورمونهایی که از تخمدان نرشح می‌شود. در شل شدن و گشاد شدن دهانهٔ رحم موّثرند. در آغاز مرحلهٔ اول دردهای زایمانی خفیف و فواصلشان زیاد است ولی تدریجاً که زایمان پیشرفت می‌کند. شدت دردها زیادتر ولی فواصل آنها کمتر می‌شود. مثلاً زائویی در ابتدا هر یک ربع تا نیم‌ساعت درد دارد که چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد. ولی بعد از چندین ساعت فاصله بین دو درد به دو تا سه دقیقه می‌رسد و هر درد به تنهایی یک تا دو دقیقه طول می‌کشد. اغلب زائوها در آخر این مرحله به علت شدت دردها ناراحت می‌شوند ولی در فواصل چون دردی ندارند به حالت عادی باز می‌گردند.

مرحلهٔ اول زایمان گاهی اوقات به علت قوی بودن دردها و باز شدن سریع دهانهٔ رحم خیلی زود پیشرفت می‌کند و از چند ساعت تجاوز نمی‌کند. ولی گاهی خیلی طولانی می‌شود به مدت مرحله اول زایمان شخص., تعدا و نوع زایمانهای قبلی ژ / طور کلی اب هر" ول زار با یت 3 – بزرگی و کر , لگن کمی و زیادی وزن نوزاد و شدت و فوا بین دردها تفاوت می‌کند.

در حاملگی اول» طول مدت مرحلهٔ اول زایمان از آغاز درد تا باز شدن کامل دهانهٔ رحم به‌طور متوسط تا ۱۲ ساعت است ولی اگر نوزاب خیلی درشت و لگ مادر تنگ و یا وضع نوزاد غیرطبیعی باشد این مدت ممکن است طولانیتر شود وبه 24 و یا گاهی 48 ساعت نیز برسد. مادراتی که قبلاً چندین بار وضع حمل کرده‌اند» مرحلهٔ اول زایمانشان کوتاه است و به طور متوسط از ۲ تا ۶ ساعت بیشتر طول نمی‌کشد.

در صورت وجود بیماریهایی که جان مادر و نوزاد را تهدید می‌کند. متخصصین زایمان می‌توانند به روشهای مختلفی چون پاره کردن کیسهٔ آب و به کار بردن داروهای اکسی تورسین؛ زایمان را جلو بیندازند.

مرحله دوم زایمان در این مرحله دهانهٔ رحم کاملاً باز شده است و سر توزاد آمادهٔ خارج شدن از مجرای زای‌مانی است. برای اینکه سر توزاد طول مجرای زایمانی را طی کند و خارج شود مدتی وقت لازم دار مجموعهٔ این مدت را مرحلهٔ دوم زایماتی می‌گویند که کوتاه تر از مرحلهٔ اول است. مرحلهٔ دوم زایمان در بین مادرانی که برای بار اول حامله شده‌اند از سه ربع تا سه ساعته طول می‌کشد لیکن این مدت نزد مادران چندزا خیلی کوتاه و سریع است. معمولاً در ابتدای این مرحله؛ کیسهٔ مایع آمنیو تیک پاره و مایع از وژن ناگهان و یا به تدریج خارج می‌شود (تا این زمان کودک در مایم آمنیوتیک غوطه ور و از همه مخاطرات محفوظ بوده است). در این موقع است که ماما یا پزشک متخصص زایمان سمی می‌کند زایمان را خاتمه دهد و اگر کیسهٔ آمنیوتیک پاره نشده باشد. آن را خود پاره می‌کند. در این مرحله است که مادر سعی می‌کند با انقباض عضلات شکم خود؛ به پایین فشار آورد و محتوی شکم خود را خارج کند. پس از آنکه سر کودک از دهانه رحم گشاد شده خارج شد | و واژن مادر را گشاد کرد، سر کودک به عضلات ناحیهٔ برینه (فاصلهٔ مابین فرج و مقعد فشار | کود می آورد و کشش این ناحیه مادر را وادار می کند که فشار دهد. در این موقع است که پزشک | قاشت متخصص زایمان برای راحتی عبورکودک و جلوگیری از پاره شدن خود به خود صورت لزوم اقدام به اپیزیوتومی (بریدن قسمتی از پرینه) میکند. سر کودک ممکن است مابین انقباضها کمی به عقب برگردد ولی با انقباضهای پی درپی ازمرحله تولد پیشرفت میکند. موقعی که سر کودک نمایان شد، انقباضهای رحم

متوالی و پی در پی می شود و زمانی می رسد که سر کودک واژن مادر را تا حد امکان متسع کرده است. در این موقع است که متخصص زایمان، سر کودک را میگیرد و به خروج آن کمک می کند.

چون استخوانهای سر کودک در موقع تولد کاملا به هم پیوسته نیست، در هنگام زایمان، سر کودک برحسب فشار وارده تغییر شکل می یابد تا با مجرای تولد تطبیق یابد و از آن عبور کند. موقعی که سر ر کاملاً خارج شد، شانه های کودک خود به خود چرخش پیدا میکند تا به راحتی خارج شود و بالاخره بقیه بدن بلافاصله خارج می شود. در مرحله تولد، انقباضهای ارادی عضلات شکم روی رحم اثر می گذارد و به زایمان کمک میکند. بنابراین، تمرینات ورزشی که مادر در دوران بارداری انجام داده است عضلات شکم را آماده برای کمک به زایمان می کند، زیرا انقباضهای عضلات رحم به تنهایی برای انجام عمل زایمان کافی نیست و فشاری که مادر به عضلات شکم خود وارد می آورد به خروج کودک از رحم کمک میکند.

اکثر کودکان بعد از تولد بلافاصله تنفس و گریه میکنند. زمانی که تنفس کودک برقرار شد، بند ناف را گره می زنند و قطع میکنند. در ۹۵ درصد زایمانها،کودک از سر، ۵/۳ درصد از ناحیه کفل و در بقیه موارد به صورتهای مختلف که ممکن است مشکلاتی در امر زایمان به وجود آورد متولد می شود.

در کشور ما متأسفانه گروه نسبتاً کثیری از مادران، از پارگی و بخیه خوردن در موقع زایمان وحشت دارند ولی این عده از درک این حقیقت غافلند که هر وقت سر نوزاد از مجرای تنگی – فشار زیاد خارج می شود، پارگی های نامرتب و متعددی که اجتناب ناپذیر هستند به وجود می آید و در صورتی که این پارگی ها را بدون بخیه خوردن به حال خود بگذارند بعد از مدتی عموت میکنند و به وضع بسیار بدی التیام می پذیرند. بانوانی که به این وضع دچار می شوند، علاوه بر این که مدتهای مدید از ترشحات عفونی و درد در موقع مقاربت شکایت دارند، بعد از گذشت چندین سال ممکن است به سقوط مثانه و مقعد که در اصطلاح علمی سیستوسل و رکتوسل نامیده می شود مبتلا شوند. کیفیت فوق اغلب نزد مادرانی که وضع حمل خود را در عمل جراحی است. تنهایی یا توسط ماماهای بی تجربه قدیمی انجام می دهند دیده می شود که تنها راه درمان ان عمل جراحی است.

زایمان با اسباب: اگر در مرحله دوم زایمان یا تولد نوزاده تأخیری رخ دهد یا مادر و کودک تحت فشار قرار گیرند و مادر چار ناتوانی شود، برای انجام تولد نوزاد از فورسپس به مرشد قاشقک کمک گرفته می شود. پزشک متخصص با دو دسته فورسیس، سر کودک را می گیرد و به سرینه، در آرامی و ملایمت آن را خارج میکند. فورسپس را موقعی به کار می برند که گردن رحم کاملا باز شده و سر کودک در پایبت لگن قرار گرفته باشد. پس از خروج - با قورسپس، بقیه بدن کودک خودبه خود خارج می شود.

گاهی پزشک متخصص برای کمک به انجام زایمان می تواند به جای فورسپس از روش وتتوز استفاده کند. در این روش با به وجود آوردن خلا، سر تـودک را به پایین می کشند. بدین ترتیب که صفحه فلزی دستگاه را از راه واژن به سرکودک قرار می دهند و چون این صفحه به دستگاه ایجاد کننده خلا اتصال دارد، در نتیجه به وجود آمدن خالا (مابین صفحه و سر کودک) صفحه به سر کودک می چسبد، سپس پزشک به آرامی سر کودکه را به پایین می کند. در محل اتصال صفحه با سرکوک در نتیجه خلا، برجستگی به وجود می آید که چند ساعت بعد از تولد از بین می رود.

مرحله سوم زایمان

جفت چند دقیقه پس از تولد نوزاد شروع به جدا شدن و خارج شدن از رحم می کند ولی خروج کامل جفت ممکن است از تیم تا یک ساعت به طول انجامد، جدا شدن جفت از دیواره رحم به طور خودبه خود انجام می گیرد ولی خروج آن از رحم باید به کسک انقباضات رحم و عضلات شکم (مانند خروج نوزاد) انجام گیرد. همچنین پزشک و پرستار مسکن است با کمک فشار دست خود به خروج جفت کمک کنند. انقباض رحم نه فقط کمک به خروج جفت می کند بلکه موجب جلوگیری از خونریزی از محل جدا شدن جفت از رحم نیز می شود. معمولاً در یک زایمان طبیعی مقدار ۲۰۰ تا ۳۰۰ سانتی متر مکعب خون از مادر دفع می شود برای انقباض رحم و خروج جفت معمولاً در خلال زایمان و یا بلافاصه بعد از زایمان، ماده منقبض کننده رحم موسوم به کسی توسین به مادر تزریق می کنند. پس از خروج

جفت رحم شکل طبیعی خود را به دست می آورد و به طرف بالا در معتل اصلی خود کشیده می شود. پس از خارج شدن جفت، در صورتی که اپیزیوتومی انجام گرفته باشد، پزشک بریدگی و پارگی را بخیه می زند و ترمیه میکند. لازم به یادآوری است در برخی از کشورها از داروهای ضد درد و بیهوش کننده مخصوص برای زایمانهای بی درد استفاده می شود. هنگامی که این مواد الر خود را ظاهر می سازند انقباضات رحم تقریباً از بین رفته است و دیگر فشار و یا زوری از طرف مادر برای خارج ساختن نوزاد وجود ندارد. در چنین مواقعی برای اینکه وضع حمل انجام گیرد، معمولا نوزاد را با اسباب یا با اپی زیوتومی خارج میکنند.

گاهی به دلایلی چون بزرگ بودن زیاده از حد کودک، کوچک بودن لگن مادر، به قرار گرفتن سی عمل سزارین را ممکن است بعد از مراحل شروع زایمان با بلافاصله قبل از ایمان نده سزارین جنین، جلو افتادن بندناف، مسمومیت آبستنی، تهدید به خونریزی و مرگ نوزاد، ایمان از و طبیعی میسر نیست و ناگزیر با شکاف دادن و باز کردن جدار شکم و رحم مادر، اقدام به خارج ساختن نوزاد از شکم میکنند که به این عمل در اصطلاح پزشکی سزار این گفته می شود داد. چون سزارین یک عمل جراحی است، بنابراین زمانی که لازم است تا مادر بهبود یابد طولانیتر از زمان یک زایمان طبیعی خواهد بود.

تعداد دفعاتی که مادر می تواند با عمل سزارین وضع حمل کند بستگی به وضعیت مزام و نوع عملی که انجام شده دارد ولی اصولا زنان باردار پیش از ۴ بار نباید سزارین شوند، زیر جدار عضله در اثر بخیه های متعدد جراحی ضعیف می شود و در موقع شروع درد یا در جریان زایمان که زن زور زیاد می زند ممکن است پاره شود و خطرات جیران نا پذیری برای مادر و نوزاد ایجاد کند.

لازم به یادآوری است که امکان زایمان طبیعی بعد از عمل سزارین وجود دارد، مشروع بر اینکه عمل سزارین قبلاً به علت تنگی لگن مادر انجام نگرفته باشد. چون تنگی و کوچکی لگن مادر در آبستنیهای متعدد تغییر نمی کند. بنابرای در زایمانهای بعدی به علت خود همان عامل، باز هم عمل سزارین با پستی انجام گیرد. در سایر موارد چنانچه عوارض و ناراحتیهای زایمان قبل که منجر به سزارین شده است ! بین رفته باشد، زایمان طبیعی بعد از عمل سرد امکان پذیر خواهد بود.

چند قلوزایی در بعضی از موارد نادر، بیش از یک سلول ماده در موقع مقتضی به عرصه می رسد از سلولهای تر قبلا در انتظار آنها باشند، هر یک از سلولهای ماده با یک سلول تر لقاح خواهد کرد به این ترتیب، اگر دو سلول ماده لقاح شود، یک دو قلو به دنیا می آید. چنانچه سه سلول ماده لقاح شود سه قلو به دنیا خواهد آمد و برا این قیاس تعداد چند قلوها افزایش خواهد یافت در اینگونه چندقلوزایی که به چند قلوهای عادی معروفند، هر یک از نوزادان به طرزی خاص خصوصیاتی از والدین خود به ارث می برند و بیش از برادران و خواهران معمولی که جدا از یکدیگر زاده شده اند به یکدیگر شباهت ندارند. حال چنانچه منشأ چند قلوزایی از یک سلول ماده باشد که یک سلول نر آن را بارور کرده است،چند قلوها از یک جنس اند و شباهت ظاهری آنها بسیار زیاد خواهد بود. در این نوع چند قلوزایی، تخم بارور شده چندین قسمت می شود و هر قسمتی فرد مستقلی به وجود می آورد. این چند قلوها به چند قلوهای حقیقی مرسومند. نسبت دوقلوهای حقیقی کمتر از دوقلوهای عادی است. قریب به ۷۰ درصد دوقلوها |دوقلوهای عادی هستند.

نسبت فراوانی آبستنی دوقلو در برابر آبستنی تک، حدود یک به ۸۹ آبستنی سه قلو یک به 89 به توان 2 آبستنی چهارقلو یک به ۸9 به توان 3 گزارش شده است. چند قلویی در زنان چندزا بیش از نخست زایمان بوده و طول دوره آبستنی معمولا کمتر است.

فصل هفتم

مراقبتهای بهداشتی در دوران بارداری، حین زایمان و پس از آن

هدف اصلی از این گونه مراقبتها آن است که حتی المقدور دوران بارداری به خوبی سپری شود وبه سلامت پایان پذیرد و از مرگ و میر احتمالی مادران و نوزادان در اثر عوارض حاملگی و مشکلات حین زایمان جلوگیری شود و بالاخره از ناراحتی روحی و جسمی دوران حاملگی و زایمان و نیز روزهای بعد از آن کاسته شود. با اعتقاد به این مهم، این فصل از کتاب به بحث و گفتگو درباره نحوه مراقبتهای بهداشتی در دوران بارداری، حین زایمان و پس از آن اختصاص یافته است.

الف ـ مراقبتهای بهداشتی در دوران بارداری توجه به بهداشت مادران باردار در خلال حاملگی یکی از اساسیترین و مطمعن ترین راههای حفظ سلامت مادر و جنین است زیرا با اعمال روشهای بهداشتی و مراقبتهای لازم می توان روند طبیعی بارداری و رشد مطلوب جنین را حفظ و موارض احتمالی را به موقع کشف و از امکان وقوع خطر یا پیشرفت آن، جلوگیری کرد. اینک اهم مراقب های بهداشتی را که در دوران بارداری می بایست رعایت شوند به شرح زیر بررسی میکنیم.

۱-تشکیل پرونده بهداشتی و معاینات پزشکی

مادر باردار اصولا در اولین هفته های بارداری باید به درمان دامهای مادر و کودک مراجعه کند و تحت نظر پزشک متخصص زنان یا مامای با تجربه قرار گیرد. این کار به منظور گرفتن شرح، معاینه دقیق، تشکیل پرونده، انجام آزمایشات مربوط به بارداری و ثبت و ضبط یافته ها، صورت می گیرد .

مادر حامله بعد از اولین مراجعه لازم است که تا هفت ماهگی (۲۸ هفتگی) هر ماه یک بار و از ۲۸ هفتگی تا 34 هفتگی هر ۲۱ روز یک بار و اا‌ز34 تا ۳۶ هفتگی هر ۱۵ روز یک بارو بعد از آن هر هفته برای معاینات لازم به مرکز بهداشت مادران باردار یا به پزشک یا ماما خانوادگی خود مراجعه کند.

بی شک توجه به اجرای این برنامه می تواند میزان رقم مرگ و میر مادران باردار، نوزادان و بروز عوارض زمان طفولیت و کودکی آنها را به پایین ترین حد خود برساند. امروزه این برنامه در تمام کشورهای پیشرفته معمول است.

۲-رژیم غذایی

با توجه به اینکه دوران بارداری تنها دورانی از زندگی انسانی است که یک ارتباط بسیار نزدیک پیوسته جسمی زیستی بین دو فرد وجود دارد، لذا در این مرحله از عمر، مادر به عنوان میزبان باید کاری کند که رشد و سلامت و بقای مهمانش را هر چه بهتر و بیشتر تأمین کند. در این راستا برخورداری مادر بارداار از رژیم غذایی کافی مناسب از اهم عومل به شمار می رود چرا که سلامتی فرد به میزان زیادی بستگی به دریافت مواد مغذی و در نتیجه ساختمان تغذیه او در دوران جنینی دارد. بدین ترتیب رشد و نمو جنین را می توان تابعی از رژیم غذایی مادر در طول دوران زندگی و به ویژه در دوران قبل از بارداری و حین بارداری دانست و طبق بررسی های انجام شده در دوران بارداری و شیردهی، علاوه بر نیاز طبیعی ، به طور متوسط روز انه به ترتیب حدود 300 و ۵۰۰ کالری انرژی اضافی مورد احتیاج است.

از سوی دیگر اضافه وزن بیش از حد مادر نیز ممکن است مشکلاتی در دوران بارداری به سبب فشار به قلب مادر،ازدیاد فشار خون و اختلال در تنفس و در موقع زایمان ایجاد کند. زنانی که دارای وزن اضافی هستند می توانند با رعایت رژیم غذایی، وزن خود را کنترل کنند تا در طول آبستنی بر وزن آنها بیش از پیش افزوده نشود. به این منظور باید قد و وزن باردار اندازه گیری شود و تناسب قد و وزن مورد توجه قرار گیرد. ضمنا از خوردن غذاهای چرب، دیر هضم و پر نمک باید حتی المقدور پرهیز شود.

3-کفش و لباس

۳- کفش و لباس در موقع بارداری که شکم به طرف جلو متمایل می شود انحنای ستون فقرات برای حفظ تعادل بدن زیادتر می شود و هر قدر پر انحنای ستون فقرات با پیشرفت بارداری افزوده می شود کشش عضلات و دردهای

حاصله از آن بیشتر می شود. به همین دلیل کفش پاشنه بلند تعادل را به هم می زند و شکم را بیشتر به طرف جلو متمایل می کند و در نتیجه کشش روی ستون فقرات و درد کمر را زیادتر می کند. از این رو مناسبترین کفش برای زنان باردار کفشهای پاشنه کوتاه و پهن است. کفشهای پاشنه بلند علاوه بر اینکه تناسب اندام را به هم می زند، خطر به زمین افتادن لغزیدن را بیشتر می کند. به همین مناسبت خانمهایی که عادت به پوشیدن کفشهای پاشنه بلند دارند می توانند از کفشهایی که حداکثر بلندی پاشنه آن ۳ تا ۴ سانتی متر و از نوع پاشنه پهن ؛ استفاده کنند. چون در مواقع بارداری، پاها مخصوصاً در ناحیه قوزک مختصری ورم می کنند، لذا بهتر است که کفش همیشه یک درجه گشادتر انتخاب شود تا تنگی آنها باعث مزاحمت نشود.

لباس دوران بارداری علاوه بر شیکی و سادگی باید راحت، نرم و متناسب با فصل انتخاب شود. همچنین از بکار بردن کمربند محکم در دوران بارداری باید خودداری شود زیرا کمربند سفت، لباس تنگ و همچنین کشهای محکم ساق جوراب معمولاً جریان خون سیاهرگی اندام پایین را متوقف می کند و باعث می شود که خون بیشتری در اعضای پایین جمع شود و ورم تدریجی یا گاهی واریس پا به وجود آید.

4-استحمام و نظافت

از آنجا که در دوران بارداری فعالیت پوست بدن بیشتر می شود و مواد زائد بیشتری دفع می کند اغلب خانمهای باردار از عرق کردن زیاد شکایت دارند و اگر در این دوره مرتبا پوست شستشو نشود منافذ پوست مسدود و راه خروج مواد زائد محدود میشود. و در دغع عرق اختلال بوجود می آیدا. لذا در صورت امکان حمام روزانه یا یک روز در میان با آب ولرم در پیشگیری از این مشکل میتواند مؤثر باشد. ضمناً از ماندن طولانی در آب بسیار گرم باید خودداری کرد . لگن بر اثر این عمل، پر خون می شود و خستگی و عوارض دیگری به وجود می آورد. تا هفت ماهگی حمام گرفتن در وان ضرر ندارد ولی از آن به بعد به علت سنگینی و عدم تعادل، خطر سرخوردن و افتادن وجود دارد و بهتر است از دوش استفاده شود شنا کردن در استخر و یا در دریا در صورتی که آب آلوده نباشد مانعی ندارد ولی برای ، در دو ماهه آخر بارداری از شنا کردن نیز خودداری شود.

5-خواب و استراحت

استراحت خانمهای باردار باید متناسب با کار و فعالیت روزانه شان باشد. معمولا ۸ تا 9 ساعت خواب در شبانه روز باعث می شود که از حساسیت و زودرنجی و خستگی پذیری این خانم ها کاسته شود. بعد از صرف ناهار هم بهتر است مدت کوتاهی استراحت کنند و اگر امکان استراحت برایشان میمبر نیست کافی است که کمی لم بدهند و راحت باشند. لیکن در ماههای آخر بارداری حتماً به استراحت بعدازظهر و به طور کلی استراحت بیشتری نیاز دارند. ضمنا خانمهای باردار لازم است از شب زنده داریها و تفریحات خسته کننده و هیجان آور خودداری کنند. زیرا این گونه تفریحات ممکن است منجر به زایمانهای زودرس، کم وزنی جنین، خستگی مفرط در مادر... شود و سلامت مادر و جنین را تهدید کند.

6-کار و فعالیت

بارداری بیماری نیست بلکه یک پدیده فیزیولوژیک و طبیعی است و چه با خانمهایی که در دوران بارداری از سایر مواقع زندگی احساس بهتری دارند و خود را سالمتر حس میکنند بنابراین بارداری نباید در روش زندگی و فعالیت روزانه خانمها اختلالی ایجاد کند. خانمهای باردار تا موقع زایمان می توانند اکثر کارهای روزمره را انجام دهند اما با فاصله و آرامش هیچ وقت نباید تا حد خستگی مفرط ادامه یابد بلکه به محض احساس اولین علایم خسگی باید فعالیت را متوقف و استراحت کنند.

7-ورزش

تمرینات بدنی ملایم مانند قدم زدن، دوچرخه سواری و شنا، سبب آرامش فکری و جسمی مادر می شود. پیاده روی در هوای آزاد بهترین و سالمترین ورزش است، ولی نباید موجب خستگی مفرط شود. کارهای سبک منزل مجاز است. مادران در صورتی که به ورزشهایی مانند اسکی شنا، گلف، تنیس و اسب سواری عادت داشته باشند نباید از ادامه آنها ممانعت شود، معمهذا از ورزشهای سنگین در ۲ ماه آخر می بایست خودداری شود.

هدف از تمرینات ورزشی در دوران بارداری این است که حالت و وضع عضلات بدن و زیبایی مادر حفظ و حتی بهتر شود و مادر از نظر جسمی و روحی برای زایمان آماده شود.

8-روابط جنسی

عمل آمیزش جنسی متعادل، در دوران حاملگی، در صورتی که شوهر رعایت کند که ناراحتی به وجود نیاید، خطری ندارد مگر سابقه سقطهای مکرر وجود داشته باشد با حاملگی متزلزل و ناپایدار باشد. عمل آمیزش جنسی در ماههای آخر حاملگی ممکن است مشکل و برای مادر ناراحت کننده و دردناک باشد. بنابراین پیشنهاد می شود دفعات کمتر و عمل آرامتر انجام گیرد.نا گفته نماند برخی از متخصصین زنان توصیه می کنند که در ماههای آخر بارداری بهتر است از آمیزش خودداری و تنها به اقناع جنسی اکتفا شود.

9-مسافرت

خانمهای باردار می توانند با قطار، اتومبیل و هواپیما مسافرت کنند، تنها نگرانی درمورد مسافرت خانمهای باردار این است که در صورت نیاز در طول راه ممکن است به پزشک متخصص زنان و یا مامای مجرب دسترسی نیابند و به همین دلیل بهتر است در هفته های آخر بارداری از مسافرت کردن خودداری کنند. خانمهایی که سابقه سقط جنین، زایمان زودوسر و مردن جنین در شکم دارند بهتر است که از مسافرت مطلقاً خودداری کنند راجع به راندن اتومبیل توسط خانمهای باردار بهتر است نظر پزشک معالج رعایت شود ولی معمولاً این عمل تا ۶ ماهگی مانعی ندارد، به شرط آنکه از نظر سرعت و پیش آمدهای غیر مترقبه کاملاً رعایت احتیاط بشود .

ب- مراقبت های بهداشتی حین زایمان

رایمان عملی است طبیعی که گاهی با اختلالاتی همراه است. این اختلالات که در گذشته موجب مرگ و میر زن باردار با کودک می شد، امروزه با پیشرفت علم پزشکی مشکلی از نظر زایمان باقی نمانده است. برای انجام زایمان، بایستی حداکثر کوشش بشود تا خطری پیش نیاید و برای این منظور بهتر است که وضع حمل در محیط بیمارستان یا زایشگاه انجام شود. در کشور ما، خوشبختانه، بر تعداد مادرانی که برای وضع حمل به بیمارستان و زایشگاه مراجعه می کنند افزوده شده است و روی همین اصل عوارض سخت و عفونتهای بعد از زایمان و مرگ و میر ناشی از آن به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. مجهز بودن بیمارستان و یا زایشگاه به کلیه وسایل لازم برای زایمان و وجود ماماهای |پر تجربه و حاضر بودن پزشک معالج و متخصص بیهوشی برای مقابله با هرگونه عارضه با خطر، این امکان را به مادر می دهد که با خیالی راحت در انتظار تولد فرزند خود باشد. مراقبتهای بهداشتی حین زایمان از دو نظر اهمیت دارد. اول تأمین سلامت و بهداشت مادر در امر زایمان و دوم توجه و نظارت بر ولادت هرچه راحت تر و کم عارضه تر توراد بنابراین، حاصل مراقبتهای بهداشتی در جریان زایمان برای مادر، ضمن تسهیل در امر زایمان و پیشگیری از عوارض مربوطه، در حفظ سلامت نوزاد وی نهفته است. در صورتی که امکان وضع حمل در بیمارستان وجود نداشته باشد، بایستی اقدامات بهداشتی ضروری را در منزل معمول داشت و وسایل مورد نیاز را قبلاً فراهم کرد. برای این منظور باید بهترین اتاق منزل را از نظر روشنایی، تهویه، تابش آفتاب و دور بودن از سر و صدا انتخاب کرد و برای استراحت و وضع حمل، یک تخت چوبی بزرگ با وسایل و ملافه تمیز فراهم آورد و از مجرب ترین فرد یا افراد ممکن در محل کمک گرفت.

ج – مراقبتهای بهداشتی پس از زایمان

هر مادری می خواهد هر چه زودتر از ناراحتیها و مشکلات جسمی و روانی دوران حاملگی و زایمان خلاص شود و به حالت طبیعی برگردد. اولین و مهمترین موضوع این است که بدن و اندام مادر به حالت اولیه برگردد و عضلاتی که ضعیف و کشیده شده و یا تغییر شکل پیدا کرده اند، قدرت و نیرو و شکل اولیه خود را به دست آورند. بنابراین آشنایی با بهداشت و مراقبتهای مخصوص بعد از زایمان در دوره نقاس (این دوره به ۶ تا ۸ هفته اول پس از زایمان اطلاق می شود، دوره ای که در آن رحم و سایر قسمتهای دستگاه تناسلی و تولید مثل زن که در طول آبستنی و زایمان متحمل تغییراتی بوده اند به حالت عادی برمی گردند) از نظر جلوگیری از عوارض گوناگونی که برای مادران پیش می آید اهمیت فراوان دارد. در این دوره باید به نظافت دستها توجه خاص مبذول داشت، زیرا از این طریق عفونت به دستگاه تناسلی، پستانها و نوزاد انتقال می یابد.

دستها را پس از کار، قبل از هر غذا، پس از توالت، قبل از شیر دادن کودک و دوشیدن پستانها، با آب و صابون باید شست. در زایشگاه و پس از آن در منزل، اندام تناسلی خارجی را انتقال می یابد. باید روزی دوبار شستشو داد. از فردای روز زایمان، مادر می تواند دوش بگیرد ولی استحمام کامل را بهتر است چند روزی به تعویق انداخت. ترشح مهبل تا سه چهار هفته ادامه دارد و استعمال یک پد (قطعه ای پنبه که در لایه ای از تنزیب قرار دارد) جاذب آب حداقل تا دو هفته ضروری به نظر می رسد. لباس زیر را هر چهار پنج روز یک بار باید تعریض کرد. پستانها را هر روز با آب و صابون شسته و قبل از شیر دادن بهتر است نوک آنها را با پنبه تمیز که در آب گرم شده باشد پاک کرد. اگر کودک در مکیدن تنبلی کرد و پستانها را از شیر تخلیه نکرد، لازم است مقدار باقیمانده را با دست یا شیردوش دوشید. اگر سینه ها خیلی پر شیر، سنگین و دردناک است می توان زیر دوش گرم ایستاد و سینه ها را زیر دوش نگه داشت تا سینه ها نرم و خروج شیر تسهیل شود. شقاق پستان را فورا باید درمان و بیش از پیش به نظافت پستان توجه کرد، چه شفاق پستان محل مناسبی برای انتشار عفونت به آن است. برای جلوگیری از شل شدن پستانها بعد از زایمان باید از کرست استفاده کرد و تنها به هنگام شیر دادن، پستانها را آزاد گذاشت. استفاده از شکم بند نیز برای جلوگیری از بزرگ ماندن شکم از دو تا سه هفته بعد از زایمان بسیار مفید است.

در این دوره رژیم غذایی مادر باید بر محتوا و غنی باشد. نیاز به هیچ گونه محدودیتی از نظر گوشت، نمک و مایعات نیست، لیکن از پرخوری باید پرهیز کرد. اگر زایمان بدون عارضه و به طور طبیعی انجام شده باشد، مادر از همان روز اول می تواند به پهلو بخوابد، روز دوم شد و روز سوم راه برود. لیکن فعالیت زودتر گاهی باعث سقوط رحم و مهبل می شود و ناراحتیهای بعدی دربردارد. بر اثر تغییرات ارگانیسمی که طی دوران بارداری در بدن زن باردار پدیدار شده است معمولاً ۶ تا ۸ هفته طول خواهد کشید تا آنها پس از زایمان به حالت عادی و طبیعی بازگردند بنابراین تا قبل از این مدت که دهانه رحم باز است و ترشحات زیادی دارد، اگر مقاربت جنسی صورت گیرد احتمال نفوذ میکروبهای گوناگون از بیرون به داخل رحم و سپس عفونت آن فراوان است. از سوی دیگر چنانچه هنگام زایمان بر اندامهای زایشی زن بخیه ای خورده باشد ممکن است بر اثر مقاربت جنسی تولید خونریزی یا ایجاد پارگی کند. بنابراین در جهت پیشگیری از بروز هرگونه ناهنجاری و عفونت بهتر است مقاربت را تا ۶ الی ۸ هفته بعد از زایمان به تعویق انداخت و برای حاملگی بعدی نیز حداق 1 ونیم سال به بدن استراحت داد تا مادر برای از دست رفته خود را باز یافته و برای حاملگی مجدد آمادگی لازم را داشته باشد. مراجعه به پزشک متخصص زنان در این دوره برای معاینات پزشکی بسیار ضروری است تا از بازگشت کلیه اندامهای بدن به حالت اول مطمئن شد و هر گونه عوارض احتمالی را بر طرف کرد.

فصل هشتم

تغذیه در دوران بارداری و شیردهی

یکی از عوامل موّثر در بهبود نسل و پرورش کودکان سالم. برخورداری مادزان از تغذیهٔ صحیح و متعادل است که این امر حتی در مراحل پیش از انعقاد نطفه و زندگی درون رحمی نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد چرا که بسیاری از مشکلات دوران بارداری ارتباط مستقیم با وضم تغذیهٔ مادر در زمان قبل از بارداری دارد و سابقه غذایی در زمان قبل از بارداری تاثیرات زیادی در وضع جسمی زنان باردار برجای می‌گذارد و مادرانی که با تغذیهٔ ناکافی در دوران کودکی همراه با کسالت و بیماریهای مختلف زندگی کرده‌اند پس از ازدواج و باردار شدن غالبا نمی توانند دوران بآرداری و شیردهی مطلوبی داشته باشند. گذشته از اهمیتی که تغذیهٔ صحیح مادران در دوران قبل از بارداری آنان دارده اثرات مثبت تغذیه مناسب در دوران بارداری و شیردهی نیز در سلامت جسمی و ذهنی نوزادان و شیرخو لران امر مسلمی است. البته تأمین رشد و نمو و سلامت کودک درگرو تغذیهٔ متعادل و کافی خود وی نیز هست. ۰ با توجه به این که مطالعه و بررسی دقیق در چگونگی تغذیه مادر و کودک مستلزم آگاهی های قبلی در زمینهٔ مقدمات علم تغذیه است.

تعریف علم تغذیه تغذیه علمی است که از ترکیبات، ساختمان و متابلیسم مواد غذایی در بدن و رابطه آنها با رشد و نمو و تکامل بدن انسان و موجودات زنده بحث و راههای سنجش و ارزیابی کیفی و کمی غذاها را توصیف میکند. لذا تغذیه، علم بررسی چگونگی عمل مواد مغذی و ارتباط آنها با یکدیگر و تناسب مقادیر آنها در سلامت و بیماری است.

تقسیم بندی مواد غذایی غذاهایی که در طبیعت یافت می شوند انواع مختلف دارند و به راههای گوناگون می توانند دسته بندی شوند. آنچه امروزه در علم تغذیه متداول است تقسیم بندی غذاها از روی ترکیبات شیمیایی و خواص تغذیه ای آنهاست که بر این اساس، مواد مغذی موجود در دسته عمده مشتمل بر: مواد قندی، چربیها، پروتئینها، مواد معدنی، و ویتامینها تقسیم بندی میکنند. شایان ذکر است که مواد قندی و چربیها به مواد انرژی زا، پروتئینها به مواد سازنده بافتها، مواد معدنی و ویتامینها به مواد محافظ معروف اند.

1- هیدراتهای کربن یا موادقندی این مواد که از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده اند، قسمت اعظم انرژی رژیم غذایی انسانها را تأمین میکنند و به علت ارزانی و داشتن تنوع، بیش از نیمی از غذای روزانه اکثریت مردم را تشکیل می دهند. بنابراین نقش این مواد این است که منبع انرژی باشند. هیدراتهای کربن را براساس نسبت پیچیدگی و اندازه مولکول آنها به سه گره مونوساکاریدها، دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها تقسیم می کنند.
مونوساکاریها قندهای ساده ای هستند که در میان هیدراتهای کربن کوچکترین مولکول را دارند و برای جذب شدن به تغییرات شیمیایی با هضم احتیاج ندارند. گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز از مهمترین مونوساکاریدها به شمار می روند.
دی ساکاریدها نظیر ساکارز، لاکتوز و مالتوز از دو مولکول مونوساکارید تشکیل شده اند و پلی ساکاریدها نظیر نشاسته،گلیکوژن و سلولز از اتصال چندین مولکول مونوساکارید به وجود آمده اند. هیدراتهای کربن به صورت مونوساکاریدها قابل جذب در بدن هستند.

براساس توصیه شورای تحقیقات جهانی تغذیه، حداقل مصرف یکصدگرم کربوهیدرات در روز از نظر پیشگیری از بروز بیماریها و اختلالات متابولیکی و جلوگیری از تجزیه پروتئینهای بدن به منظور جبران کمبود انرژی، ضروری است. اغلب رژیمهای عادی بیش از رقم ذکر شده جاوی کربوهیدرات هستند و از این نظر مشکلی وجود ندارد. از نظر منابع غذایی کربوهیدراتها، قند و شکر، عسل، میوه های شیرین، گندم، برنج، ذرت جو و سایر غلات و حبوبات، سیب زمینی، هویج، چغندر، شلغم و مانند اینها از جمله مواد قندی مهم به شمار می آیند. ناگفته نماند بیماری دیابت از مهمترین بیماریهایی است که بر اثر اختلال در متابلیسم مواد قندی در بدن به وجود می آید.

۲- لیپیدها (مواد چربی) لیپیدها به وفور در طبیعت وجود دارند، در تمام مواد نباتی و حیوانی یافت می شوند و مهمترین منبع انرژی غذایی را تشکیل می دهند زیرا هر گرم مواد چربی قریب ۹ کالری یعنی حدود دو برابر پروتئینها و مواد قندی انرژی تولید میکنند. چربیها گروهی از مواد آلی هستند که در آب | حل نمی شوند ولی در حلالهایی مانند اتر، کلروفرم و بنزن محلولند. چگالی این مواد از آب کمتر است و به همین جهت در روی آب قرار می گیرند. چربیها نیز مانند قندها از گرین، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده اند، با این اختلاف که نسبت اکسیژن به کربن و هیدروژن در چربیها کمتر ازمواد قندی است

به طور کلی لیپیدها، استر اسیدهای چرب هستند و از ترکیب الکل با اسیدهای چرب به وجود می آیند. بیش از چهل نوع اسید چرب (اشباع شده و اشباع نشده) در طبیعت یافت

می شوند که گوناگونی و ویژگی شیمیایی به خصوصی به چربیهای طبیعی می دهند. لیپیدها به صورت چربیهای ساده، با زنجیره کوتاه قابل جذب هستند. از این رو چربیهای با زنجیره بلند، با مقدار کمی پروتئین به هم پیوسته و به صورت لیپوپروتئین در می آیند که به صورت ذرات ریزی که شیلومیکرون خوانده می شود جذب می شوند و برای تولید انرژی به – مصرف می رسند ، (۲۰) تا ۲۵ درصد کالری براساس توصیه شورای تحقیقات جهانی تغذیه، لازم است غذای روزانه به وسیله چربیها تامین شود. همچنین به منظور حفظ سلامت بدن بهتر است مقدار چربیهای اشباع نشده بیش از چربیهای اشباع شده انتخاب و مصرف شود. روغنهای مایع روغن زیتون، ذرت و آفتابگردان حاوی اسیدهای چرب غیراشباع بیشتری هستند. از نظر منابع غذایی لیپیدها، غذاهای حیوانی مانند انواع گوشت، کره، خامه، شیر، تخم مرغ و روغنهای حیوانی منبع اصلی چربی هستند. به علاوه در دانه های روغنی مانند گردوفندق، بادام، و زیتون نیز مقادیر زیادی چربی وجود دارد. از حالات مرضی که در رابطه با متابلیسم چربیها قابل ذکرند، افزایش چربی خون، تصلب شرایین (رسوب مواد چربی در دیواره رگها) و چاقی را می توان نام برد.

۳- پروتئینها پروتئینها گروهی از مواد آلی هستند که ساختمانی بسیار پیچیده دارند و از اتصال اسیدهای آمینه به وجود می آیند. عناصر ساختمانی اسیدهای آمینه را کربن، اکسیژن، هیدروژن و ازت تشکیل می دهند. در ترکیب بعضی از اسیدهای آمینه گوگرد نیز وارد می شود. ازت عنصر اختصاصی پروتئینهاست که در ترکیب قندها و چربیها یافت نمی شود، خواص ویژه یک پروتئین با نوع اسیدهای آمینه موجود در آن، تعداد دفعاتی که اسیدهای آمینه در زنجیره تکرار می شوند و براساس نحوه اتصال آنها به یکدیگر تعیین می شود. از این رو چون هر اسید آمینه ممکن است چندین بار و با ترتیب گوناگون در ارتباط با اسید آمینه دیگر در مولکول پروتئین قرار گیرد احتمال تشکیل پروتئینهای مختلف بسیار زیاد است، لذا بدن انسان دارای هزاران پروتئین مختلف است که از حدود بیست نوع اسید آمینه تشکیل یافته اند.

یازده اسید آمینه از بیست نوع موجود، به وسیله سلولهای بدن قابل تهیه هستند و به اسید آمینه های غیر ضروری معروفند، بقیه اسید آمینهها یا اصولا در سلولها ساخته نمی شوند و یا مقدار ساخته شده برای رفع احتیاجات بدن کافی نیست. این گونه اسید آمینه ها که به اسید آمینه های ضروری موسومند، حتماً بایستی از طریق غذا وارد بدن شوند.

تریپتوفان، والین و هیستیدین (ضروری برای خردسالان) را می توان نام برد. از اسید آمینههای ضروری، ایزولوسین، لوسین، لیزین، متیونین، فنیل آلانین، ترئونین تریپتوفان والین هیستیدین ضروری برای خردسال را میتوان نام برد. پروتئینهای مورد مصرف انسان، معمولاً از زنجیره های طویل اسید آمینه بندهایی به هم اتصال یافته اند تشکیل شده اند. این مولکولها بسیار بزرگ هستند و نمی توانند از طریق دیواره روده عبور کنند، لذا می بایست به واحدهای کوچکترین به صورت تا نگه داری بافتها، تنظیم موازنه آب، نگه داری pH خون و اسیدهای آمینه تجزیه شوند تا داخل خون و از آنجا به بافتها برده شوند... نقش پروتئین ها در تامین رشد شرکت در ساختمان آنزیمها، برخی از هورمونها و پادتنها اهمیت زیادی دارد.

گرچه تعیین میزان دقیق احتیاج روزانه به پروتئین و تعمیم آن در شرایط گوناگون کار ساده ای نیست لیکن رقم ۸/۰ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را در افراد بالغ می توان حدود تقریبی در نظر گرفت. بدیهی است میزان مورد نیاز در نزد نوزادان و کودکان، زنان باردار و شیرده بیش از رقم ذکر شده خواهد بود. از نظر منابع غذایی، گوشت، پنیر، تخم مرغ، ماهی، شیر، ماست، حبوبات، دانه هایی چون گردو، پسته، بادام و فندق از منابع غنی پروتئین به شمار می روند. ضمناً چون پروتئینهای حیوانی از نظر کیفیت بر پروتئینهای گیاهی ارجحیت دارند، توصیه می شود که حداقل یک سوم پروتئین مصرفی روزانه از منابع حیوانی تامین شوند. از اختلالات اساسی که در اثر کمبود مواد پروتئینی در بدن بروز میک کنند، کواشیورکور و ماراسموس قابل ذکرند که با علایمی چون کاهش وزن بدن، وقفه در نمو، خستگی و بیحالی،تحریک پذیری، تأخیر در التیام زخم، کاهش مقاومت در برابر عفونت، تشنجات مداوم عضلانی، تغییر رنگ مو و ریزش آنها مشخص می شوند.

۴- مواد معدنی این گروه از مواد مغذی شامل تعدادی عناصر غذایی هستند که به صورت املاح معدنی در غذای انسان وجود دارند. این مواد علاوه بر شرکت در ساختمان یاخته های بدن از طریق کمک به آنزیمها، هورمونها و ویتامینها، در تنظیم اعمال بدن شرکت دارند ولی برخلاف مواد قندی، چربی و پروتئینی، تولید انرژی و حرارت نمیکنند. نیاز بدن نسبت به بعضی از مواد معدنی چون کلسیم، سدیم، پتاسیم، فسفر، منیزیم، گوگرد و کلر نسبتاً زیاد و به پاره ای از آنها مانند آهن، مس، روی، فلوئور، ید و کبالت خیلی کمتر است. این مطلب بدان معنی نیست که این دسته از مواد معدنی نقش مهمی در بدن ندارند، بلکه برعکس، کمبود آنها اختلالات مهم و گاه خطرناکی را موجب می شود. مواد معدنی در غذاها پراکنده اند و روزانه همراه غذاها به بدن می رسند. در مورد برخی از آنها چون آهن، کلسیم و فسفر باید توجه کرد که به خصوص در دوران رشد و نمو، بارداری و شیردهی به مقدار کافی به بدن برسند.

از لحاظ نسبت وفور عناصر معدنی در بدن باید دانست کلسیم با نسبت ۵/۱ تا ۲/۲ درصد وزن بدن (به طور معمول ۱۲۰۰ گرم)، بیشترین عنصر معدنی بدن را تشکیل می دهد. بعداز کلسیم، فسفر با حدود ۷۰۰ گرم، پتاسیم ۲۰۰-۲۴۰ گرم، گوگرد ۱۷۵ گرم، سدیم ۱۰۰ گرم، کلی ۱۰۰ گرم، منیزیم ۲۵ گرم، آهن ۴ گرم، و روی ۲-۵/۲ گرم در درجات بعدی قرار دارند. مقادیر عناصر دیگر در بدن انسان اغلب در حد میلی گرم است. حال به بررسی مختصر برخی از مواد معدنی مهم در بدن انسان می پردازیم: کلسیم: این عنصر برای تشکیل استخوانها، دندانها و انعقاد خون لازم است. شیر و مخصوصاً پنیر و تخم مرغ منابع بسیار خوب کلسیم به شمار می روند. ۴ ۲ ۱ سدیم: این عنصر در تنظیم pH و فشار اسمزی بدن نقش عمده ای ایفا میکند. غذاهای دریایی، گوشت، شیر و تخم مرغ از جمله منابع غذایی سدیم به شمار می روند. ۳- پتاسیم: این عنصر تحریک پذیری عصبی و عضلانی را کنترل، pH و فشار اسمزی را تنظیم میکند و بسیاری از آنزیمهای درون سلولی را فعال می سازد. ضمناً در آرامش عضله قلب مؤثر است. پتاسیم مورد نیاز بدن از طریق غذاهایی از قبیل گوشت، سبزیها، میوه جات حبوبات و غلات تأمین می شود. – منیزیم: این عنصر برای متابلیسم طبیعی بدن و فعالیت بعضی از آنزیمها ضروری است.

قهوه، کاکائو، غلات و سبزیجات از منابع سرشار منیزیم هـ آهن آهن در ساختمان هموگلوبین خون وارد می شود و برای خونسازی لازم است. کمبود رد آن انسان را مبتلا به نوعی کم خونی میکند. آهن همچنین در ساختمان بعضی از آنزیمها وارد می شود. کبد، گوشت، زرده تخم مرغ، غلات، سبزیها و به ویژه اسفناج از منابع سرشار آهن هستند.

منگنز: منگنز ماده اصلی برای فعالیت بعض از آنزیمهاست. گوشت، ماهی و مرغ، دانه غلات، حبوبات، سبزیجات و چای از منابع سرشار منگنز به شمار می روند. روی: این عنصر در ساختمان تعدادی از آنزیمها شرکت دارد و کمبود آن باعث اختلال در رشد طبیعی و تأخیر در بلوغ می شود. جوانه گندم، کبد و تخم مرغ، منابع خوب این عنصر هستند.

این عنصر در تشکیل هموگلوبین و در نتیجه خونسازی مؤثر است و یکی از عوامل ضدکم خونی است. گوشت، غلات، حبوبات، کبد و غذاهای دریایی از منابع مهم مس به شمار می روند.

ید: این عنصر از اجزای متشکله هورمون تیروکسین است و کمبود آن در انسان موجب بروز بیماری گواتر می شود. از جمله منابع مهم ید، ماهیها و حیوانات دریایی قابل ذکرند. فلوئور این عنصر در ساختمان دندانها و استخوانها وجود دارد و باعث استحکام استخوان بندی و مانع کرم خوردگی و فساد دندانها می شود. فلوئور در آ در آب، غذاهای دریایی، ماهی و چای موجود است. کلر: این عنصر در ترکیب اسید کلر ئیدریک شیره معدی شرکت دارد و آنزیم آمیلاز بزاق و روده را فعال می سازد. همچنین در تنظیم فشار اسمزی و نگهداری تعادل اسید و قلیای مایعات بدن نقش مهمی به عهده دارد. علاوه بر نمک طعام، گوشت، شیر، تخم مرغ، و غذاهای دریایی منابع سرشار کلر هستند. فسفر این عنصر مانند کلسیم در ساختمان استخوانها و دندانها وارد و جزء اساسی و ترکیبات یاخته ای محسوب می شود. منابع مهم غذایی آن، پنیر، تخم مرغ، گوشت و ماهی

گوگرد: عنصری است که در ساختمان بعضی اسیدهای آمینه و ترکیبات شیمیایی بدن وارد می شود. گوشت، ماهی، تخم مرغ، پنیر، غلات و بعضی از غذاهای گیاهی مانند سیر، پیاز،خردل و کلم از جمله منابع غنی گوگرد هستند.

کبالت: این عنصر یکی از اجزای ضروری در ساختمان ویتامین B است. که کمبود این B, ویتامین در بدن، ایجاد کم خونی وخیم و کشنده میکند. کید، قلوه، گوشت و شیر از منابع سرشارکبالت هستند.

۵-ویتامینها

ویتامینها گروهی از ترکیبات آلی هستند که اگرچه در تولید انرژی یا سازندگی بافتها، به طـور مستقیم و به خودی خود نقشی به عهده ندارند، لیکن برای تأمین رشد و بقای طبیعی بدن،اهمیت فوق العاده ای دارند.

E ویتامینها را برحسب آنکه در چربی و یا در آب محلول باشند به ۲ دسته ویتامینهای محلول در چربی شامل ویتامینهای A و D و E و K و ویتامینهای محلول در آب شامل ویتامینهای گروه B (B و B و PP و B و B ، اسید فولیک، اسید پنتوتنیک و بیوتین از انواع مهم آن به شمار می روند) و ویتامین C تقسیم بندی میکنند. ویتامینهای محلول در چربی، همواره با چربیهای مصرفی وارد بدن می شوند. بنابراین هر عاملی که در جذب چربیها دخالت کند در جذب این ویتامینها نیز مؤثر است. این دسته از ویتامینها در بدن ذخیره می شوند و دفع آنها از بدن به سختی انجام می گیرد و به همین جهت اختلالات حاصله از کمبود آنها دیرتر ظاهرمیشوند.

با وجود اینکه هر یک از ویتامینها به تنهایی نقش مجزا و ویژه ای در بدن دارند ولی در مجموع به عنوان تنظیم کننده واکنشهای حیاتی، از زمینه های مشترکی در یک رشته از فعالیتهای بدن، از قبیل رشد، تولید مثل، حفظ سلامت بدن، تغذیه عادی، فعالیت طبیعی دستگاه گوارش، واکنشهای عصبی و روانی، مقاومت در برابر عفونتها، برخوردارند.

در عین حال مصرف مقادیر زیاد این ویتامینها ایجاد مسمومیت میکند. ویتامینهای محلول در آب، برخلاف ویتامینهای محلول در چربی، در بدن ذخیره نمی شوند و یا میزان ذخیره آنها بسیار جزئی است و مازاد آنها از بدن دفع می شود. از این رو در مقایسه با ویتامینهای محلول در چربی، موارد مسمومیت در این دسته از ویتامینها کمتر و در عین حال، عوارض ناشی از کمبود آنها در زمان کوتاهتری بروز میکند. اینک به بررسی مختصربرخی از ویتامینهای مذکور می پردازیم:

الف - ویتامینهای محلول در چربی ویتامین A : این ویتامین در تامین رشد و نمو بدن، جلوگیری از شبکوری و حفظ سلام چشم اهمیت فوق العاده ای دارد. به علاوه وجود این ویتامین، برای ساختمان استخوانها، تتشکیل سلولهای دندان و محافظت پوست و غشای مخاطی ضروری به نظر می رسد. ویتامین A در شیر، پنیر، کره، زرده تخم مرغ، روغن کبد انـواع ماهیها و همچنین و پیش سازهای آن که در برخی از غذاهـای گیاهی نظیر سبزی، کاهو، آلو، طالبی، هـریم گوجه فرنگی، ذرت، کدو، سیب زمینی و زردآلو موجود است و طی تغییراتی در بدن به ویتامین

A تبدیل می شوند یافت می شود.

ویتامین D: این ویتامین برای رشد طبیعی و استحکام استخوانها و دندانها اهمین خاصی دارد. احتیاجات انسان به ویتامین D از طریق منابع غذایی و همچنین تأثیر مستقیم نر آفتاب بر پوست بدن تأمین می شود. در موارد کمبود آن، بیماری نرم استخوانی، بروز میکند ؟ در کودکان به راشی تیسم و در بزرگسالان به استئومالاسی معروف است. از نظر منابع غذایی ویتامین D در کره، شیر، پنیر، تخم مرغ و کبد یافت می شود اما بیش از همه در روغن کبد ماهی وجود دارد .

ویتامین E : برخی از محققین عقیده دارند که انسان برای تولید مثل، سلامت عضلات و E حفظ گلبولهای قرمز در مقابل همولیز و همچنین یک رشته واکنشهای فیزیولوژیکی به وجود این ویتامین نیازمند است. ضمناً این ویتامین به عنوان عامل آنتی اکسیدان در تهیه محصولات غذایی کاربرد وسیعی دارد. از مهمترین منابع ویتامین E روغنهای نباتی از قبیل روغن ذرت،

بادام کوهی، سویا، پنبه دانه، آفتابگردان و جوانه گندم را می توان نام برد. ویتامین K این ویتامین در انعقاد خون نقش مؤثری ایفا میکند و در موارد کمبود، زمان K : انعقاد خون طولانیتر می شود. برگ تازه سبزیها از قبیل کلم، کاهو و اسفناج منبع خوبی از این ویتامین به شمار می روند. افراد بالغ به طور عادی در رژیم غذایی خود به ویتامین K نیازی | ندارند زیرا، در حال سلامت، باکتریهای روده به مقدار کافی از این ویتامین تولید می کنند...

ب – ویتامینهای محلول در آب (ویتامینهای گروه B و ویتامین C) ویتامینهای گروه B : ویتامینهای گروه B شامل ترکیبات مختلفی هستند و شامل ویتامین Bیک و Bدو و PP و B 6 وB 12 ، اسید فولیک، اسید پنتوتنیک و بیوتین هستند.

بسیاری از این مواد مخلوط با یکدیگر در غذاها موجودند. ویتامین B1 (تیامین): این ویتامین برای متابلیسم مواد قندی در بدن، کار قلب ودستگاههای عصبی لازم است. کمبود آن ایجاد ناراحتیهای ع عصبی و قلبی و در مراحل پیشرفته ایجاد فلج میکند. بیماری ناشی از کمبود شدید ویتامین B ، بری بری خوانده می شود. این سبی و و پیشرف ویتامین در اغلب غذاهای نباتی و حیوانی موجود است. جوانه گندم و غلات غنی ترین منبع و ویتامین B هستند.

ویتامین B2 (ریبوفلاوین): این ویتامین در متابلیسم مواد غذایی مؤثر است. کمبود آن به صورت ضایعاتی در گوشه لب (به شکل شیار یا شکاف) تورم و التهاب زبان و ضایعات پوستی بروز میکند. منابع غذایی آن کبد، شیر، پنیر، تخم مرغ، سبزیجات و میوه هاست.

ویتامین PP (نیاسین): این ویتامین در ساختمان مولکولی کوآنزیم نیکوتینامید آدنین دی نوکلئوتید (NAD) و نیکوتینامید آدنین دی نوکلئوتید فسفات (NADP) شرکت میکند که این کوآنزیمها در واکنشهای متعدد متابلیسم واسطه وارد عمل می شوند. کمبود این ویتامین ایجاد بیماری پلاگر میکند. این بیماری باعث قرمزی و پوسته پوسته شدن و تغییر رنگ و کلفتی پوست، به خصوص در قسمتهایی از بدن که در مقابل نور خورشید قرار دارند (دستها، صورت و گردن) می شود. شکل لکه های رنگی در اطراف گردن به نام گردن بند کازال معروف است. از منابع غذایی این ویتامین،کبد، دل، قلوه، تخم مرغ، ماهی، شیرگاو، برنج و حبوبات را می توان نام برد. ویتامین B پیریدوکسین): این ویتامین به ویژه در متابلیسم پروتئینها و احتمالاً در تنظیم عمل سیستم عصبی مؤثر و لازم است. کمبود این ویتامین در نوزادان ایجاد اختلالات عصبی میکند و در افراد بالغ، اختلالات روانی، استفراغ و عوارض پوستی به همراه دارد. منابع اصلی این ویتامین کبد، دل و قلوه است لیکن در گوشتهای گاو، گوساله، ماهی و حبوبات نیز موجود است.

ویتامین B12 (سیانوکوبالامین): این ویتامین در خون سازی مؤثر است و کمبود آن تولید کم خونی وخیم و پیش رونده میکند. کبد، قلوه، ماهی، گوشت، تخم مرغ و شیر از بهترین منابع غذایی این ویتامین به شمار می روند.

اسید فولیک: بدن برای خون سازی به این ویتامین احتیاج دارد. در اثر کمبود اسیدفولیک، کم خونی مگالوبلاستیک بروز میکند که نشانه های آن، بزرگ شدن گلبولهای قرمز و نارسی و کاهش مقدار هموگلوبین است. به علاوه اختلالاتی نیز در لوله گوارش ایجاد می شود که موجب زخم دهان و بدی جذب می شود. انواع غذاهای حیوانی، به خصوص کبد و گوشت کم چربی گوساله و دانه های گیاهی مانند حبوبات خشک و سبزیهایی که دارای برگ سبز هستند

مانند اسفناج منابع غذایی اصلی اسیدفولیک محسوب می شوند. اسید پنتوتنیک: این ویتامین برای سلامت تمام یاخته های بدن لازم است و در مقابلیسم اهمیت زیادی دارد. عوارض و علایم ناشی از کمبود آن تاکنون در انسان دیده نشده است که علت آن توزیع گسترده این ویتامین در منابع غذایی است. کبد، قلوه،زرده تخم مرغ، زبان، گوشت و غلات از منابع غنی این ویتامین هستند. بیوتین: این ویتامین به شکل کو آنزیم در بدن فعالیت دارد. اگرچه شواهدی مبنی بر کمبود بیوتین در انسان وجود ندارد، لیکن در مطالعات تجربی، علایم کمبود این ویتامین به صورت ضایعات پوستی، افسردگی، سستی، از دست دادن اشتها، تهوع، درد عضلات، حالات غیر طبیعی در الکتروکاردیوگرام و غیره مشاهده شده است. کبد، قلوه، زرده تخم مرغ، قارچ خوراکی، گل کلم، بادام زمینی و مخمرها از جمله منابع غنی این ویتامین به شمار می روند. ضمناً مقداری بیوتین نیز به وسیلهٔ زمینه میکروبی روده سنتز و در اختیار بافتهای بدن قرار

می گیرد.

ویتامین C : این ویتامین برای دفاع بدن در برابر عوامل عفونت زا و سمی اهمیت اساسی : این و دارد. همچنین در عمل تشکیل دندانها و استخوانها، خونسازی و پروتئین سازی تا حدودی مؤثر است. کمبود ویتامین C به صورت بیماری اسکوربوت ظاهر می شود. از علایم این بیماری، خستگی و ضعف، بیحالی، گرفتگی عضلات، درد استخوان، درد و ورم مفاصل، تأخیر در التیام زخم، تورم و خونریزی از لثه، لق شدن دندانها و خونریزیهای زیرجلدی قابل ذکرند که در موارد شدید منجر به کم خونی و مرگ بیمار می شود. مرکبات، سبزیجات برگ سبز، گوجه، گیلاس و آلبالو از منابع غنی ویتامین C هستند .

احتیاجات روزانه بدن به انرژی حاصله از مواد غذایی یکی از خواص اساسی و عمده غذا تأمین انرژی لازم برای انجام فعالیتهای حیاتی است و همه اعمال زیستی انسان، چه اعمال ارادی مانند حرکت و انجام کارهای گوناگون و چه اعمال غیرارادی از قبیل دم زدن، ضربان قلب، اعمال امعاء و احشاء و همچنین رشد و نمو و ترمیم بدن حتی در حالت استراحت و خواب، برای انجام اعمال حیاتی چون تنفس، ضربان قلب تنظیم حرارت بدن و یا کار سایر دستگاهها احتیاج به انرژی دارد. مقدار انرژی لازم برای انجام اعمال حیاتی یک فرد را، که در حالت استراحت کامل است، اصطلاحاً متابلیسم پا به میگویند. حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد کل انرژی مورد احتیاج روزانه، در افرادی که کار متوسطی دارند، صرف تأمین متابلیسم پایه می شود.

افزایش ترشح بعضی از غدد داخلی از جمله عواملی هستند که در متابلیسم پایه و در نتیجه سطح بدن، سن، جنس، حالات فیزیولوژیک خاص مانند حاملگی و شیردادن، بیماری واحتیاجات کلی بدن به انرژی مؤثرند.

لازم به یادآوری است یاخته های بدن قادرند انرژی حاصل از سوخت مواد سه گانه (موادقندی، چربیها، پروتئینها) را موقتاً به صورت انرژی شیمیایی ذخیره کنند که یکی از مهمترین منابع ذخیره انرژی، ترکیب شیمیایی ناپایداری به نام آدنوزین تری فسفات (ATP) است. ATP ترکیبی از آدنین، ریبوز و سه رادیکال فسفات است که دو رادیکال فسفات آخر توسط اتصالی موسوم به اتصال پرانرژی به بقیه مولکول متصل شده اند. مقدار انرژی آزاد در ر یک از اتصالات پرانرژی برای هر مولکول گرم ATP حدود ۸ کیلوکالری است. بنابراین جدا شدن هر رادیکال فسفاتی قریب هشت کیلوکالری انرژی آزاد میکند. ATP بعداز جدا شدن یک رادیکال فسفاتی به ADP (آدنوزین دی فسفات) و بعداز جدا شدن رادیکال فسفاتی دوم به AMP (آدنوزین مونوفسفات) تبدیل می شود. ترکیباتی که انرژی از دست می دهند با استفاده از انرژی حاصل از اکسیداسیون مواد غذایی، مجدداً می توانند به حالت اولیه خود برگردند و به همین دلیل ATP ارز انرژی بدن نامیده می شود که می توان آن را مصرف کرد و مجدداً به دست آورد.

تغذیه در دوران بارداری

دوران بارداری یکی از مهمترین دوران زندگی بانوان است. شاید در هیچ دورانی از زندگی، دو موجود این قدر نزدیک و مرتبط به یکدیگر نیستند. بسیاری از تغییرات (جسمی، روحی، روانی، داروها و بعضی غذاها) که در بدن مادر صورت میگیرد ممکن است در سلامت موجود تازه و حتی نسلهای بعداز آن دخالت کند. بدین جهت تغذیه صحیح مادر در دوران بارداری در تأمین و حفظ سلامت کودکان فوق العاده حایز اهمیت است. تغذیه صحیح و کافی در دوران بارداری علاوه بر تامین رشد کافی و ایجاد ذخایر غذایی در جنین، باعث تشکیل ذخایر مواد مغذی در بدن مادر نیز می شود. ایجاد این ذخایر در بدن مادر یکی از شرایط توفیق در شیردهی، به خصوص در شش ماه اول آن است. گزارشهای موجود در جوامع مختلف نشان می دهد. مادرانی که در دوران بارداری تغذیه کافی ندارند، وزن نوزادشان کمتر از نوزادان مادرانی است که در دوران بارداری از تغذیه مناسب و صحیح برخوردار هستند. معمولاً پیروی از رژیم غذایی خاص در دوران بارداری لزومی ندارد، ولی به علت تغییر شرایط فیزیولوژیک در زنان باردار، علاوه بر افزایش مقدار انرژی مورد نیاز روزانه، توجه کمیت و کیفیت پروتئین و مقدار مواد معدنی و ویتامین ها نیز حایز اهمیت است.

در دوران بارداری همزمان با رشد سریع جنین بر وزن مادر نیز افزوده می شود. اضافه وزن مادر د روزهای آخر بارداری معمولاً در حدود بیست درصد وزن قبل از بارداری پیش بینی می شود همراه با ازدیاد وزن زنان باردار، احتیاجات غذایی نیز به دلایلی چون تأمین رشد و نمو بافتهای جنین و ضمایم آن، نگهداری بافتهای رشد کرده، تهیه ذخایر غذایی در جنین و مادر بالاتر می رود. از این رو انرژی مصرفی در دوران بارداری به ویژه از نیمه دوم حاملگی، به طور متوسط حدود ۳۰۰ کالری در روز افزایش می یابد.

پروتئین

برای رشد و نمو جنین و بافتهای در حال تکامل وی و نیز تدارک غذای بعداز تولد نوزاد در پستان مادر، پروتئین مورد نیاز در دوران حاملگی نیز افزایش می یابد و بایستی حدود ۲۰ گرم در روز اضافه بر مقدار مورد نیاز عادی مصرف شود. بهتر است دو سوم از پروتئین مصرفی از منابع حیوانی نظیر گوشت، شیر، تخم مرغ، پنیر، ماهی و گوشت پرندگان و یک سوم بقیه از منابع گیاهی از قبیل نان و حبوبات تأمین شود.

در دوران حاملگی توجه به دریافت مواد معدنی به ویژه آهن، کلسیم و مصرف نمک طعام مواد معدنی ضروری است. رشد سریع آهن: وجود آهن در رژیم غذایی دوران بارداری به خصوص در مادرانی که به علل مختلف ذخیره آهن بدنشان کافی نیست (بیماری یا زایمانهای مکرر) اهمیت خاصی دارد. رشد سریع جنین و ضمایم آن و افزایش بافتها و حجم خون مادر، احتیاج به آهن را در دوران بارداری افزایش میدهد.

به علاوه ذخیره آهن کبد نوزاد که در دو تا چهار ماه اول زندگی مصرف می شود به تغذیه مادر در دوران بارداری بستگی دارد. با توجه به اینکه زنان باردار عادت ماهانه ندارند و از این طریق آهن بدن آنها دفع نمی شود مقدار آهن مورد نیاز روزانه آنها برابر زنان در حالت عادی است و چون دفع آهن در این دوران صورت نمی گیرد مقدار عادی روزانه که حدود ۲۰ میلی گرم توصیه شده کافی به نظر می رسد ولی در صورتی که مادر مبتلا به کم خونی ناشی از فقر آهن باشد، مصرف مقداری آهن اضافی در جیره غذایی ضروری خواهد بود.

کلسیم: این عنصر برای تشکیل استخوانها و جوانه های دندانی جنین لازم است. در دوران بارداری مقدار کلسیم مورد نیاز روزانه ۱۲۰۰ میلی گرم، یعنی در حدود ۵/۱ برابر مقدار توصیه شده روزانه برای زنان در حالت عادی است. مصرف روزانه شیر و فرآورده های آن از قبیل پنیر، ماست و کشک جهت تأمین کلسیم بسیار مناسب است، به خصوص کلسیم شیر که به بهترین وجه قابل جذب است.

نمک طعام: در بارداری، متابلیسم نمک طعام پیچیده است. توصیه می شود خانمهای باردار در صورتی که وزنشان بیش از حد طبیعی بالا رفته یا مایع در بافتهایشان ن جمع است نمک مصرفی را تا حدودی کاهش دهند. ارتباط سدیم با ورم و فشارخون باعث شده است که رژیم محدود از نمک برای جلوگیری از ابتلا به مسمومیت آبستنی، به خانمهای باردار تجویز شود. در هر حال بهتر است خانمهای باردار از مصرف نمک اضافی همراه غذا خودداری کنند نمک را فقط برای مزه به غذا اضافه کنند.

ویتامینها

گروهی اعتقاد دارند که مصرف برخی از ویتامینها در دوران بارداری ضروری است و میزان نیاز به دسته ای از این ترکیبات در این دوران افزایش می یابد. به هر حال اهمیت غذایی را که ویتامین کافی دارد، برای ایجاد سلامتی در دوران بارداری نمی توان منکر شد. شیر، میوه و سبزیجات در مقادیر کافی می توانند تمام ویتامینهای لازم را تأمین سازند. زمانی که رژیم غذایی خوب و مخلوط مصرف شود نیازی به تجویز هیچگونه ویتامین اضافی نخواهد بود. هرگاه نسبت به کیفیت تغذیه تردیدی باشد، آب میوه تغلیظ شده، قرصهای ویتامین A و B یا روغن کبد ماهی و همچنین اسیدفولیک به منظور جلوگیری از بروز کم خونی مگالوبلاستیک باید تجویز شود.

توصیه های غذایی برای دوران بارداری گرچه توصیه های غذایی به مادران حامله باید بر مبنای مواد غذایی موجود در محل و عادات غذایی آنها باشد، لیکن غذاهایی را که معمولاً برای دوران بارداری پیشنهاد می شوند، در زیر یادآور می شویم .

- مصرف روزانه دو تا سه لیوان شیر با معادل آن ماست و پنیر کم نمک در رژیم غذایی - گنجاندن روزانه حداقل یک وعده غذای گوشتی نظیر گوشت گوسفند، گوساله، مرغ، ماهی و ... در رژیم غذایی

در نظر گرفتن تخم مرغ به تعداد چهار تا پنج عدد هر هفته در رژیم غذایی، برحسب اشتها و با کنترل وزن مادران گنجاندن میوه و سبزیجات تازه در رژیم غذایی. وجود نان، برنج و سیب زمینی در رژیم غذایی

- گنجاندن مایعات نظیر چای، آب و دوغ در رژیم غذایی به مقدار دلخواه. چنانچه زن باردار، از آغاز دوران بارداری برنامه غذایی متعادلی داشته باشد، این دوران را به راحتی سپری میکند و با افزایش غیرعادی وزن و برخی مشکلات دوران بارداری مواجه نخواهد شد.

پرهیز غذایی در دوران بارداری در صورتی که دوران بارداری به طور طبیعی و با رعایت تغذیه صحیح و مراقبتهای لازم طی شود، معمولاً نیاز به پرهیز غذایی نیست. با این وجود در رابطه با عوارضی که معمولاً در دوران بارداری شایع است

توجه به دو نکته مهم ضروری به نظر می رسد: ۱- به منظور جلوگیری از به وجود آمدن ناراحتیها و عوارض معدی و روده ای و افزایش وزن، بهتر است حتی الامکان از خوردن غذاهای چرب، سرخ کرده، شیرینیهای خامه دار وهمچنین سبزیجات زیاد که باعث نفخ شکم می شود، خودداری شود. ۲- از آنجایی که دفع نمک به وسیله کلیه ها به علت فشار رحم روی آن، به آسانی صورت نمی گیرد و مقداری از نمک در نسوج مختلف میکند، بهتر است از خوردن غذاهای پرنمک جلوگیری شود. تا زمانی که فشار خون و آلبومیر جمع می شود و ایجاد تورم و اضافه وزن غیر طبیعی و تورم شدید صورت و اعضای بدن، به خصوص دست و پا ظاهر نشده اند، رژیم غذایی خاصی مورد نیاز نیست ولی چنانچه هر یک از علایم فوق که نشانه مسمومیت بارداری است، پدید آید، رعایت رژیم غذایی کم نمک یا بی نمک طبق تجویز پزشک ضروری خواهد بدن بود.

تغذیه در دوران شیردهی دوران شیردهی نیز همانند دوران بارداری، مسائل تغذیه ای فراوانی به همراه دارد. مادری که طفل را از پستان خود شیر می دهد نیاز به غذای خوب، کافی و کاملی دارد به ویژه اگر این مادر فعالیتهایی در خارج از خانه نیز داشته باشد. بدین لحاظ در دوران شیردهی احتیاج مادر از جهت دریافت انرژی، پروتئین و بعضی از ویتامینها و مواد معدنی افزایش می یابد. در این دوران رژیم غذایی مادر، علاوه بر تأمین احتیاجات غذایی، باید دارای موادی باشد که از طریق شیر خارج می شوند.

انرژی مورد نیاز نیاز به انرژی اضافی در دوران شیردهی بستگی به مقدار شیر تولید شده دارد. به طور معمول مقدار تولید روزانه شیر زن، تقریباً ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلی لیتر است و انرژی لازم برای تولید این مقدار شیر حدود ۶۰۰ کالری است. اگر کارآیی بدن در تولید شیر هشتاد درصد باشد مادر شیرده به ۷۵۰ کالری برای تولید شیر نیازمند است ولی چون ذخایر چربی بدن مادر در این دوره برای تولید شیر مصرف می شود، انرژی اضافی مورد نیاز روزانه حدود ۵۰۰ کالری توصیه شده است.

پروتئین مقدار متوسط پروتئین شیر انسان حدود ۲/۱ درصد است. به عبارت دیگر اگر میزان متوسط تولید شیر به طور روزانه ۸۵۰ میلی لیتر باشد، این مقدار شیر حاوی ۱۰ گرم پروتئین است و در موارد تولید شیر بیشتر (۱۲۰۰ میلی لیتر در روز) پانزده گرم پروتئین دارد. طبق نظر متخصصین، روزانه بیست گرم پروتئین، علاوه بر پروتئین مصرفی برای دوران شیردهی، توصیه شده است که تخمین زده می شود این مقدار پروتئین برای تولید ۱۲۰۰ میلی لیتر شیر در روز کافی باشد (با در نظر گرفتن کفایت تبدیل که هفتاد درصد پروتئین مصرفی روزانه قابل تبدیل به پروتئین شیر است).

افزایش انرژی و پروتئین مورد نیاز در دوران شیردهی با مصرف یک لیتر شیر در روزتأمین می شود.

مواد معدنی در دوران شیردهی نیز همچون دوران بارداری، نیاز مادران به املاح افزایش می یابد و دقت لازم در انتخاب رژیم غذایی متعادل و کافی را برای تأمین مواد معدنی مورد نیاز بدن ایجاب میکند. چون مقدار آهنی که از طریق شیر دفع می شود نسبتاً کم است، به علاوه زنان شیرده معمولا عادت ماهانه ندارند، بنابراین مقدار آهن مورد نیاز روزانه آنان در دوران شیردهی نیز حدود بیست میلی گرم توصیه شده است که معادل همان مقدار آهن لازم برای شرایط عادی و و اهن دوران بارداری است. کلسیم: مقدار کلسیم شیر انسان تقریباً ۳۰ میلی گرم در یکصد میلی لیتر است. تخمین زده شده است که یک نوزاد احتیاج به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلی گرم کلسیم در روز دارد. با در نظر گرفتن این مسئله که در این دوران جذب کلسیم خیلی پایینتر از صدرصد است، بنابراین مصرف - ۱۲۰۰ میلی گرم کلسیم برای جبران نیاز کلسیمی مادر کافی است. اگر در رژیم غذایی مادر، کلسیم - به مقدار کافی تأمین نشود، میزان کلسیم شیر از ذخایر اسکلتی مادر تامین می شود. زنانی که نمی توانند شیر یا فرآورده های شیری را مصرف کنند، مکمل کلسیم روزانه به مقدار یک گرم جهت جبران کلسیم استخوان مادر توصیه می شود. مورد فسفر ۴۰۰ میلی گرم، ید ۵۰ میکروگرم، منیزیم ۱۰۰ میلی گرم و روی ۱۰ میلی گرم در روزه علاوه بر آهن و کلسیم، نیاز به سایر املاح نیز در دوران شیردهی افزایش می یابد. مثلاً در علاوه بر نیاز عادی می بایست در نظر گرفته شود.

ویتامینها برای تأمین ویتامینها که نیاز روزانه به آن در دوران شیردهی افزایش می یابد، مصرف میوهها و سبزیها به مراتب بهتر از فرآورده های دارویی حاوی ویتامینهاست. استفاده از آفتاب مستقیم بهترین راه تأمین ویتامین D است. معمولاً با مصرف مقدار کافی غذاهای متنوع و دریافت کالری و پروتئین مورد نیاز روزانه، ویتامینهای مورد نیاز هم تأمین می شود.

مایعات

با توجه به اینکه قریب ۸۷ درصد حجم شیر مادر را آب تشکیل می دهد، میزان مایعات دریافتی مادر می بایست روزانه در حدود سه لیتر باشد تا از کم آبی بدن مادر جلوگیری کند. بهتر است یک لیتر از این سه لیتر با مصرف شیر تأمین شود زیرا به این ترتیب مقداری از پروتئینها، ویتامینها و کلسیم مورد نیاز مادر نیز تأمین می شود. چنانچه در جریان شیردهی، وزن مادر روبه افزایش باشد، بهتر است از شیر بدون چربی استفاده شود.

نکات قابل توجه در مصرف داروها، مواد مخدر و بعضی از مواد غذایی در دوران شیردهی

باید توجه داشت که اگر مادر در زمان شیردهی دارویی مصرف کند، احتمال دارد مقداری از دارو در شیر وی وارد شود. به همین جهت مادر شیرده، به هر دلیلی هرگز نباید خودسرانه دارویسی مصرف کند. برای رفع یبوست نیز بهتر است به جای استفاده از داروهای ملین، مقدار بیشتری استعمال مواد مخدر به وسیله مادر باعث اعتیاد شیرخوار می شود. به همین دلیل مصرف این گونه مواد و همچنین استعمال دخانیات و نوشیدن مشروبات الکلی برای مادران شیرده، به هیچ عنوان منطقی و عاقلانه نخواهد بود.

مصرف بعضی از مواد غذایی مانند پیاز،کلم و سیر ممکن است سبب ناراحتی گوارشی و شل شدن مدفوع شیرخوار شود و یا به علت نامطبوع شدن طعم شیر بر اثر مصرف این مواد، کودک از خوردن آن امتناع کند. بهتر است مادر شیرده این موارد را بشناسد و در مصرف موادغذایی، محتاط باشد. لازم به تذکر است که حذف هیچ یک از خوردنیها از برنامه غذایی مادر شیرده توصیه نمی شود مگر اینکه مصرف آن به طریقی تأثیر نامطلوبی در کودک داشته باشد. بهتر است مادران شیرده از مصرف ادویه و غذاهای تند و محرک نیز پرهیز کنند.

فصل نهم

تغذیه نوزادان و شیرخواران

آغاز زندگی نوین بعد از تولد، در حقیقت ادامه حیات داخل رحمی در محیط خارج است. ادامه سیر تکاملی و رشد سریع سیستمهای عصبی، قلبی و عروقی، گوارشی، آنزیمی و فاکتورهای اختصاصی و ایمنی بخش نوزاد، احتیاج به مواد غذایی متناسب با اعمال فیزیولوژیکی نوزادان دارد که از طریق شیر مادر یا تغذیه مصنوعی و همچنین غذاهای مکمل باید تأمین شود. در این فصل از کتاب که به تغذیه نوزادان و شیرخواران اختصاص دارد، ابتدا تغذیه نوزادان با شیر مادر و سپس روش تغذیه نوزادان به طریقه مصنوعی را شرح خواهیم داد.

نظر اسلام درباره تغذیه با شیر مادر در گذشته تغذیه با شیر مادر نشانه شایسته بودن مادر برای انجام نقش بیولوژیک وی بوده و تغذیه با شیر مادر در بسیاری از آموزشهای مذهبی از ارزشهای اجتماعی محسوب شده است. به طوری که طبق شرع مقدس اسلام برای مادران «حق شیر» در نظر گرفته شده و گاهی آن را به صورت شیربها طلب میکنند. در سابق تنها در موارد استثنایی نظیر مرگ مادر، ابتلای وی به بیماریهای شدید و یا تولید نشدن شیر کافی، در صورتی که دایه نیز در دسترس نبود، شیرهای دیگر توصیه می شد زیرا در هیچ شرایط، رقابت سایر شیرها با شیر مادر امکان پذیر نبود. در روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده درهمه موارد بر تغذیه با شیر مادر تأکید شده است.

در قرآن مجید در سوره بقره، آیه ۲۳۲، آمده است، «مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر بدهند. برای کسانی که بخواهند دوران شر خوارگی را تمام کنند». در سوره طلاق آیه - می فرماید، «در مورد زنهایی که طلاقشان داده اید چنانچه بچه هایتان را برایتان شیر می دهند مزدشان را بدهید، با آنها به عدل رفتار کنید و اگر شیر دادن برایشان دشوار است، زن دیگری را دایه فرزند خود بگیرید». حضرت محمد پیشوای بزرگ بشریت می فرمایند، «آیا خشنود نیستید وقتی یکی از شما از شوهرش آبستن است و شوهرش خشنود است؛ ثواب کسی را دارد که روز، روزه بدارد و شب برای عبادت بپا خیزد. هنگامی که زایمان کند، هر جرعه ای که از شیر او درآید و هر دفعه که پستان او مکیده شود برای هر جرعه شیر و هر مکیده شدن ثوابی دارد و اگر برای مراقبت از طفل خود، شبی بیدارماند پاداش او همان است که هفتاد بنده را در راه خدا آزاد کرده

متأسفانه برخی از مادران ایرانی به دلایلی چون تبلیغات شرکتهای سازنده شیرهای مصنوعی، شاغل بودن و فعالیتهای خارج از منزل، نداشتن آگاهی و آموزشهای لازم درباره مزایای شیر مادر، تصور غلط از اینکه تغذیه با پستان، اندام را بی تناسب میکند، فرزندان خود را به تغذیه مصنوعی عادت می دهند و جگر گوشه های خود را از نعمت تغذیه با شیر مادر محروم میکنند.

چه خوب است به دستورات الهی و عادات و رسوم انسانی خود توجه کنیم، کودکانمان را در آغوش پر مهر مادری پرورش دهیم، ارزشمندترین غذاها یعنی شیر مادر را هد به اش سازیم او را همیشه در کنار خود داشته باشیم، ارتباط عاطفی و انسانی را از همان بدو تولدش بر فراز کنیم و از شیره جانمان به او بدهیم تا رشد و تکاملی ایده آل و دلخواه داشته باشد.

ساختمان پستان و چگونگی ترشح شیر پستان در زنان از ضمایم دستگاه تولید مثل محسوب می شود و برای ترشح شیر و تغذیه نوزاد تطابق یافته است. نمو ظاهری پستانها در سنین ۸ تا ۹ سالگی آغاز می شود و در مرحله بلوغ کامل می شود ولی ساختمان داخلی آن در دوران حاملگی تغییر و با ترشح شیر تکامل می یابد. پستانی که کاملاً رشد کرده باشد از ۱۵ تا ۲۰ لپ غده ای تشکیل شده است که به شکل شعاعهایی در کنار یکدیگر قرار گرفته و بین آنها را بافت همبند پر کرده است. رشته های بافت همبند پستان تا حدودی دارای خاصیت ارتجاعی هستند و باعث سفتی و قوام این غده می شوند. هر یک از لپهای غده ای که به لپهای پستانی موسومند، شامل لیکهای متعددی هستند و هر لیک از یاخته های ترشحی شیر تشکیل شده است که دارای مجرایی ترشحی به نام شیربر است. مجراهای کوچک به مجراهای بزرگتری می پیوندند و مجراهای اخیر در نزدیکی نوک پستان گشادتر می شوند و سینوسهای شیربر را تشکیل می دهند و سرانجام به وسیله هشت تا پانزده مجرای باریک به نوک پستان باز می شوند.

با اینکه پستانها پس از چهارمین ماه حاملگی آماده ترشح شیر هستند ولی ترشح شیر موکول به انجام عمل زایمان است زیرا احتمالاً عمل ترشحی پستان در اثر مقدار زیاد پروژسترون دوران حاملگی امکان پذیر نیست اما بلافاصله پس از تولد نوزاد و خروج جفت از رحم نه تنها میزان پروژسترون بلکه استروژن خون کاهش می یابد در عوض ترشح پرولاکتین از غده هیپوفیز افزایش می یابد و نمو سریع پستان و ترشح شیر آغاز می شود. لازم به یادآوری است که مکانیسم ترشح شیر،بازتاب هورمونی است و مکیدن بخش قدامی نوک پستان توسط نوزاد نقش عمده ای در آن دارد. زیرا با مکیده شدن نوک پستان، ضمن ترشح پرولاکتین، اکسی توسین نیز ترشح می شود و با تحریک سلولهای خاصی که تحت تأثیر شوند، شیر به خارج رانده می شود. به همین دلیل زمانی که پستان با مکیدن نوزاد تحریک نشود ترشح شیر تیز متوقف خواهد شد.

در روزهای اول تولد، مقدار شیر کم است و آغوز یا ماک (کلستروم) نامیده می شود. این شیر دارای مواد پروتئینی و ضد میکروبی زیادی بوده و برای تغذیه نوزاد مناسب است که به تدریج در طی چندین روز تغییر رنگ و حالت داده و به صورت شیر معمولی در می آید. همچنین مقدار شیر در پستانها در روزهای اول نسبتاً کم است (برای رفع احتیاجات اولیه نوزاد کافی است) و به تدریج مقدار آن افزایش می یابد. مقدار عادی ترشح روزانه شیر در حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلی لیتر است. برای ترشح شیر به مقدار کافی، عوامل مختلفی از قبیل، سلامت جسم و آرامش روح مادر، پیروی مادر از یک برنامه صحیح غذایی، استراحت و خواب کافی، اشتیاق و اعتقاد مادر به شیر دادن و تخلیه کامل پستان با مکیدن آن توسط شیرخوار مؤثرند.

مزایای تغذیه با شیر مادر تغذیه با شیر مادر دارای مزایای متعددی است که به پاره ای از آنها اشاره می نماییم:

پستان مادر، به طور سالم و با درجه حرارت مناسب و مطبوع آماده است. شیر مادر مستقیما از مادر همیشه و در همه موارد

1- سالم بودن شیر مادر سالمترین نوع تغذیه نوزاد و شیرخوار است. شیر و نوک پستان مادر به دهان کودک می ریزد و عاری از هر گونه آلودگی خارجی است.

2-شیر مادر و مسائل اقتصادی امروزه بهترین و اقتصاد بترین شیر برای تغذیه نوزاد شیر مادر است. در اکثر کشورها هزینه تهیه شیرهای جانشین شیر مادر، از نظر مادی از عهده اغلب خانواده ها خارج است. وشهای تغذیه با شیر مادر و شیرهای جانشین نشان می دهند که از نظر اقتصادی باید به مخارج جانبی از قبیل هدر رفتن غذا در تغذیه با شیرهای جانشین، هزینه خرید شیشه و پستانک و نظافت آن، هزینه های پزشکی خانواده مانند هزینه درمان اسهال و استفراغ و سوء تغذیه ناشی از خوردن شیرهای دیگر و تقاضای بیشتر در مورد خدمات درمانی و در نتیجه فشار بیشتر بر این خدمات نیز توجه کرد.

۳- آسایش و راحتی مادر مادری که طفل را با شیر خود تغذیه میکند، هر زمان و هر کجا نوزاد به شیر احتیاج داشته باشد بدون تهیه کردن وسایل، به راحتی قادر است طفلش را از پستان خود تغذیه کند.

۴- عوامل روانی

موقعی که نوزاد برای شیرخوردن در دامان مادر خوابیده و سر او به سینه مادر است، با مادر خود رابطه بدنی نزدیک پیدا میکند و این حس تماس نزدیک بین مادر و شیرخوار، سبب علاقه در مادر و حس وجود شخصی به نام مادر در شیرخوار می شود. کودکی که از شیر مادر تغذیه می شود، از لحاظ روانی آرامش و ثبات بیشتری دارد. تغذیه با شیر مادر باعث ایجاد محبت، اعتماد و ارضای کودک و همچنین سبب پیدایش تعادل هورمونی در مادر می شود.

۵ - پیشگیری از عفونتهای گوارشی و تنفسی شیرخواران در شش ماه اول نسبت به عفونتها مقاومت کمی دارند و در صورت برخورد با عامل بیماری را به سرعت مبتلا به اسهال و استفراغ و عفونتهای ریوی می شوند که این امر در

شیرخوارانی که به طریق مصنوعی تغذیه می شوند به مراتب بیشتر و شدیدتر است.

۶- اثر ضد میکروبی شیر مادر و و شیر مادر نه تنها از نظر کیفی و کمی بهترین شیر و ماده غذایی برای رشد و نمو و سیر تکاملی نوزاد انسان است بلکه مواد ایمنی بخش و ضدعفونی کننده آن نیز از قبیل لیزوزیم وهمونوگلوبولین ، تکمیل کننده سیستم ایمونولوژی در حال رشد نوزاد است.

7-آلرژی و حساسیت کمتر علایم حساسیت در اطفالی که با شیر مادر تغذیه می شوند، در مقایسه با اطفالی که تغذیه مصنوعی دارند، کمتر دیده می شود. جدار روده در هفته های اول، زندگی نسبت به پروتئینهای خارجی مانند پروتئین شیر گاو قابل نفوذتر است و در نتیجه خطر پیدایش حساسیت در دوره شیرخوارگی از قبیل اگزما، اسهال، استفراغ و شوک و همچنین تظاهرات بادوامتر حساسیت، در اثر شیر در اطفالی که با شیر گاو تغذیه می شوند زیادتر است. احتمالا پاره ای از مردهای ناگهانی در روزهای اول زندگی به علت واکنش شدید به حساسیت به شیر گاو است.

۸- چاتی نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند، مطابق اشتهای خود، شیر مورد احتیاج را از سینه مادر دریافت میکنند. بنابراین احتمال نوشیدن شیر بیش از احتیاج نادر است. برعکس، نوزادانی که با شیر غیر مادر تغذیه می

شوند، اغلب اوقات مجبورند شیشه شیر را به اتمام رسانند که این خود عامل مهم در پرخوری و چاقی است و ممکن است سبب افزایش فشار خون، بیماریهای قلبی وعروقی، بیماری قند و غیره در آینده در این نوع کودکان شود.

۹- شیر مادر و جلوگیری از حاملگی عقیده بر این است که تحریک مکرر پستان در اثر مکیدن شیر، عامل مهمی در تولید و ترشح هورمونهای متعدد از جمله پرولاکتین واکسی توسین است و این هورمونها سبب قطع قاعدگی و تخمک گذاری می شوند. از این رو مادرانی که نوزادانشان را با شیر خود تغذیه می کنند، در مقایسه با آنهایی که به اطفالشان از شیر خود نمی دهند، کمتر در معرض خطر باروری ناخواسته قرار دارند.

مزایای دیگر شیر مادر مادرانی که نوزادشان را از شیر خود تغذیه میکنند، کمتر به سرطان پستان مبتلا می شوند همچنین شیردادن از طریق احتمال پیشگیری از بارداری و فاصله دادن به بارداریها در سلامت مادر مؤثر است و از تجلیل قوای مادر در اثر بارداریهای مکرر جلوگیری میکند. کودکانی که تغذیه مصنوعی دارند ممکن است دچار درهم فرورفتن و انسداد روده شوند در صورتی که شیر مادرخواران به علت یکنواختی لخته های شیر کمتر دچار چنین بیماری خواهند شد. شواهدی در دست است که نشان می دهد کودکانی که از شیر گاو تغذیه شده اند، در مقایسه ا شیر مادرخواران، احتمال دارد در سنین بلوغ، بیشتر به بیماریهای قلبی عروقی مبتلا شود.

نظر می رسد این اثر مربوط به نوع مرور شیر گاو باشد مدت و فاصله شیر دادن در مورد دفعات و مدت در بار مایه نوزاد باید از کار در مو فر و مایل را در نظر داشت زیرا نوزادان خود به خوبی می توانند در تعلیم مدت و فواصل نقلیه سوم مهمی معمولا نوزادان رسیده به وزن ۳ تا ۸۰/۳ کیلو گرم به خوبی برنامه ندایی هر چهار ساعت یک بار را می پذیرند، ولی بعضی از نوزادان ممکن است برنامه سه ماهه را بهتر تحمل کنند. در مورد نوزادان کم وزن و فارس که هر بار مقدار کمتری شهر می خورند، ماساه دو ساعت برای تغذیه در نظر گرفته می شود. نوزاد معمولا پس از یک بار بازیه کسانی در حدود سه تا چهار ساعت می خواند و تقریباً با شش تا هفت بار تغذیه در شبانه روز کاملا آرام و راضی خواهد بود. با این همه بهتر است فواصل تغذیه به دلخواه کودک تسلیم شود، نوزادانی را که بعد از هر وعده شیر خوردن بیش از چهار ساعت می خواننده بهتر است بیدار کرد و شیر داد نوزاد را باید به طور متناوب، هر بار به طور کامل، از یک پستان تقدیه کرد. این عمل باعث تحریک پستان و تولید شیر بیشتر می شود. مدت نظریه معمولا بیست دقیقه است. در مواردی که شیر یک پستان برای تغذیه نوزاد کافی نیست، می توان از هر دو پستان استفاده کرده بدین ترتیب که ابتدا کودک را به مدت دو تا پانزده دقیقه با یک پستان و سیسی به همان مدت با پستان دیگر شیر داد. پس از چند روزی که ترشح شهر به مقدار کافی رسید مجددا باید کودک را به طور متناوب هر بار از یک پستان تقدیم کرد. در صورتی که ترشح شیر زیاد باشد می توان از هر دو پستان در تغذیه نوزاد استفاده کرد تا تخلیه آنها به طور ناقص انجام گیرد و بدین ترتیب ترشح شیر کاهش یابد. باید دانست که مدت شیردهی در مورد نوزادان متفاوت است و بهتر است مدت هر وعده و و عده تغذیه به دلخواه آنان تنظیم شود. معمولا در کودک پس از دو ماهگی از برنامه منظمی پیروی هر خواهد کرد .

روش شیر دادن تغذیه نوزاد از پستان مادر، مستلزم تو جهات دقیقی است. در بعضی موارد عدم مو قدرت مادر در راه بینی نوزاد باز باشد. مادر هم باید با میل و و دست به فر بارش شور بدهد و بهتر است در حالت شیر دادن با پستان اکثراً به علت کمی شهر در پستان نیست، بلکه به علت اشکالات موجود در روش شیر دادن است. البته در هنگام تغذیه، نوزاد باید گرسنه و جایش خشک باشد و همچنین ووضع کاملا راحتی باشد. در این حالت، مادر با یک دست کودک را نگاه می دارد دست دیگر پستان را می گیرد. با استشمام بوی شوره کودک پسرش را بر می از داند، گونه از به پستان مادر تماس پیدا می کند و نوک پستان به آسانی در دسترس او قرار می گیرد و دهانش را برای مکیدن بار می کند.. نوزاد قسمت زیادی از نوک پستان را به دهان می برد و با فشار منظم فکها مادرانی که پستان بزرگ دارند، هنگام شیر دادن باید با انگشتان خود مانع شوند که پستان و حرکات زبان و لبها و با مکانیسم خاصی سبب تخلیه سینوسهای پستان می شود

بر روی بینی نوزاد قرار گرفته و راه تنفس او را ببندد. پس از هر وعده شیر خوردن باید هوایی که در ضمن مکیدن پستان بلعیده شده است خارج شود تا از درد معده و استفراغ شیرخوار جلوگیری شود، بنابراین مادر باید بعد از هر بار | تغذیه، شیرخوار را با تکیه دادن به شانه خود به وضع قائم نگه دارد تا به خروج هوای بلعیده شده کمک کند. گاهی اوقات خوابانیدن کودک روی شکم یا به طرف راست این عمل را آسان می کند. بعضی از شیرخواران بعد از تغذیه، مقدارکمی از شیر را بالا می آورند؛ اطلاع از این نکته برای مادران ضروری است. این امر در کودکانی که با شیر گاو تغذیه می شوند بیشتر از کودکانی است که از شیر مادر استفاده میکنند. این کودکان را باید به روی شکم یا به طرف راست خوابانید، زیرا اگر به پشت خوابیده باشند، ممکن است مواد استفراغ شده وارد مجرای تنفسی آنها شود و منجر به عوارض نامطلوب شود

تغذیه شیرخواران دوقلو در تغذیه دوقلوها، در شرایطی که شیر مادر کافی باشد، می توان از دو روش همزمان و متناوب استفاده کرد.

الف ـ روش همزمان در این روش مادر هر دو کودک را با دو پستان همزمان تغذیه می کند. به تجربه دیده شده است که این روش اثر تحریکی بیشتری در تولید شیر دارد. در این روش مادر، در جای راحتی می نشیند و در زیر بازوها یک یا چند بالش قرار می دهد. در این حالت مادر، کودکان را به ترتیبی نگه می دارد که سر هر یک در هر کف دست و پاهای آنها در دو سمت راست و چپ بدن قرار می گیرند. در مدت تغذیه باید در نحوه شیر خوردن هر یک از کودکان دقت کرد، زیرا یکی از دو قلوها ممکن است ضعیفتر باشد. در این صورت مدت بیشتری برای تغذیه او باید منظور شود. مدت هر وعده تغذیه، در این روش تقریبا بیست دقیقه است، ولی باز هم یادآوری می شود که این زمان در مورد هر کودک ممکن است متفاوت باشد؛ در حقیقت مدت شیر خوردن باید به دلخواه کودکان تنظیم شود.

ب - روش متناوب

در این روش مادر به مدت تقریبی بیست دقیقه یکی از کودکان را با پستان راست و سپس به مدت تقریبی بیست دقیقه کودک دوم را با پستان چپ تغذیه می کند.

در هر دو روش بهتر است هر یک از دوقلوها به طور نویش با هر دو پستان تغذیه شوند،

زیرا قدرت مکیدن در کودکان متفاوت است و به این ترتیب مسلماً پستانها بهتر تخلیه می شوند و ترشح شیر بهتر انجام می شود. در صورتی که شیر مادر برای تغذیه دوقلوها کافی نباشد، با روش جانشینی می توان آنان را تغذیه کرد که به دو حالت جانشینی متناوب و جانشینی کامل امکان پذیر است. در جانشینی متناوب، به تناوب شیر مصنوعی جانشین شیر مادر می شود. بدین ترتیب که مادر در یک نوبت یکی از دو قلوها را با هر دو پستان تغذیه میکند و به دیگری با بطری شیر می دهد و نوبت دیگر برعکس، جانشینی کامل زمانی است که مادر اساساً قادر به تغذیه دو قلوها از پستان نباشد که در این صورت آنها را با بطری تغذیه می کند.

چگونگی تشخیص کافی ؛ کافی بودن شیر مادر ن بهترین دلیل برای کافی بودن شیر مادر، سلامت، آرامش و رضایت کودک شیرخوار است که پس از تغذیه می خوابد، در ساعت بیداری آرام و با نشاط است و اجابت مزاجش طبیعی است. ولی و معتبر ترین معیار قضاوت در این مورد، افزایش منظم وزن شیرخوار است. بنابراین کمبود وزن به تناسب سن کودک و بی قراری او ممکن است به علت گرسنگی ناشی از کمی شیر مادر باشد. این کودکان معمولا دچار یبوست می شوند.

باید توجه داشت که مرطوب شدن لباس مادر بر اثر ترشح شیر در فواصل شیر دادن هیچ ارتباطی با زیادی مقدار شیر پستان ندارد. گاهی با مکیدن یک پستان از پستان دیگر هم شیر خارج می شود. این حالت عموماً در زایمان اول مادر و در هفته های اول شیردهی اتفاق می افتند که با تنظیم ساعات تغذیه کودک به تدریج بر طرف می شود.

شایان ذکر است که همیشه بی قراری کودک دلیل ناکافی بودن شیر مادر نیست، بلکه بعضی ازکودکان اساساً بیش از کودکان دیگر گریه میکنند و تنها به دلیل گریه، نمی توان آنان را گرسنه پنداشت و تغذیه آنها را با بطری آغاز کرد. موافقت با تغذیه مصنوعی باید با اکراه و پس از نیست، از آن استفاده شود، قبل از دستور تغذیه مصنوعی، لازم است وزن کودک را یک هفته بررسی کامل به عمل آید و فقط در موارد ضروری که مطمئنا تغذیه با شیر مادر امکان پذیر تحت نظر گرفت و با فواصل کمتره از پستان مادر به او شیر داد تا شاید مکیدن مکرر پستانه باعث ترشح شیر شود. در صورتی که شرایط تغذیه طبیعی واقعا فراهم باشد، باید باز هم کوشش کرد از شیر مادر ولو خیلی کم به شیرخوار داده شود. در این صورت تغذیه توام شیر مادر و شیرهای جانشین توصیه می شود.

موارد منع تغذیه با شیر مادر ا در مواقعی که تغذیه طبیعی برای مادر با نوزاد پی آمدهای بدی داشته باشد، ممکن است به طور | موقت یا دایم تغذیه با شیر مادر به بشهاد پزشک قطع شود. مثلا شقاق یا ترک خوردگی نوک | بستان، ابتلای مادر به پاره ای از عفونتهای حاد، التهاب و عفونت پستان از جمله موارد مم ، موقت و عفونتهای شدید و طولانی ومزمن، اختلالات روانی، تشنج و صرع از مواردی هستند و که موجب منع دایم تغذیه با شیر مادر می شوند. نا گفته نماند در موارد خاصی که نوزاد به علت نقص ساختمان دهان یا نارس بود

نمی تواند پستان را بمکد، باید پستان را دوشید تا هم از قطع ترشح شیر مادر جلوگیری شود و هم با مراقبتهای لازم بتوان نوزاد را تحت نظر پزشک با همان شیر تغذیه کرد. مراقبت ناکافی در هنگام تغذیه این قبیل نوزادان، ممکن است موجب ورود شیر در مجرای تنفسی و در نتیجه خفگی آنها بشود.

مواظبت و بهداشت پستانها در بهداشت پستانها باید از نوک آنها به دقت مراقبت کرد، زیرا به آسانی ممکن است میکروبها از نوک پستان به درون راه یابند و باعث آبسه پستان شوند. بر اثر عدم مراقبت کافی از پستان، ممکن است دهان نوزاد نیز دچار عفونت قارچی (برفک) شود. این آلودگی سبب پیدایش لکه های سفید

رنگ در داخل دهان نوزاد می شود. در موقع ماساژ و دست زدن به پستان، شستن دستها با آب و صابون، لازم و کافی است. برای نظافت نوک پستان بهتر است قبل و بعد از هر دفعه شیر دادن از آب جوشیده استفاده شود مادر شیرده باید از سینه بند مناسب استفاده کند و بهتر است یک تکه پارچه تمیز داخل سینه – قرار دهد تا شیری که از پستان تراوش می شود، جذب آن شود. تعویض و شستشوی مرتب سینه بند در جهت رعایت هر چه بیشتر نکات بهداشتی امری ضروری است .

از شیر گرفتن کودک از شیر گرفتن کودک معمولا زمان مشخصی ندارد. در مواردی که شیر مادر کم است با مادر تمایل | به ادامه شیردهی ندارد و از سوی دیگر امکانات لازم برای فراهم کردن غذای مناسب شیرخوار وجود دارد، به عبارت دیگر در شرایط مناسب بهداشتی و اقتصادی می توان از سس شش – ماهگی به تدریج شیر مادر را قطع کرد. باید توجه داشت که شیر مادر، منبع بسیار نیست،دادن شیر مادر تا هجده ماهگی یا دو سالگی، همراه با غذاهای موجود توصیه می شود از شیر گرفتن کودک باید به تدریج انجام شود. قطع ناگهانی شب، برای مادر و کودک مان پروتئینی است.

است مشکلات زیادی ایجاد کند. در مادران جوان که مقدار ترشح شیر زیاد است، قطع ناگهانی | شیردهی، باعث جمع شدن شیر در پستان و عراقب ناشی از آن می شود، همچنین سبب ناراحتی | و عصبانیت کودک شیرخوار می شود، به طوری که ممکن است از خوردن غذاهای دیگر نیز امتناع ورزد.

تغذیه مصنوعی (تغذیه با بطری) تغذیه مصنوعی به مواردی از تغذیه گفته می شود که به دلیلی شیرخوار از تغذیه با شیر مادر یا دایه محروم باشد (بهترین شیر بعد از شیر مادر، شیر دایه است، به شرطی که در انتخاب دایه دقت کافی شود و تمام نکات لازم در مورد شیردهی رعایت شود.) و یا قسمت اعظم تغذیه او از شیری غیر از شیر مادر تأمین شود. بدین منظور برای تغذیه شیرخوار باید از شیرهای مختلف استفاده کرد. اگر شیرخشک در اختیار شیرخوار نباشد، می توان با رعایت نکاتی، از شیر پاستوریزه با شیر تازه دام که اکثرا شیر گاو است استفاده کرد.

شیر پاستوریزه مناسبتر از شیر تازه دام برای تغذیه شیرخوار است. هدف از پاستوریزه

کردن شیر،کاهش تعداد میکروبهای موجود در آن و تغییراتی است که شیر برای شیرخوار گواراتر و سهل الهضم تر شود. شیر پاستوریزه را باید در یخچال نگهداری کرد و نباید بیشتر از ۴۸ ساعت بعد از تاریخ

تهیه نگهداری شود، زیرا تعداد قابل توجهی میکروب در آن مشاهده خواهد شد. شیر پاستوریزه را برای مصرف شیرخواران زیر یک سال باید مدت بیست دقیقه جوشانید و در مدت جوشانیدن، شیر را به هم زد تا از رسوب مواد پروتئینی و املاح در ته ظرف جلوگیری شود.

ارزش غذایی شیر پاستوریزه تقریباً دست نخورده است و همراه با قطره مولتی ویتامین تکمیلی در تغذیه شیرخواران محروم از شیر مادر می توان از آن استفاده کرد. گاهی شیر را پس از پاستوریزه کردن، هموژنیزه نیز می کنند. هضم این گونه شیرها به دلیل شکسته شدن گویچه های چربی به ذرات کوچک آسانتر است. شیرهای تازه دام قبل از مصرف حتماً بایستی حدود بیست دقیقه جوشانده شود و به تناسب سن کودک رقیق شود برای تغذیه شیرخوار تا ماه ششم، می توان با اضافه کردن یک قسمت آب جوشیده به سه قسمت شیر، این کار را انجام داد.

یادآوری می شود که با جوشانیدن شیر تازه گاو، میکروبهای آن کاهش یافته و با رقیق کردن آن، ترکیب اجزای شیر برای تغذیه شیرخوار مناسبتر می شود، با این حال ترکیب و نسبت اجرای آن تفاوت زیادی با شیر مادر دارد. گذشته از اختلاف اجزای مشترک در این دو شیر، وجود مواد مصونیت را فقط مخصوص شیر مادر است و در شیر گاو وجود ندارد. به همین جهت، تنها شیر مادر است که از بروز اسهال در شیرخواران تا حدود زیادی جلوگیری می کند.

از مقایسه ترکیبات شیر مادر با شیر گاو، که رایجترین شیر حیوانی برای تغذیه نوزاد | است و اکثر شیرهای خشک از آن تهیه می شود، چنین نتیجه گیری می شود که شیر مادر دارای | پروتئین کمتری نسبت به شیر گاو است و مقدار آن تقریبا یک سوم شیر گاو است. از نظر | قندی، شیر مادر دارای لاکتوز بیشتری نسبت به شیر کار است و از لحاظ املاح و مواد معلمی | شیر گاو غنبتر از شیر مادر است. همین تفاوتها در ترکیب شیمیایی شیر مادر با دیگر شیره موجب شده است که در مجموع شیر مادر را مناسبترین، کاملترین، سالمترین، طبیعیت اقتصادیترین غذا برای دوران شیرخواری دانسته و به عنوان شیر استاندارد برگزیده اند.

معایب شیر خشک ۱ - شیرخوارانی که از تغذیه مصنوعی استفاده میکنند از محاسن عاطفی شیر مادر محرومند. ۲- شیرخوارانی که از شیرخشک مخلوط با شیر مادر استفاده میکنند خیلی زود از شیر مادرمحروم می شوند. ۳- شیرخواران با تغذیه مصنوعی در مقایسه بـا شـیـر مـادرخواران بیشتر مبتلا به(مانند اسهال) و سوء تغذیه می شوند. ۴- شیرخواران با تغذیه مصنوعی به علت فقدان مواد مصونیتی و ترکیبات موجود در شیر گاو و شیرخشک بیشتر به عفونتهای گوارشی، گوش میانی و غیره مبتلا می شوند. ۵- تظاهرات آلرژی مانند آسم و اگزما در شیرخواران با تغذیه مصنوعی شایعتر است. ۶- تشنجهای ناشی از کمبود کلسیم (هیپوکلسمیک) در نوزادان و شیرخوارانی که از شیر گاه استفاده میکنند بیشتر مشاهده می شود. - مرگ ناگهانی در شیرخوارانی که با شیرخشک تغذیه می شوند شایعتر است.

لوازم مورد نیاز در تغذیه با بطری تغذیه با بطری به راحتی تغذیه از شیر مادر نیست و احتیاج به تعدادی وسایل، لوازم و امکاناتی به شرح زیر دارد:

الف - بطری: بطری شیر یا به اصطلاح شیشه شیر انواع مختلف دارد و بهترین آنها بطریهایی هستند که دهانه گشاد دارند و از شیشه نشکن و مقاوم به حرارت با پلاستیک مخصوص ساخته شده اند. این بطریها از نظر اندازه متفاوت اند و روی آنها اغلب درجه بندی شده است و برای هر نوزاد باید چندین بطری تهیه کرد.

سر پستانک درشت باشد و سوراخ آن نیز به اندازه مناسب و کاملا در وسط قرار گیرد. باز بودند ب - پستانک: پستانکها نیز انواع متعدد دارند و بهتر است نوعی را انتخاب کرد که دارای سوراخ پستانک باید به آن اندازه باشد که وقتی بطری محتوی شیر به طور معکوس نگه داشته شود، در هر ثانیه یک قطره شیر از آن بچکد. در صورتی که سوراخ پستانک خیلی کوچک باشد | می توان با یک سوزن که در شعله آتش سرخ شده باشد، سوراخ آن را گشادتر کرد. تعداد پستانکها باید تقریباً دو برابر تعداد بطریها باشد.

ابتدا بطریها و پستانکها را با شیشه شوی ج - وسایل تمیز کردن و ضدعفونی کردن بطری و پستانک: برای این منظور یک ظرف کاملا می شویند و تمیز میکنند، به طوری که ذرات شیر و سایر آلودگیهای آن کاملاً پاک شود. آنها را در ظرف بزرگی که تا نیمه آب دارد قرار می دهند و به مدت پنج تا ده دقیقه می جوشانند. پس از این عمل بطریها و پستانکها را به وسیله انبرک از داخل ظرف بیرون می آورند، خشک میکنند و در جای محفوظی به منظور استفاده های بعدی قرار می دهند. برای ضد عفونی و استریل کردن وسایل شیر کودک، از محلولهای ضد عفونی کننده نظیر هیپوکلریت نیز می توان استفاده کرد. برای هر لیتر آب یک قاشق مرباخوری از محلول هیپوکلریت اضـ میکنند و وسایل تهیه شیر را به مدت یک ساعت در آن قرار می دهند. محلول ضدعفونی کننده هر روز باید تجدید شود.

هر دفعات تغذیه با بطری در شبانه روز تعداد دفعات تغذیه کودک با افزایش سن کودک کم می شود. نوزاد سالم و طبیعی سه تا چهار ساعت یک نوبت شیر لازم دارد ولی نوزاد نارس و ضعیف هر دو تا سه ساعت باید تغذیه شود. در سه ماه اول تولد، تغذیه شیرخوار باید در طول ۲۴ ساعت انجام گیرد، لیکن به تدریج، آ ، آخرین وعده تغذیه شیرخوار را می توان بین ساعت ده تا دوازده بعدازظهر تنظیم کرد و کودک را تا ساعت شش یا هفت صبح روز بعد شیر نداد.

مقدار مصرف شیر در هر وعده تغذیه با بطری مقدار شیر لازم در هر نوبت برای سیر شدن در کودکان مختلف با یکدیگر متفاوت است.

همچنین تمایل کودک به خوردن شیر در هر نوبت در خلال ۲۴ ساعت نیز یکسان نیست، لذا آشنایی با میزان احتیاج کودک به شیر ضرورت دارد تا بتوان مقدار لازم و کافی غذا در اختیار برخوار گذاشت. با این حال توجه به جدول زیر نیز در این امر می تواند کمک کننده باشد.

طرز تهیه شیر از شیرخشک ابتدا براساس سن و وزن کودک یا آشنایی با مقدار شیری که در هر وعده می خورد، آب لازم (جوشیده ولرم) در بطری ریخته و سپس با پیمانه موجود در قوطی شیر، مطابق جدول راهنمای تغذیه که بر روی قوطیهای شیرخشک وجود دارد، به اندازه کافی پودر شیر، به آن اضافه می شود. بعد از قرار دادن پستانک روی بطری و تکان دادن بطری شیر به حدی که ذرات پودر شیر کاملا با آب مخلوط شود و به صورت مایع یکنواختی درآید و آزمایش درجه حرارت و سرعت خروج شیر از سوراخ پستانک، شیر تهیه شده برای تغذیه کودک آماده است.

روش شیردادن با بطری اصول کلی تغذیه با شیر مصنوعی مشابه تغذیه با شیر مادر است. طفل باید گرسنه و بیدار و مادر باید در وضع راحت باشد و بشاش، آرام و دور از اضطراب، طفل را برای تغذیه با بطری در آغوش بگیرد. ابتدا باید حرارت شیر یا مایعی که با شیشه به کودک داده می شود و سرعت خروج آن از پستانک امتحان شود. با چکاندن چند قطره از مایع درون شیشه به پشت دست، هم حرارت و هم سرعت خروج شیر از سوراخ پستانک امتحان می شود. حرارت مناسب باید در حدود ولرم باشد.

کودک را باید در حالت نیمه خوابیده در بغل گرفت و بطری را طوری در دست نگه داشت که پستانک پر از شیر باشد تا همراه شیر هوا وارد معده کودک نشود، پس از این که مقداری شیر خورده شد، باید بطری را از کودک گرفت، او را بلند کرد تا هوای بلعیده شده از معده اش خارج شود. اگر در حین شیرخوردن، مقدار زیادی هوا وارده معده کودک شده باشد ممکن است پس از تمام کردن شیر، مقدار زیادی از شیر همراه هوا به بیرون برگردد، بنابراین اگر کودکی کمی پس از شیر خوردن استفراغ کرد باید قبل از هر اقدامی به اندازه سوراخ پستانک و طرز شیردادن به او توجه و آن را تصحیح کرد. در مدت شیردادن باید مراقب طرز شیر خوردن کودک بود و هرگز نباید بطری شیر را در دهان کودک قرار داد و او را تنها گذاشت

اگر شیر در شرایط استریل تهیه شده باشد، باقیمانده آن را برای تغذیه وعده دیگر کودک می توان در یخچال نگه داشت، در غیر این صورت دور ریختن آن عاقلانه تر خواهد بود، بهتر است سعی شود مقدار شیر هر وعده در حدود اشتهای کودک تهیه شود.

خطرات استفاده از روشهای غلط در تغذیه مصنوعی

۱ـ مصرف حجم کم شیر (کمتر از نیاز شیرخوار) منجر به کاهش رشد و سوء تغذیه می شود

گرسنگی، یبوست و بی قراری را در شیرخوار به همراه دارد. ۲ – استفاده از حجم زیاد (بیشتر از نیاز شیرخوار) علاوه بر بروز عوارضی از قبیل استفراغ، اسهال، بالا آوردن بعد از شیر خوردن و ناراحتیهای گوارشی دیگر، منجر به چاقی نیز می شود. ۳- استفاده از شیرهای غلیظ (غلیظ تر از دستور تهیه شیرخشک باعث وارد آمدن فشار روی کلیه های شیرخوار به منظور دفع مقدار زیادی املاح می شود. اصولاً تغذیه با شیرهای غلیظ بسیار خطرناک است و می تواند باعث عوارض گوارشی، کلیوی، مغزی، کاهش در رشد شیر خوار و یا حتی مرگ شود.

۴- خوراندن شیرهای رقیق (رقیقتر از دستور تهیه) باعث سوء تغذیه می شود و کاهش رشد را به دنبال خواهد داشت. ۵- رعایت نکردن اصول بهداشتی در تهیه شیر منجربه بروز اختلالات گوارشی مانند اسهال و استفراغ و مسمومیت غذایی و بعضی از بیماریهای عفونی و انگلی می شود ۶- باید از مصرف شیرخشکهای مانده و تاریخ گذشته، آسیب دیده و با آنهایی که بعد از بازشدن در شرایط مناسب نگاهداری نشده اند خودداری شود (در قوطی شیرخشک را بعد از بازشدن و مصرف کردن باید محکم بست و در جای خنک و خشک نگهداری کرد). ۷- بهتر است از اضافه کردن مو د غذایی و دارویی به شیر درون بطری، بدون مشورت با پزشک خودداری شود

تغذیه کمکی شیر عم از شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی غذایی کافی و کامل برای کودک در ماههای اول بعد از تولد است اما پس از ماههای سوم و چهارم، تغذیه کودک با مواد غذایی دیگر نیر ضروری است. زیرا از یک طرف مقدار کالری مورد نیاز کودک بیشتر می شود و اگر بخواهد تمام آن را از تامین کند، ناچار است از نظر حجم مقدار زیادی شیر بخورد که این امر گاهی موجب اشکال | و از طرف دیگر بعضی از مواد از قبیل ویتامین D ، آهن، فلوئور و غیره در شیر مادر و | اکثر شیرهای خشک کم و لازم است از مواد غذایی دیگر برای تامین احتیاجات کودک استفاده | شود. از نظر روانی نیز شروع مواد غذایی دیگری به جز شیر مادر و با شیر خشک برای مادر و | کودک هر دو بسیار لذت بخش و سرگرم کننده است. نکات کلی که باید در تغذیه مواد غذایی - به جز شیر در نظر گرفته شوند عبارتند از:

مواد غذایی چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع باید به تدریج به غذای شیرخوار اضافه شود. ۲- از یک نوع غذای ساده شروع شود و تدریجا به مخلوطی از چند نوع افزایش یابد. ۳- از مقدار کم شروع (یک قاشق مرباخوری) و به تدریج بر مقدار آن افزوده شود. ۲ـ بین اضافه کردن مواد غذایی مختلف حدود ۵ تا ۷ روز فاصله لازم است تا شیرخوار به غذای اول عادت کند و بعد غذای جدیدی به او داده شود. اضافه کردن یک به یک و فاصله دار مواد

غذایی باعث می شود که الف ـ اگر ناسازگاری به یک ماده غذایی وجود داشته باشد، شناخته شود. ب - غذا با مقادیر و نوع محدود، تحمل شیرخوار را به تدریج افزایش می دهد و به دستگاه گوارش او فرصت می دهد تا عادت کند. د. غذاها در شروع باید نسبتاً رقیق بوده و غلظت کمی بیشتر از شیر داشته باشند و سپس تدریجاً بر غلظت آنها افزوده شود. ضمناً اگر در شروع تغذیه تکمیلی، شیرخوار به غذای خاصی بی میلی نشان داد پافشاری نکنید. برای یک تا دو هفته، آن غذا را از برنامه حذف و سپس مجدداً به غذای وی اضافه کنید. ۶ـ شیر مادر به تنهایی تا پایان چهار تا شش ماهگی برای شیرخوار کافی است. لیکن بعداز این سن بایداز غذاهای کمکی استفاده شود، ویتامینهای A و D و همچنین آهن را باید به صورت قطرات خوراکی در اختیار شیرخوار قرار داد.

۷- بهتر است غذای شیرخوار به مقدار کم و برای یک وعده تهیه شود. مگر این که امکان ماندن غذا، نگه داری آن در یخچال حداکثر تا ۲۴ ساعت اشکالی ندارد. برای نگه داری بیش از نگه داری غذای اضافی باقی مانده در یخچال یا فریزر وجود داشته باشد. در صورت باقی ۲۴ ساعت، باید غذا را در ظرف تمیز کوچکی که محتوی یک وعده غذاست ریخت و در فریزر قرار داد. ضمناً غذای شیرخوار را فقط به مقدار مصرف یک وعده بایستی گرم کرد و به او خورانید.

برخی از انواع غذاهای کمکی مناسبترین غذاها برای تغذیه تکمیلی، غذاهایی هستند که:

۱- دارای انرژی کافی و حجم کم باشند (مواد چربی، شکر و غلات) آنها آسانتر باشد.

۲- نرم و هضم ۳- تازه و بدون آلودگی باشند و در شرایط بهداشتی تهیه شوند. ۴- در دسترس، ارزان و مناسب عادات غذایی خانواده باشند. د. امکان استفاده از آنها حجم کم و در دفعات مکرر میسر باشد.

در مواد غذایی به جز شیر که برای کودک شیرخوار می توان توصیه کرد عبارتند از: ۱- آرد غلات: برنج، گندم، جو و ذرت را می توان پس از مخلوط کردن با آب و یا شیر بخت و به صورت حریره از ماه سوم به بعد به رژیم غذایی کودک اضافه کرد و روزی یک تا سه بار به جای یک وعده شیر به کودک خورانید.

آرد غلات در عین حال به صورت پخته شده با نامهای تجارتی مختلف وجود دارد مزیت آنها در این است که تهیه آنها احتیاج به پختن ندارد و مواد دیگری از قبیل ویتامینها نیز به آنها افزوده شده است.. برای تهیه خریره از این آرد غلات آماده، کافی است مقداری از آرد را به آب و یا شیر اضافه کرد تا حریره آماده در اختیار کودک قرار گیرد. در صورت تمایل می توان مقدار کمی شکر نیز به آن افزود تا طعم شیرینتری داشته باشد. باید توجه داشت که بعضی از آردهای غلات آماده فقط از یک نوع علة تهیه شده است و برخی مخلوطی از غله های مختلف هستند. ضمناً برخی از آنها قبلا با شیر مخلوط تهیه شده است. بهتر است در اوایل از آرد غله هایی که فقط از یک غله تهیه شده است استفاده شود و هر چند روز یکی از غلهها امتحان شود تا اگر کودک نسبت به یکی از آنها عدم تحمل نشان داد مشخص شود. بعدها در صورتی که کودک تک تک غلات مختلف را به خوبی تحمل کند، می توان از آرد غلات مخلوط استفاده کرد.

۲- سوپ: تهیه سوپ برای اغلب مادران کار آسانی است و از ماههای سوم و چهارم به بعد تغذیه کودک با آن را می توان شروع کرد. در اوایل تغذیه بهتر است از سوب بدون گوشت و بعداً با گوشت بدون چربی مانند سوپ ماهیچه که مقداری مواد دیگر از قبیل برنج، حبوبات و سبزیجاتی چون هویج و سیب زمینی به آن اضافه شده است استفاده کرد و عصاره آن را به کودک خورانید. پس از ۶ ماهگی مواد موجود در سوپ را به شرط رنده و نرم کردن آنها،

می توان مورد استفاده قرار داد. روزانه یک تا دوبار تغذیه با سوب به عنوان یک وعده غذا معمولا کافی ۳- میوه و آب میوه: آب میوه های مختلف از قبیل آب پرتقال، آب لیموشیرین و آب سیب را می توان به مقادیر کم (۳ تا ۲ قاشق مرباخوری در روز) از ماههای سوم و چهارم شروع کرد و به تدریج مقدار آن را افزایش داد. در صورت تمایل، می توان کمی شکر به منظور شیرین شدن به آن اضافه کرد. چنانچه کودک نتوانست آب میوه ای را تحمل کند لازم است تا مدتی غذایی او حذف کرد. از ماههای پنجم و ششم به تدریج می توان خود میوه را نیز نرم و له کرد و به مقدارک به کودک خورانید. مصرف میوه به شکل کمپوت مگر در شرایط خاص چندان مناسب نیست زیر برخی از مواد به ویژه ویتامینها در جریان تهیه کمپوت از بین می روند، بنابراین مصرف میوه و یوه تازه برتری دارد.

۲- تخم مرغ از ماههای پنجم و ششم می توان تخم مرغ را به غذای کودک اضافه کرد در چند ماه اول بهتر است فقط از زرده تخم مرغ استفاده کرد و آن را به صورت عسلی یا سفت، به تنهایی و یا مخلوط با سایر مواد غذایی به کودک خورانید. تغذیه روزانه نیم تا یک زرده تخم مرغ را معمولا کودک به خوبی تحمل میکند و مشکلی برای او به وجود نمی آید. د. سایر غذاها: از ماههای پنجم و ششم به تدریج بر حسب تمایل و تحمل کودک

می توان مواد غذایی مختلف از قبیل بیسکویت، ژله، پوره سیب زمینی و غذاهای مختلف دیگری برای کودک تهیه کرد. بعد از شش ماهگی به تدریج غذای کودک شبیه غذای خانواده می شود به طوری که در یک سالگی سه وعده غذای کودک مانند غذای خانواده است و در فواصل آن، شیر، میوه و یا آب میره منظور می شود.

فصل دهم

رشد و نمو طبیعی در کودکان

اطلاع از چگونگی رشد و تکامل کودکان، دست اندرکاران تعلیم و تربیت را قادر می سازد تا کودکان را به رشد و تکامل طبیعی و سالم رهبری و آنان را به شیوه نیکوتر و مطلوب تربیت کند، لذا این فصل از کتاب نگرش کوتاهی است بر رشد و نمو طبیعی در کودکان و ارائه راه حلهای ممکن در تأمین رشد و تکامل بدنی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی آنان .

حیاتی و پیشرفت عکس العملهای مختلف بافتها، اعضا و اندامها را مشخص و تغیرات تأثیر محیط نیز قرار دارد بیان می کند. به بیان دیگر، نمو را به افزایش تدریجی اندازه بدن و اندامهای آن می توان اطلاق کرد و رشد را به افزایش شخصیت اجتماعی و عاطفی فرد را که خود تحت مهارتها و تواناییهای جسمانی و عقلایی کودک باید مربوط دانست. بنابراین رشد و تکامل را می توان سلسلۀ ظرفیتها و استعدادهای گسترش یابنده ای دانست .

تو جوانی تبدیل می شود. یعنی سستی و ناتوانی کودک به نیرومندی و استواری و الفاظ نامفهوم که به تدریج برای فرد مایه سهولت و کارکرد بیشتر و مؤثرتر می شود. مانند حرکتهای سست و خام کودکان در دوران کودکی که رفته رفته بر اثر رشد به مهارتهای سریع و شگفت انگیزی در او به بیان اندیشه های معقول و سنجیده تکامل می یابد و یا کودک نابالغ همچون زن و مرد پخته و ورزیده ای جلوه میکند که می تواند فرزند به وجود آورد، مسئولیتهایی انجام دهد و خانواده خود را اداره کند. در نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که رشد و تکامل عبارت است از همه تغییرات و

تحولاتی که از زمان تشکیل سلول تخم تا به هنگام مرگ انسان روی می دهد و سلسله تغییرات پی در پی یا متوالی است که برای رسیدن به هدف واحدی انجام میگیرند و آن هدف، تکمیل ویژگیهای رشد و تکامل و عوامل مؤثر در آن رشد و نمو انسان دارای خصوصیاتی است که در روند آن بسیار مؤثر است. نمی توان با االطمینا و یقین گفت که کدام یک از این خصوصیات مهمتر از دیگران است ولی سعی میکنیم که تا حدی رعایت اهمیت آنها را بکنیم و آنرا که مهمتر به نظر می رسد مقدم قرار دهیم. این ویژگیها عبارتند از:

- رشد با الگویی معین توأم است. – در رشد عکس العملها ابتدا جنبه عمومی دارد و سپس اختصاصی می شود. – رشد جریانی مداوم است.
- اختلافات فردی در فرآیند رشد، کمابیش ثابت است. – تکامل قسمتهای مختلف بدن به مقدار متفاوت حاصل می شود.
- رشد را می توان پیش بینی کرد.
- هر مرحله ای از تکامل دارای مشخصاتی مخصوص به خود است. – هر فردی معمولا تمام مراحل تکامل را طی میکند.

کیفیت و کمیت رشد متأثر از شرایط و عواملی است که می توان آنها را در دو دسته عوامل وراثتی و محیطی تقسیم بندی کرد.

ستگی ندارد. شوید به عبارت بحث محیط می توان به محیط درونی بدن از قبیل هورمونهای ترشح شده از عدده تغییرات باخته ای و کیفیت کارکرد دستگاههای بدن، محیط طبیعی مانند آب و هوا،

وراثت در حقیقت انتقال یک عده خصایص زیستی از والدین به فرزندان است. این ام ممکن است به صورت رنگ چشم، مره پوست، گروه خون، شکل، قامت و بر طاهر دیگر خصایص موروثی آنهایی هستند که ظاهر شدن آنها به یادگیری و مدیریت در مسکن وخوراک، محیط اجتماعی نظیر خانواده، مدرسه و جامعه اشاره کرد. امروزه این واقعیت پذیرفته شده است که تفکیک تأثیر عوامل ارثی و محیطی در مطالعه رشد و تکامل آدمی غیر ممکن است زیرا هر دو در رشد و تکامل انسان با یکدیگر همکاری دارند و می توان گفت که ورانت و محیط در حکم دو بعد (طول و عرض) مربع مستطیل هستند که بدون یکی از آنها، شکلی به نام مربع مستطیل نخواهیم داشت. به عبارت دیگر، متخصصان وجود دارد.

رشد و تکامل در سالهای اخیر به این نتایج رسیده اند که بین عوامل ارثی و عوامل محیطی در رشد و تکامل رفتار آدمی، تعامل با تأثیر ممتقاب اشتباه محض است که یکی از آن دو دسته عامل را مهمتر تصور کنیم – وراثت ماده خام خصایص بشر را آماده می سازد و محیط به وسیله تغذیه، پرورش و یادگیری، حمایت و تحریک، آن را به صورت مجموعه رفتارهای معینی در می آورد – چون وراثت و محیط در طول زمان در رشد و تکامل رفتار فرد اثر می گذارند بنابراین می توانیم رشد و تکامل را به صورت فرمول زیر خلاصه کنیم رشد و تکامل رفتار موجود زنده = وراثت × محیط × زمان

بنابراین تمام صفات جسمانی و روانی، نتیجه کنش متقابل و دایمی دو عامل ارثی و محیطی هستند. این موضوع نه تنها در مورد یک سلول با یک عضو یا اندام، بلکه به طور کلی برای نوع انسان، با همه جامعیت خویش، مصداق دارد.

دوره های مختلف رشد کودکان روان شناسان رشد کودک، همواره با این پرسش مواجه بوده اند که آیا به طور کلی می توان زندگی | انسان را به مراحل و مقاطع معینی تقسیم کرد؟ و آیا خصایص و مشخصات رفتار در هر یک از | این مراحل، کاملا روشن و قطعی هستند؟ با توجه به اینکه رشد و نمو یک عمل مداوم و | پیوسته است لذا اغلب روانشناسان و متخصصین از تقسیم آن به دوره های مختلف خودداری | می کنند. لیکن بعضی از روانشناسان و فیزیولوژیستها برای تسهیل در مطالعه و شناخت | ویژگیهای رشد کودکان از زمان انعقاد نطفه تا پایان دوره کودکی و آغاز نوجوانی، دوره های زیر را |مورد توجه قرار داده اند الف ـ دوران پیش از تولد (از انعقاد نطفه تا زمان تولد) ب - دوران شیرخوارگی (از بدو تولد تا پایان دو سالگی) ج - دوران کودکی اولیه (از ۳ تا ۶ سالگی)

د ـ دوران کودکی ثانویه (از ۷ تا ۱۲ سالگی)

الف ـ رشد در دوران قبل از تولد از لحظه ای که باروری انجام می گیرد یعنی اسپرم مرد با تخمک زن تمامی پیدا می کند و با هر یکی می شوند، موجود تازه ای پیدایش می یابد و زندگی این موجود به صورت تخم آغاز

می شود تجارب آزمایشگاهی نشان داده است که زیگوت (تخم) حدود سی ساعت بعد از لقاح به مرحله دو سلولی می رسد و چهل تا پنجاه ساعت بعد از باروری تقریباً چهار سلولی می شود

زیگوت در ضمن تقسیم از داخل لوله های رحمی میگذرد و وقتی که به مرحله دوازده تا شانزده سلولی می رسد (روز سوم یا چهارم) به شکل دانه توت است و به نام مورولا خوانده می شود که به صورت توده ای از پاخته های کوچک موسوم به بلاستومرها در می آید (شکل ۱). هنگامی که مورولا به تقسیمات خود ادامه می دهد، در یافت آندومتر رحم نیز تغییراتی به وجود می آید. ترشح غده ها به حداکثر خود می رسد و مجرای رحم پر از مواد ترشحی سلولهای غدد می شود. در اثر نفوذ مواد ترشحی غدد رحم به داخل توده مورولا، رفته رفته در بین بلاستومرها فضایی که توسط این مواد ترشحی پر شده است ایجاد می شود. در نتیجه گروهی بلاستومرها به کنار رانده می شوند و گروهی دیگر از آنها در یک نقطه به صورت یک توده تجمع پیدا می کنند. در این حالت مورولا، ساختمان یک انگشتر نگین دار را به خود می گیرد و به نام بلاستولا خوانده می شود.

حفره ای که در داخل بلاستولا قرار دارد و درون آن مملو از مایع است، بلاستوما سلولهایی که قسمت حلقه انگشتر را تشکیل می دهد تروفوبلاست، سلولهایی که به صورت تودهای، قسمت نگین انگشتر را به وجود می آورند امپریوبلاست و مجموعه این توده یاخته ای که بیشتر به کیسه ای شباهت دارد، بلاستوسیست نامیده می شود. تا آخر هفته اول تکامل زیگوت انسان دوران مورولا و تشکیل بلاستوسیست را گذرانیده، در عین حال طول لوله رحم را پیموده است و لانه گزینی خود را در مخاط رحم شروع میکند.

قسمت آن یعنی تروفوبلاست و امبریوبلاست، هر یک در جهت مخصوص به خود نمایر و در عرض هفته دوم و سوم تکامل، بلاستوسیست در مخاط رحم فرو می ودر | خصص می یابد. سلولهای تروفو بلاست عمیقا در اندومتر فرو می روند و تشکیل جفت می دهند که اعمال مهم و حیاتی، تنفس، تغذیه و تصفیه جنین را بر عهده دارد. استا تشکیل پرده های کوریون، آمنیون و بندناف که جفت را به جنین متصل می سازد نیز مربوط به این - یاخته هاست. برد: امنیون محتوی مایعی به نام مایع آمنیوتیک است که حالت محافظ دارد و لایه بنیادی جنین یعنی اکتودرم، مزودرم و اندودرم را ایجاد می کنند. فرایندهای تبدیل بلاستولا به جنین سه لایه زاینده را، گاسترولاسیون و خود جنین را در این مرحله، گاسترولا می نامند.

اکتودرم خارجیترین لایه جنینی است که سیستم عصبی، اندامهای حسی، اپیدرم و ضمایم آن و همچنین دهان اولیه را تشکیل می دهد. در نتیجه تمایز سلولهای اندودرم، تیروئید،کبد، پانکراس، دستگاه تنفسی، لوله گوارش غدد براقی تشکیل می شوند. مزودرم که در بین دو لایه فوق تشکیل می شود، منشأ جنینی انواع بافت پیوندی، چربی، صلانی، استخوانی، هیپودرم است . سیستم قلب و عروق، دستگاه سازنده خون و لنف ، طحال و بالاخره درم و می دهند و در آنها تمایز یاخته ای صورت می گیرد. یعنی در هر بخش به تدریج بافتها و اندامها .. بعد از تشکیل کامل این سه لایه، یاخته های هر بخش از چنین به تکثیر خود ادامه ه می شوند. این دوره از نمو جنینی، اندام زایی (ارگانوژنز) نامیده می شود و در انسان در حدود سه ماه به طول می انجامد. در پایان دوره اندام زایی، جنین شکل طبیعی خود را پیدا

بدین ترتیب تقریباً در انتهای ماه سوم بارداری، چنین کاملا شبیه یک آدم تکامل یافته میکند و به صورت موجود انسانی مشخص می شود.

فقط سرش نسبت به بقیه قسمتهای بدنش بزرگتر است. در نوزاد تقریبا یک دوم قد او را وسیله گوشیهای تشکیل می دهد و حرکات دست و پاها نیز قابل مشاهده است. پلکهای چشم و ناخنها شکل گرفته و پسر یا دختر بودن جنین نیز قابل تشخیص است. ضربان قلب به مخصوص و دقیق قابل تشخیص است. چنین در سه ماهگی حرکت می کند ولی مادر این حرکات را معمولا حس نمی کند (شکل ۲). در اواخر ماه چهارم، فعالیتهای حرکتی چنین افزایش می ی یفتر می شود و مادر این حرکات را به خوبی احساس می کند.

در حدود پنج ماهگی، پوست بدن شکل طبیعی خودش را به دست می آورد و بسیاری از بازتابها مانند مکیدن انگشت، بلعیدن و سکسکه کردن مشاهده می شود. در این دوره، مو، ناخن، غدد عرقی و مویی که تمام بدن را می پوشاند به وجود می آید. در پنج ماهگی صدای قلب جنین توسط گوشیهای مخصوصی به خوبی شنیده می شود. اگر چنین در این ماه به دنیا آید، به علت ناکافی بودن رشد ریه ها، بعد از چند ساعت از بین خواهد رفت. در حدود شش ماهگی، چشمها کاملا شکل گرفته اند و پلکها باز و بسته می شوند به علت آنکه دستگاههای عصبی و تنفسی چنین در این مرحله رشد کافی نکرده اند چنانچه جنین در این ماه به دنیا آید معمولا زنده نخواهد ماند

در حدود هفت ماهگی، حواس چشایی، بینایی و شنوایی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده است. از آنجایی که دستگاههای عصبی، گردش خون و تنفسی جنین به مرحله ای از رشد رسیده که او را برای زندگی خارج از رحم آماده کرده است، چنانچه جنین در این ماه به دنیا آید، می توان آن را تحت شرایط خاص و با مراقبت کامل بهداشتی در داخل دستگاه رحم مصنوعی در حدود هشت ماهگی، جنین نسبت به ماه قبل رشد بیشتری دارد و طبق آمارهای موجود از هر سه نوزادی که در این ماه متولد می شوند، دو نفر آنها با مراقبت کافی بهداشتی نام انکوباتور، زنده نگه داشت.

در تغذیه خوب، زنده می مانند. ر آخرین ماه حیات نوزاد (نهمین ماه حاملگی) نوزاد حداکثر رشد و نمو خود را انجام داده است و کلیه اندامهای جنین آماده اند تا مستقلاً کار خود را شروع کنند که این امر با تولد نوزاد عملی می شود. زمان تولد نوزاد تقریباً ۲۶۶ روز بعد از زمان بارداری و یا ۲۸۰ روز (چهل هفته) از ابتدای آخرین خونریزی ماهانه پیش از بارداری است. در حدود ۷۵ درصد نوزادان با ۱۰-۱۵ روز اختلاف از این تاریخ حساب شده متولد می شوند.

مشخصات نوزادان سالم و طبیعی نوزاد طبیعی و سالم که تمام ماههای بارداری مادر را به طور کامل سپری کرده باشد معمولا ۳ تا ۵/۳ کیلوگرم وزن دارد و دارای ۴۸ تا ۵۲ سانتی متر قد است. اندازه دور سرش ۳۳ تا ۳۵ سانتی متر و از نظر شکل و قواره شبیه به یک انسان عادی است.

برای ارزیابی میزان سلامت نوزاد در دقایق اول ولادت، روشهای چندی وجود دارد که در زمینه های مختلف می توان با استفاده از این راهها، وضعیت عمومی، عصبی و رفتاری نوزاد را باز شناخت و در جهاتی آینده نگری کرد. یکی از معمولترین و ساده ترین این روشها روش ارزیابی ایگار است که در فاصله یک و پنج دقیقه پس از ولادت با بررسی پنج نشانه مستقل حیاتی نوزاد، یعنی تعداد ضربان قلب، وضعیت تنفس، تونیسیته عضلات، رفلکسهای | ابتدایی حرکتی و رنگ پوست نوزاد و منظور کردن شماره ای بین صفر و دو برای هر یک از این | نظر مشخص علایم و سپس جمع نمرات پنجگانه، عدد یا نمره ایگار نوزاد را در دقیقه مورد میکنیم. نوزادان طبیعی و سالم در این ارزشیابی، نمره ای بیش از هفت کسب می کنند (نمره ۱۰ بالاترین نمره در این معیار محسوب می‌شود.)

در مورد آنچه نوزادان طبیعی و سالم پس از تولد انجام می دهند باید گفت اگر نوزاد را به شکم بخوابانیم، می تواند سر خود را به یک طرف بگذارد و به طرف دیگر نیز بچرخاند. او معمولا بازوهایش را خم میکند، پاهایش را به زیر شکم خود می برد و در نتیجه کفلش بالا قرار می گیرد. اگر در حالی که دست خود را به زیر شکم نوزاد قرار داده ایم، نوزاد را بلند کنیم، سر نوزاد به طرف جلو و پایین خم می شود. اگر چنین نوزادی را بنشانیم سر او به طرف پایین و جلو خم می شود و به شکل یک توده گرد درخواهد آمد زیرا عضلات نوزاد قدرت حفظ حالت و وضع طبیعی را ندارد. نوزاد مکرراً دست و پای خود را دراز و بعد جمع می کند. چشمهای خود را در مقابل نور می بندد ولی اگر او را در حالت عمودی نگه داریم چشمهایش را باز میکند. صداهای ناگهانی منجر به چشمک زدن و همچنین حرکات ناگهانی نوزاد می شود ولی اگر صدا دایمی باشد، هیچ حرکتی به خود نمی دهد. اکثر نوزادان در هنگام تولد می شنوند، بو و مزه را - میکنند، انگشت دست خود را می مکند ولی توجهی به محیط خود یا شخص مادر ندارند. علاوه بر رفلکسهای معمول، نوزادان دارای تعدادی رفلکسهای خاص نیز هستند که در | کودکان بزرگتر دیده نمی شود. از میان آنها رفلکس جستجو، مکیدن، مورو و چنگ زدن را که دارای اهمیت بیشتری هستند می توان نام برد.

رفلکس جستجو، بدین گونه است که اگر جسم نرمی از قبیل نوک پستان و یا نوک انگشت با گونه نوزاد تماس پیداکند وی سرش را به سمت آن بر می گرداند. این رفلکس در پیدا کردن نوک پستان برای نوزاد در هنگام شیرخوردن اهمیت خاص دارد زیرا در صورتی که نوک پستان در ا

اطراف دهان باشد نوزاد سرش را به آن طرف می گرداند تا نوک پستان در مقابل دهان وی قرار |

رفلکس مکیدن، همچنانکه از نامش پیداست بدین گونه است که اگر جسمی از قبیل نوک پستان، پستانک یا انگشت در دهان نوزاد قرار داده شود وی بلافاصله شروع به مکیدن آن میکند.

اهمیت این رفلکس در هنگام شیرخوردن کاملا واضح است. رفلکس مورو ، بدین گونه است که اگر سر نوزاد روی تنه خم شده و یکباره رها شود ویا صدای شدیدی در اطراف وی ایجاد گردد و یا بستر وی یکباره تکان بخورد وی بلافاصله دست

و پای خود را جمع میکند. این رفلکس یک حالت دفاعی بدن است. و بالاخره در رفلکس چنگ زدن، اگر . جسمی در کف دست نوزاد قرار داده شود وی آن را برای مدت چند ثانیه به صورت چنگ زده نگه می دارد. وجود رفلکسهای نوزاد مؤید تندرستی، به خصوص سلامت دستگاه عصبی مرکزی، محیطی و عضلانی وی است که در هنگام معاینه نوزاد توسط پزشک، بررسی می شود و حایزاهمیت فراوانی است.

ب - رشد در دوران شیرخوارگی

اگر چه نوزاد انسان قابلیتهای بسیاری برای سازگار شدن با محیط دارد و می تواند ببیند، بشنود، نسبت به بو و مزه واکنش داشته باشد و نسبت به درد، لمس و تغییرجا از خود حساسیتهایی نشان دهد، ولی چگونگی استفاده از این تواناییها را به تدریج یاد میگیرد و در مقابله با مسائل توانا می شود. در ابتدای تولد، نوزاد در انجام کارهای ارادی سخت ناتوان است و بسیاری از کارهای او از . راه بازتابهای ساده انجام می گیرد. نوزاد با برخی احتیاجات جسمی اساسی به دنیا می آید.

جوابگویی به این نیازها و مراقبت از نوزاد برای حفظ تعادل محیط داخلی بدن او ضروری است.

بسیاری از احتیاجات از جمله اکسیژن، خواب، تنظیم دمای بدن به طور منظم و طبیعی تنظیم می شوند ولی بعضی دیگر مانند غذا، احتیاج به مداخله مستقیم اطرافیان دارد. مشخصه اولین سال زندگی کودک، رشد جسمانی سریع اوست. کودکان سالمی که خوب تغذیه شده اند، از تولد تا یک سالگی پنجاه درصد بر قدشان و تقریباً دویست درصد به وزنشان اضافه می شود. بعد از سال اول زندگی، از سرعت رشد کاسته می شود و به دنبال آن افزایش قد و

وزن تا زمان نوجوانی، حالت یکنواخت و تقریباً خطی دارد . بسیاری از تغییرات دوران کودکی دست کم تا اندازهای ناشی از رسش یا نضج است .

رسش عبارت است از توالی همگانی عوامل بیولوژیکی در دستگاه عصبی مرکزی که زمینه را برای ظاهر شدن عملکردی روان شناختی آماده می کند. رسش به تنهایی نمی تواند باست برد

خصوصیتی روان شناختی شود بلکه صرفا محدوده زودترین هنگام بروز آن را تعیین می کند...

توانایی کودک در نشستن، ایستادن و راه رفتن نمونه هایی از تأثیر رسش در رشد است رشد شناختی در سال اول زندگی در قلمروهای مختلفی بروز می کند که از میان آنها چهار قلمرو اهمیت خاصی دارند. اولین آنها ادراک است. کودک خردسال می تواند اشیا و کیفیات آنها مانند رنگ، عمق و شکل را ادراک کند. کودکان خردسال به خصوص به حرکات، تضاد و تغییر در اندازه یا وضعیت فضایی اشیا نگاه میکنند. دومین ترانایی شناختی تشخیص اطلاعات است کودکان قادرند محرکتایی را که به هم شباهت دارند ولی یکسان نیستند تشخیص دهند، مانند تصاویر تکراری از یک چهره که از زوایای مختلف دیده می شود. سومین توانایی شناختی، رده بندی است. به عنوان مثال، در یک سالگی کودکان احتمالا اشیا را برحسب رنگ رده بندی میکنند، با انواع غذاها را با هم در یک گروه قرار می دهند و آنها را از مواد غیر خوراکی مجزا میکنند. چهارمین توانایی شناختی کودک در سال اول زندگی افزایش حافظه است کودکان خردسال می توانند محرکی را که قبلاً دیده اند تشخیص دهند و همچنان که بزرگتر می شوند محرکی را نیز که قبلا با فاصله زمانی طولانیتری دیده اند تشخیص خواهند داد. ضمناً قادرند اموری را که مربوط به زمان حال نیست و همچنین اطلاعاتی درباره چیزهایی که در گذشته تجربه کرده اند به خاطر آورند.

در شش ماه دوم زندگی، درکودکان ترسهای خاصی ایجاد می شود. غالباً از غریبه ها می ترسند و هنگامی که مراقبی آشنا از آنان جدا می شود، دچار اضطراب و ناراحتی می شوند. به نظر می رسد که رسش و در نتیجه آن ایجاد تواناییهای شناختی در شروع ترسهای مختلف دخالت داشته باشد.

پس از پایان سال اول، رفتار کودک اختصاصیتر می شود و سال دوم زندگی از نظر رشد اجتماعی اهمیت بسیاری پیدا میکند. در این سن،کودک، از یک طرف، تواناییهایی به دست آورده است که دوست دارد آنها را به مرحله اجرا بگذارد و از طرف دیگر – او به بزرگسالان هنوز قابل توجه است. کودک در این سن باید ضمن احساس امنیت و آرامش در محیط، بتواند به راحتی احساسات و تمایلات خود را نشان دهد تا تدریجاً استقلال و اتکای به نفس در او رشد کند.

سخنگویی از جمله مهارتهای جنبشی کودکان به شمار می آید و اکثر آنان از یک سالگی به بعد زبان را برای بیان خواستها و نیازهای خود به کار می برند. هر چند که بعضی از آنان تا دو سالگی هم قادر به سخن گویی نیستند. برخلاف رشد مهارتهای حسی و حرکتی، که بیشتر از رشد طبیعی کودک متاثر است، توانایی سخن گفتن به تحریکات محیطی و انگیزه های مناسب باز دارد. اطرافیان کودک باید او را یاری دهند تا مرحله گریه و زاری را پشت سر گارد سخن گفتن را آغاز کند. صحبت کردن مادر با کودک از همان ماههای اول زندگی، در رشد گی کودک و به وجود آوردن تحریکات مختلف حسی از جمله شنوایی بسیار موثر است .

بازیهای کودک در دو سالگی بسیار ساده و براساس فعالیتهای حسی و حرکتی است و کردی فقط با مهره ها بازی می کند. لذت و خوشحالی او از تکرار و تقلید اعمال است. طبیعی است که در این سن، قانونی نیز بر فعالیتهای کودک حکمرما نیست و در واقع، بازی نوعی تقلید و تکرار الگوهای رفتاری و بانوعی رفتار حرکتی است، بدون هیچ گونه آگاهی از قوانینی که بر بازی | حاکم است. در این سنین کودک دوست دارد که بیشتر تنها با با یک بزرگتر آشنا بازی کند ولی کم کم به تماشای بازی بچه های دیگر و همبازی شدن با آنها علاقه مند میشود.

در این دوران والدین باید ویژگیهای کودک را بشناسند و او را با تمام طرافتهایش درک کنند. کودک ضمن این که عزیزترین و نزدیکترین کس به پدر و مادر است، موجودی مستقل نیز خاص خود را دارند. شناخت این ویژگیها به بزرگسالان کمک میکند تا به نحوی منطقی با کودک هست. به علاوه دنیای کودکان با دنیای بزرگسالان متفاوت است و هر کدام از کودکان ویژگیهای برخورد و روند رشد و تکامل طبیعی وی را تسهیل کنند.

ج - رشد در دوران کودکی اولیه

با وجود این که رشد جسمی کودک در این دوره به سرعت دوران شیرخوارگی نیست ولی سرعت قابل ملاحظه ای دارد که وی را برای تجربه و یادگیری بیشتر آماده میکند و به تدریج که بزرگتر می شود به شبکه پیچیده تری از تجارب دست می یابد. از حواس خود هر چه بیشتر استفاده میکند و با راه رفتن با محیطی گسترده و متنوع روبرو می شود. برخلاف دو سال اول زندگی، رفتار کودک کمتر قابل پیش بینی است. زیرا از این پس تجارب محیطی و تأثیری که این تجارب بر او می گذارد، تعیین کننده مسیر رشد کودک است.

دندانهای شیری میان دو تا سه سالگی تکمیل می شود و کودک را در استفاده از غذای بزرگسالان، هر چه بیشتر یاری می دهد. دندانهای شیری یکی از بهترین عوامل تغذیه و در نتیجه رشد و نمو کودک در حساسترین دوره زندگی اوست. کودکی که دندانهای پوسیده و ناسالم دارد، نمی تواند غذا را خوب بجود و در نتیجه دچار سوء هاضمه می شود. پوسیدگی و عفونت دندانهای شیری ممکن است عفونت و بیماریهای مختلفی در کودک ایجاد کند. بنابراین، لازم است از دو سالگی، هر شش ماه یک بار، کودک را تحت معاینه و کنترل بیماریهای دهان و دندان قرار داد. قدرت به کار گرفتن مؤثر اشیا در حدود سه ، سالگی به وجود می آید. قدرت تجسم و تخیل کودک بیشتر شود و دیگر مانند کودک دو ساله در موقع بازی کردن با مکعبهای چوبی آنها را بی هدف به این طرف و آن طرف نمی اندازد، بلکه این قطعات را به شکلهای مختلف روی هم می چیند و از آنها خانه و برج می سازد و یا با پشت سر هم قرار دادن آنها، قطار درست میکند. کودک در این سن بسیار فعال و پر جنب و جوش است و از فعالیت لذت می برد. بدن

بسیار انعطاف پذیر و برای بازی و فعالیت آماده است. در این دوره نیز فراهم کردن فرصتهای مناسب برای جنب و جوش، فعالیت و بازی از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی این حرکات باید زیر نظر بزرگسالان انجام شود و کودک ساعتها به حال خود واگذار نشود. کودکان این سن نیاز به غذا خوردن یا استراحت را تشخیص نمی دهند و به علت تمایل به حداکثر فعالیت، در هر بازی به دوره های متعدد استراحت نیاز دارند. بنابراین باید قبل از این که کاملاً خسته و بهانه گیر شوند موقعیتهایی برای استراحت و غذا خوردن آنها فراهم کرد و یا این که بعد از فعالیتهای شدید، برای آنها فعالیتهای آرام در نظر گرفت. بسیار عادی است کودکان بر سر گروههای بازی کودکان معمولا کوچک است و چندان سازمان یافته نیست و به سرعت تغییر می کند. کودکان این سن مرتب از فعالیتی به فعالیت دیگر می پردازند و این کار برای آنها ، نزاع بین کودکان بسیار کوتاه است و به سرعت فراموش می شود. دعوای اسباب بازی هنوز هم غیر طبیعی نیست و گاهی اجتناب ناپذیر می شود. در این گونه موارد بهتر است اجازه داده شود که کودکان، خود مسائلشان را حل کنند و اگر بزرگسالان ناچار از مداخله شوند بهتر است توجه کودک را به چیز دیگری جلب کنند. برای کودکان این گروه رشد پویایی در این دوران بسیار سریع است. کودک در سه سالگی حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه، در چهار سالگی حدود ۲۰۰۰ کلمه و در شش سالگی - ۲۵۰ کلمه می داند و می فهمد اگر کودک به کودکستان برود خزانه لغات او از این هم غنیتر می شود. به طور کلی کودکانی که امکان سنی، می توان مسئله را با گفتگوی صمیمانه و آرام حل کرد. صحبت کردن با کودکان بزرگتر از خود را داشته باشند یا بتوانند از رادیو و تلویزیون استفاده کنند با امکان بیشتری برای گفتگو با بزرگسالان را داشته باشند، دامنه لغات وسیعتری پیدا می کنند. با رشد قوه تخیل کودک، علاقه او به قصه های تخیلی و گاه جعلی افزایش پیدا میکند. کودکان در این مرحله به خلق داستانهای عجیب و غریب می پردازند و گاهی قسمت عمده وقت خود را صرف بیان ماجراهای خیالی میکنند. این قبیل داستانها در رشد قوه تخیل کودک تأثیر بسیار دارد و نباید در استفاده از آنها برای کودکان تردیدی داشت. آمادگی کودکان برای شنیدن قصه های تخیلی بستگی به رشد عاطفی آنها دارد، ولی بعضی از کودکان در این زمینه افراط میکنند. در این گونه موارد، آشنا کردن کودکان با قصه ها و داستانهای واقعی نیز لازم است یادگیری در دوره کودکی اولیه برای کودکان جالب و همراه با تفریح است و هر آن چیزی را که به حال خود سودمند تشخیص دهند به آموختن آن گرایش پیدا می کنند. محیط، انواع وسایل بازی، پدر و مادر، اطرافیان و به طور کلی زمینه های سالم و سازنده در امر یادگیری مؤثر واقع می شوند. کودکان این گروه سنی، عواطف خود را به طور آشکار ابراز میکنند. بروز ناگهانی خشم و ترس در این کودکان بسیار عادی است. خسم در این سنین، زمانی بیشتر دیده می شود که کودک خسته با گرسته باشد و یا با مداخله بیش از اندازه بزرگترها روبرو شود. اگر این نکات مورد توجه واقع شود می توان تا اندازه زیادی خشم آنان را تخفیف داد. به هر حال، کودک در طول چند سال در کنترل خود در می آورد. کودک تا قبل از سن مدرسه، معمولا ناراحتی و خشم خود را به اول زندگی و تا حدود سن ورود به مدرسه، روش غلبه بر خشم خود را به مرور می آموزد وصورت گریه ظاهر می کند، ولی بعد از ورود به مدرسه به تدریج یاد می گیرد که ناراحتی خود را کودکان در این مرحله به علت روبرو شدن با موقعیتهای بسیاری که بیشتر آنها تیر تازگی به گونه های دیگر بیان کند.

غیر منطقی است ولی ممکن است در زندگی ایند: آنها مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین قراردادن دارد و به دلیل قوه تخیل فعال، ممکن است ترسهای زیادی داشته باشند. بسیاری از این ترسها کودکان در موقعیتهای ترسناک، با این استدلال که دیگر بزرگ شده اند و یا مسخره کردن آنها به علت و حشت از چیزهایی که برای بزرگسالان مادی است، کاملا غیر عاقلانه است. حسادت کودکان در این سن بسیار طبیعی است. فراوان دیده شده است که تولد یک نوزاد

جدید در خانواده و توجه والدین و سایر بستگان به او، حسادت کودک را برانگیخته است. کودکی که تاکنون تنها فرزند با کوچکترین فرزند خانواده و مرکز توجه والدین بوده است با تولید برادر با خواهر تا مدتی دچار اشکالات رفتاری می شود و گاه این مشکلات به صورت واکنشهای امیر معقول و حتی تهاجم به نوزاد جدید خود را نشان می دهد و گاه موجب شب ادراری و یا مشکلات عاطفی دیگر می شود. هوشیاری پدر و مادر و توجه طبیعی به کودک بزرگتر تا اندازه زیادی به حل مشکل کمک می کند و باعث می شود که این حسادت به مرور از بین برود مخصوصاً بدر می تواند سامانی را که مادر مشغول مراقبت از کودک تازه وارد است، به کودک بزرگتر توجه بیشتری داشته باشد

لکنت زبان در بین کودکان بسیار شایع است و بیشتر در بین پسرها و در سنین دو تا پنج سالگی دیده می شود. لکنت زبان به صورت اختلال در آهنگ کلمات، مکث کردن در بیان کلمات، تکرار و کشیدن صداها و یا تبدیل صداها و صداهای جانشین مشخص می شود و کلمات به صورت بریده ادا می گردد. بیشتر کودکان در حضور جمع و به خصوص در مدرسه با در حضور افراد غریبه وضع دشوارتری دارند و به عکس، هنگام تنهایی با هنگام سرود خواندن و همنوایی با دیگران اشکالی در تکلم ندارند.

برای درمان لکنت زبان، مخصوصا لکنت زبانی که به علت اضطراب و ناراحتیهای کودک د آمده باشد، باید توجه زیادی به کودک معطوف شود و سعی بر این باشد تا کشمکشها و ناراحتیهای کودک، تا آنجا که ممکن است، از بین برود. به وجود احساس امنیت عاطفی یکی از مهمترین عوامل رشد رضایتبخش کودک است. احساس امنیت از طریق محبت کردن به کودک و تأیید او حاصل می شود. کودک باید احساس کند که صمیمانه دوستش دارند و او را به عنوان یک فرد تأیید میکنند. کودک در صورتی می تواند نگرشی مثبت و پایدار نسبت به زندگی داشته باشد که محبت و تأیید پایدار و یکنواختی از طرف افراد خانواده دریافت کند. حتی تنبیه به موقع کودک نیز نباید این احساس را در او ایجاد کند که دیگر هرگز دوستش نخواهند داشت و با او را طرد کرده اند. بلکه باید احساس کند که به علت عملی که انجام داده تنبیه می شود نه به علت خستگی پدر و مادر یا عصبانیت آنها که قابل ذکر دیگر این که کودکان در اواخر این دوران علاقه مند به طر جریزی)

مسئولیت پذیری و انجام دادن فعالیتهای اجتماعی نیز هستند. کودک در هیچ دوره ای این چنین آماده یادگیری سریع و پذیرفتن فعالانه مسئولیت نیست. کودک علاقه مند است و می تواند با | همکاری کودکان دیگر و توجه بزرگسالان به ساختن چیزهایی بپردازد یا برای ساختن و | طرح ریزی به کودکان دیگر بپیوندد. همین طور مایل است از بزرگسالان نیز به عنوان سرمشقی مطلوب استفاده کند.

رشد در دوره کودکی بعدی این دوره از نظر روان شناسان، ستین گرایش به دسته و گروه است. دوره ای که کودکان به مسئله پذیرفته شدن در گروه و تأیید از جانب اعضای دسته و گروه توجه زیادی می کنند. همچنین بسیار تلاش میکنند تا خود را از نظر ظاهر، گفتگو و رفتار با دسته وگروه همسالان خود تطبیق دهند به همین جهت روان شناسان، این دوره را سن همانند سازی نامگذاری کرده اند. مطالعات جدید درباره خلاقیت نشان داده که اگر کودکان در این دوره با موانع محیطی با استهرای بزرگسالان و همسالان روبرو نشوند، می توانند انرژی خود را در جهت فعالیتهای خلاق سوق دهند. از این رو روان شناسان این دوره را من خلاقیت نیز نامگذاری کرده اند، دوره ای که در آن معلوم خواهد شد که کودک در آینده خلاق و مبتکر یا دنباله رو و پیرو خواهد بود. البته پایه و شالوده روحیة خلاق در دوره کودکی اولیه ریخته می شود ولی به طور کلی توانایی برای استفاده از آن برای فعالیتهای ابتکاری در دوره کودکی ثانویه به وجود می آید. همچنین این دوره از دیدگاه روان شناسان، سن بازی نیز نامگذاری شده است، نه به این علت که این دوره در مقایسه با مقاطع ستی دیگر (خصوصاً کودکی اول) بیشتر به بازی اختصاص پیدا می کند، زیرا زمانی که کودکان وارد سن مدرسه می شوند میزان بازی آنها در مقایسه با دوره قبل کمتر می شود، بلکه این نامگذاری از آن جهت است که فعالیتهای بازی در این دور، بسیار متنوع است و گسترش زیادی پیدا می کند. بازیهای این دوره هم خصوصیات دوره اولیه و هم ویژگیهای دوره نوجوانی را دارد. نابراین، به طور کلی می توان گفت که این دوره از رشد نیز مانند هر مقطع دیگری حائز اهمیت بسیار است.

اهمیت آن بیشتر از این جهت است که خصوصیات رشد در این دوره در مقایسه با مقاطع دیگر، نمودی مثبت و سازنده دارد و این پیشرفت و سازندگی هم برای والدین و هم برای معلمان و مربیان کودک آشکار است. کمیت یا نگه داری ذهنی است در این دوره زمینه روانی و شناختی فرد طوفیت جدیدی پیدا میکند که عبارت از تبت است. قبل از این دوره خصوصیات و مشخصات اشیا (اعم از فیزیکی و هندسی) برای او وضع ثابتی ندارند ولی کودک در این دوره، براساس عملیات منطقی مینی ثبات و دوامی به دنیای خارج می بخشد و ملاگهای ثابتی در ساخت فکری او به وجود می آید | بنابراین منظور از نگه داری ذهنی این است که اگر ظاهر اشیای خارجی (از جهات مختلف) کند، وضع آنها در ذهن کودک ثابت می ماند و او چنین تشخیص می دهد که این اشیای به ظاهر تغییر کرده همان اشیای سابق هستند و فرقی نکرده اند. کودکان در این دوره به لحاظ شناختی داری توانایی دیگری میشود که به آن طبقه بندی می گویند. زمانی که از طبقه بندی صحبت می شود منظور منطق جزء وکل است که در این دوره به سهولت در کودک یافت می شود. این توانایی به کودک امکان می دهد که اجزا را در کل باشیم که رنگها و شکلهای مختلف داشته باشند، طفل قادر به طبقه بندی آنها نیست و تنها آنها را دوره کودکی اولیه این نوع طبقه بندی وجود داخل سازه و یا برعکس اجزا را از کل جدا کند. در ندارد زیرا به کار بردن منطق جزء و کل ممکن نیست. مثلاً اگر اشیایی به شکلهای گوناگون داشته به شکل توده هایی طبقه بندی میکند. یعنی او تابع شکل قضایی مجموعه ای است که طفل با این اشیا تشکیل داده است. هنوز نمی توان منطقی در آن مشاهده کرد. اما در دوره کودکی ثانویه اشیای مختلف را برحسب شکل و یا رنگ به راحتی طبقه بندی میکند و از نوعی منطق که به آن منطق عملیاتی می گویند در طبقه بندی اشیا استفاده میکند. کودک در این دوره قادر می شود چیزها را به شیوه های مختلفی طبقه بندی کند. شکل رنگ و اندازه از عمومیترین راههای طبقه بندی در نزد کودکان است. البته کودکان همچنین قادرند که مجموعه ای از این سه را نیز با هم به کار برند و در عین حال قادرند که براساس کاربرد، جنس و ... نیز به طبقه بندی اشیاء بپردازند. بدیهی است که هر چه سن کودکان افزایش پیدا کند شیوههای طبقه بندی کودکان نیز متنوعتر می شود.

درک مفهوم فضا و مکان در این دوره به نحو بارزی تجلی می یابند. کودکان بسیار زود از جای اشیا و وسعت و فاصله آنها تصوری به دست می آورند. دست زدن به اشیا و راه رفتن و سرین حواس به یاری اصطلاحات خاص مانند چپ و راست و بالا و پایین و مانند آن وضع اشیا را در فضا روشنتر می سازد. در دوره کودکی اول، فضا و مکان کودک در محدوده ادراک حسی قرار دارد. یعنی فضا و مکان را به صورت عینی درک میکند و هنوز قادر نیست از آن درک ذهنی داشته باشد. اما در دوره کودکی دوم، کودک به تدریج آماده می شود که مفهوم مکان را بسیار گسترده تر از دوره قبل، و نه فقط به صورت محسوس، درک کند.

. درک مفهوم فضا و مکان در این دوره به نحو بارزی تجلی می یابند. کودکان بسیار زود از جای اشیا و وسعت و فاصله آنها تصوری به دست می آورند. دست زدن به اشیا و راه رفتن و تمرین حواس به یاری اصطلاحات خاص مانند چپ و راست و بالا و پایین و مانند آن وضع اشیا را در فضا روشنتر می سازد. در دوره کودکی اول، فضا و مکان کودک در محدوده ادراک حسی قرار دارد. یعنی فضا و مکان را به صورت عینی درک میکند و هنوز قادر نیست از آن درک ذهنی داشته باشد. اما در دوره کودکی دوم، کودک به تدریج آماده می شود که مفهوم مکان را بسیار گسترده تر از دوره قبل، و نه فقط به صورت محسوس، درک کند. بعد از دوران کودکی اول، مفاهیم اخلاقی نزد کودک بسیار گسترده تر و وسیعتر مطرح می شود در حالی که در آن دوران، مفاهیم اخلاقی معانی محدود و معینی دارند و قابلیت گسترش و تعمیم ندارند. کودک در این مرحله در قضاوت اخلاقی خود تنها به اعمال و پیامدهای ظاهری رفتار توجه نمی کند بلکه به انگیزه ها و نیتها و احساسات و دیدگاههای دیگران در رفتاری که از آنها صادر شده توجه میکند و اهمیت می دهد.

کودک همچنان که در هر دوره رشد می کند، ویژگیهای معینی از لحاظ عاطفی پیدا می کند که او را با دوره های قبل یا بعد متفاوت می سازد. یکی از تفاوتهای مهم کودک در این دوره با دوره کودکی اول این است که او یاد می گیرد چگونه واکنشهای عاطفی و هیجانی خود را کنترل کند، چیزی که در دوره کودکی اول کمتر وجود دارد. البته این کنترل در محیط بیرون از خانه بیشتر رعایت می شود و در محیط خانه کمتر نیازی به کنترل عواطف و هیجانات خود می بیند می شود. تصور کودک از خویشتن روشنتر می شود و مقام و موقعیت خود را بهتر درک می کند به طور کلی در این دوره از جوش و خروشها و سبکسریهای کودکی محض کاسته در حالی که به جهان گسترده تری گام می گذارد، به تدریج فاصله اجتماعی او از مادرش افزایش می یابد. در نتیجه افراد بیشتری وارد زندگی او می شوند. میکوشد روی پای خود بایستند، از این رو موفقیتهای وی بیشتر به کوششهایش بستگی پیدا می کند. شخصیت کودک در تماس با دیگران تغییر شکل پیدا میکند و روابطش با افراد توسعه می یابد. از ویژگیهای مهم این دوره، روحیه همکاری گروهی و در عین حال رقابت کودکان با یکدیگر است.

نیازهای اساسی کودکان

نیازهای اساسی در سنین کودکی که در جهت تأمین رشد و تکامل طبیعی کودکان اهمیت و و ضرورتشان شناخته شده است عبارتند از:

1-نیاز کودک به محبت والدین اگر کودک از این نیاز لازم محروم و یا از وجود آن در والدین مشکوک باشد احساس ناامنی میکند و دچار هیجان و نگرانی می شود و عوارض مختلفی چون حسادت، سرکشی، خشم و حتی دشمنی با خواهر و برادران خود با شعاع وسیعی زمینه وجودش را فرا می گیرد. واکنشها و احساسات انسانیش جریحه دار می شود و می اندیشد که او قادر به ایجاد حسن تفاهم و ارتباط با دیگران نخواهد بود و سرانجام به صورت موجودی خشک و سرد و بی مهر به جامعه می پیوندد.

2-نیاز کودک به احساس امنیت این مرحله زیربنایی برای ایجاد مراحل بعدی تکامل انسانی است. نیاز به امنیت برای کودک در احساس راحتی جسمی و به حداقل رساندن عوامل مزاحم در ساختمان زمینه های تکاملی وی نقشی بارز دارد که تأمین این نیاز تنها در سایه ارتباط صمیمی والدین با کودک میسر است.

2- نیاز کودک به درک شخصیت فردی و دریافت ارزش و احترام از جانب دیگران چون کودکان از نظر جسمی، روحی، هیجانی با افراد بالغ اختلاف دارند و محدود کردن آنها در کردار، آمال و علاقه مندیها به روح حساسشان لطمه می زند پدر و مادر باید صمیمانه و به تدریج آسانی و گاهی به اشکال صورت می گیرد.

کرد و برعکس نباید راه تمایل منطقی وی را به خاطر مسیر فکری والدینش منحرف کرد. او شخصیت، استعداد، تمایل، علاقه، درک و دریافت مستقل و مشخصی دارد که قابل احترام و فقط محتاج به رهبری و کمک است. کودک بدون ذوق موسیقی را نباید بنابه میل پدر و مادر نامناسب برای شاگرد اولی بیش راند زیرا نتیجه ای جز خستگی و آشفتگی روحی وی در بر پشت پیانو خسته و آزرده کرد، یا کودک با استعداد متوسط را زیر مهمیز تحریک و تشویق

نخواهد داشت.

۲- نیاز کودک به ارزشیابی و خودشناسی کودک نیاز دارد که قدر و ارزش خود را بفهمد. علاقه مند است که مشکل خود را درک کند و در کارش موفق شود و از پیروزی خود لذت برد. تحقیر، این نیاز را سرکوب میکند و برایش عقده حقارت می سازد. کمرو، خجالتی، گوشه گیر و منزویش میکند و گاهی ممکن است زمینه عصیان و سرکشی وی را فراهم آورد و ناسازگارش کند. کودک بدرفتار را اگر هر روز با خواهر خوش رفتارش مقایسه و با لحن تحقیرآمیز از این مقایسه نتیجه گیری کنیم حسادت و کینه خواهر خوش رفتار نیز بر این ناسازگاری مزید می شود. در بین سه کودک که یکی موفق و سرافراز، دیگری نسبتا خوب و سومی ضعیف است بدون مقایسه تحقیرآمیز آنها بیشتر باید به تشویق سومی پرداخت تا به جبران ضعف خود نائل شود. اگر آن کس که به کار تربیت اطفال علاقه مند است به این نکته وقوف یابد که اطفال در دنیای خود دارای احساس درکی ظریف و لطمه پذیرند بسیاری از عوارض رفتاری زمان بلوغ بروز نخواهد کرد.

۵- نیاز کودک به احساس کاردانی و ابتکار در سنینی که کودک خود را در می یابد و به جمع گرایی تمایل پیدا میکند و از بازی با همسالانش لذت می برد، هرگاه با امر و نهی های کاذب و غیر منطقی والدین و اطرافیان مواجه شود، قدرت | ابتکار و خلاقیت وی آسیب می بینند و ممکن است اعتماد به نفس وی برای تمام عمر کاهش یابد و از بین برود.

۶- نیاز کودک به درک و رهبری شدن نیاز طبیعی کودک آن است که والدین او را درک و به سرگرمیها و تفریحش توجه و در بازی با او | ومشغولیاتش شرکت و در بسیاری از فعالیتها او را راهنمایی کنند. والدینی که سخت به کار خود فرو رفته اند و مجال چنین کارهایی را ندارند، به این نیاز کودک توجهی نمیکنند و ناخواسته * | نیاز طبیعی کودک پاسخ نمی دهند و موجب آزردگی و آشفتگی انفعالی درونیش می شوند.

را می پیماید نیاز مبرم به ۷- نیاز کودک به داشتن استقلال و آزادی عمل استقلال خواهی در روحش بیدار می شود و بال و پر می گیرد. او احساس می کند که باید برپای به همان سرعتی که طفل رشد می کند و مراحل رسیدگی چه توجه به نیاز واقعی استقلال دوستی کودک، از تکامل و پرورش وی در راه رسیدن به این نیازها خود بایستند و با درک شخصیت خود انسانی مستقل شود. متاسفانه بسیاری از والدین بدون غفلت و گاهی جلوگیری می کنند. این امر موجب می شود استقلال خواهی، اندیشه آزاد خودشناسی و جهان شناسی کودک محدود بماند و هنگامی که مرد زندگی شد نه تنها خود از این مطلب آزرده و غمگین خواهد شد بلکه در پیشبرد و تعالی خانواده و اجتماع خود نیز آنچنان که

باید و شاید سهمی نخواهد یافت.

۸- نیاز کودک به شخصیت یا بی شخصیت یابی و استقلال خواهی کودک دو رکن اساسی در رشد اجتماعی مطلوب وی به شمار می روند. کودک به آموختن قوانین خانه،کوچه، مدرسه و اجتماع نیاز دارد. این آموزش اجتماعی باید به آرامی و با وضع صحیح و استواری در روح کودک جایگزین شود و با رشد او قوام و رسیدگی یابد. در رسیدن به این هدف والدین خود باید دارای شخصیتی استوار و متین و از وقار و انضباط کافی برخوردار باشند و با آرامش و صبر لازم نقش تعلیمی خود را ایفا کنند. والدین در حالی که به استقلال خواهی کودک احترام می گذارند و او را در چارچوب مشروط و معقول هدایت میکنند، زمینه شخصیت سازی وی را نیز باید با دانایی و صداقت و حمایت و تأنی بیشتری رهبری کنند.

۹- نیاز کودک به سعی و کوشش و بالندگی در سنینی که کودک دوره دبستان را می گذراند و به شکلهای مختلف آموزش می بیند، هنوز به خوبی محیط زندگی و جهان را نشناخته است، لذا به درک قوانین و کاربرد آنها و مسائل پیرامون خود علاقه مند است و گاهی با آنها به رقابت برمی خیزد. از این رو اگر در این کودک در انجام کار مفیدی احساس شوق و نشاط نکند و یا به علت عدم توفیق، در اندوه ناشی از احساس حقارت و شرم فرو رود، به سرعت می تواند تحت تأثیر راهنمایی و برخوردهای مناسب والدین یا دیگر اطرافیانش از این حالت خارج شود و آثار نامطلوب آن را از ضمیرش پاک کند و در نتیجه | بنیادهای ثابت اخلاق و رفتارهای مطلوب را در ذهن خود استوار سازد.

۱۰- نیاز کودک به درک و آموزش تدریجی انضباط برای دستیابی به سایر نیازهایش توجه به ضرورت انضباط و نظم در رشد طبیعی کودک، مسئله ای بسیار جدی است. درخانواده با کودک چنان باید رفتار شود که کودک ضمن قبول نظم و منطق، امر و نهی والدین خود را با احترام و اعتماد بشنود و به کار بندد تا قادر باشد در سایه نظم و انضباط و فرمانبرداری از والدین از شخصیت و رشد اجتماعی معقول در همه زمینه های زندگی برخوردار شود.

تأمین رشد و نمو طبیعی در کودکان به لحاظ عوامل محیطی شماری که در چک روند رشد و تکامل افراد بعد از تولد دخالت دارند، اینک به ذکر نکاتی می پردازیم که در تامین رشد و تکامل بدنی، ذهنی، اجتماعی وعاطفی کودکان کمک مؤثری هستند.

الف ـ رشد و تکامل بدنی رشد و نموبدنی عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحی که به طور مداوم انجام می گیرد هرگاه بدن نقص قطری نداشته باشد و نیازهای رشد به طور کامل و سالم ارضا شوند، عمل با فرایند رشد و نمو به طور طبیعی و عادی انجام خواهد گرفت و می توان انتظار داشت که کودکی در هر یک از مراحل رشد و تکامل، ویژگیهای آن مرحله را دارا باشد.

نقایص بدنی، چگونگی تغذیه، وضع اقتصادی - اجتماعی خانواده، کار کردن در شرایط نامساعد، خواب و استراحت، ورزش و تفریح، فشارهای عاطفی و اختلال در کار غدد از جمله عواملی هستند که بر رشد و تکامل بدنی کودکان تأثیر دارند.

برخورداری کودک از غذای کافی و مناسب، توجه به بهداشت و سلامت کودک، توجه به خواب و استراحت کافی، در نظرگیری تفریحات سالم برای کودک و تأمین آرامش خاطر وی از جمله مسائلی هستند که والدین باید در جهت رشد و تکامل بدنی فرزندان خود مورد توجه قرار دهند. در محیطهای آموزشگاهی نیز دقت نظر در مواردی چون، توجه به اعمال و کنشهای بدنی شناخت تفاوتهای موجود در میزان رشد، توجه و مواظبتهای فردی در رشد و تکامل بدر دانش آموزان بسیار سودمند خواهد بود. به علاوه توجه و به کارگیری نکات زیر توسط معلمین مدارس، آنان را در این مهم ممکن است کمک مؤثری بکند.

- معلم باید در آغاز سال تحصیلی شخصاً یا با همکاری کادر بهداشتی شده و قدرت بینایی و شنوایی دانش آموزان را اندازه گیری کند و این عمل را هر یک یا دو ماه تکرار که و در صورت مشاهده هرگونه اختلال فورا به والدین دانش آموز اطلاع دهد تا نسبت به درمان آن اقدام شود.

کلاس درس باید همیشه تمیز و پاکیزه باشد و نور کافی در آن بتابد.

- در هر درس باید فعالیتهای گوناگون برای باروری هر چه بیشتر حواس دانشی امورترتیب داده شود راهنمایی کند.

- معلم باید با اصول بهداشت مدارس آشنا باشد و دانش آموزان را به رهایت آنها - فعالیتهای ورزشی طوری در برنامه منظور شوند که به رشد بدنی دانش آموزان کمک تکالیف دانش آموزان در حد تواناییهای آنان تعیین شود. - فرصتهای مناسب برای رشد مهارتهای گوناگون برای دانش آموزان فراهم شود.

- در تنظیم جدول ساعات درس، اصول روان شناسی و آموزش و پرورش مراعات - وسایل اولیه بهداشت در اختیار دانش آموزان قرار گیرد. محیط مدرسه و کلاس، نشاط انگیز و مشوق باشد.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که چون رشد و تکامل بدنی با رشد سایر جنبه های وجود انسان کاملا بستگی دارد، بنابراین باید فعالیتهایی را برای کودکان در نظر گرفت که نیازهای عاطفی، فکری و اجتماعی آنان را به طور هماهنگ و همزمان ارضا کنند.

ب - رشد و تکامل ذهنی منظور از اصطلاح عقل در روان شناسی جدید، مجموعه اعمال معنوی یا درونی انسان است. " بنابراین در مطالعه رشد و نمو عقلی، استعدادهای حفظ کردن، تخیل، زبان، ادراک، تصورات و استعداد حل مشکلات و مسائل مورد بحث قرار می گیرند. همانگونه که افراد بشر از لحاظ شکل، قد، نیرو و سایر صفات و ویژگیها با هم متفاوتند، میزان و کیفیت هوش آنان نیز با همدیگر تفاوت دارد، یعنی عده ای پرهوش، گروهی کم هوش واکثریت متوسط هستند روان شناسان درباره علتهای این تفاوتهای هوشی مطالعات و آزمایشهای متعددی انجام داده و عواملی چون، وراثت و محیط، رشد بدنی و بهداشت، سن، جنس، نژاد و ملیت، وضع اجتماعی - اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، وجود محرک و یادگیری را در آن مؤثر دانسته اند برای اینکه کودک از استعداد ذهنی سالمی برخوردار شود و بتواند از استعداد عقلی طبیعی خویش بهتر استفاده کند، باید خانواده و مدرسه با یکدیگر صمیمانه همکاری کنند و این همکاری در صورتی سودمند خواهد بود که والدین و معلمین، خود از تربیت سالم بهره مند برای کمک به ظهور و پرورش استعداد عقلی کودک قبل از مدرسه باید توصیه های زیر را به کار بست - خانه به صورت محیط شناخت و تجربه اندوزی و تربیت محبت آمیز درآید. - هیچگونه مانع عاطفی (مشاجره والدین و ...) نباید به وجود آید زیرا کودک را از یادگیریهای لازم باز می دارد. – هر گونه نقص غذایی با عدهای کشف و اصلاح شود است در استعداد یادگیری کودک تأثیر بگذارد. – کودک پیش از ورود به دبستان در محیط مساعد برای ارضای میل کنجکاری خود قرار از واداشتن کودک به یادگیری چیزی که استعدادش را ندارد خودداری شود

با رفتن کودک به مدرسه، نقش خانواده در کمک به کودک برای شکوفایی و به کار انداختن استعدادهای ذهنی وی تمام نمی شود بلکه مدرسه در مقام کمک و همکاری با خانواده می تواند وظایف و نقشهای دیگری به عهده گیرد.

هر گونه فعالیت درسی در مدرسه وقتی مفید خواهد بود که به هدف نامبرده کمک کند یعنی دانش آموز را تحریک کند که بی اختیار، استعدادهای ذهنی خود را به کار اندازد و شخصاً ازفعالیتهای خود نتیجه بگیرد و استفاده کند و معلم خوب کسی است که فعالیتهای درسی را به عهده دانش آموزان بگذارد و خود، در صورت لزوم، به نظارت و راهنمایی آنان اکتفا کند. با توجه به چگونگی رشد و تکامل عقلی در کودکان، رعایت نکات زیر ضروری می نماید:

- برنامه تحصیلات باید با میزان رشد عقلی و ذهنی کودک سازگار باشد. به عبارت دیگر، چیزی را باید به او آموخت که استعداد یادگیری آن را دارد. – تدریس در سالهای اولیه تحصیل باید بر محسوسات دانش آموزان متکی و مبتنی باشد. بدین معنی که معلم باید درسها را محسوس و عملی عرضه کند و از حواس مختلف آنان

برای یادگیری هر چه بهتر یاری بگیرد. – باید استعداد کودک را برای شناختن اوضاع جهان خارج، بیدار و تربیت کرد. برای این منظور معلم باید گفته های درسی خود را به مظاهر زندگی و اشیای موجود در محیط خاص کودک مرتبط سازد. – همیشه باید به این نکته توجه داشته باشیم که حفظ و از بر کردن تنها دلیل فهم مطلب نیست بلکه مهم، ادراک آن و یاد گرفتن طرز استفاده از آن است.

- معلم باید تخیل دانش آموزان را در راه درست پرورش دهد و آنان را از افراطی که سبب دوری از زندگی واقعی می شود منع کند. به عبارت دیگر، دانش آموزان را طوری بار آورد که در مسائل زندگی و حل مشکلات آن، به تفکر و تعقل بپردازند و دل خود را به عالم وسیع و زیبای خیال خوش نکنند.
- کودک در نخستین مراحل هر موضوع و بحث می پذیرد، در صورتی که در دبستان به تحقیق و انتقاد آنها علاقه مند می شود.

معلم باید اولاً مسائل واقعی را برای ایشان مطرح کند، ثانیا آنان را از همان آغاز تحصیل، به روش انتقاد صحیح و لزوم و اهمیت آن در پیشرفت فرد، راهنمایی و تشویق کند و به ایشان بیاموزد که انسان باید در قضاوتهای خود تابع عقل و منطق باشد نه عاطفه و اگر از کارهای او انتقاد صحیح و بجایی می شود ناراحت نشود بلکه به تعدیل و تغییر آنها بپردازد و نیز از انتقاد بجا و منطقی کارهای ناپسند دیگران، پاک و هراس نداشته باشد. – در توزیع دانش آموزان در کلاسها، تا حد امکان، استعداد ذهنی آنان در نظر گرفته شود

زیرا همانندی عقلی میان دانش آموزان، بزرگترین کمک به یادگیری و آموزش است. – از نظر روان شناسی، منطقی نیست که برنامه ثابتی را به طور مساوی بـر همه دانش آموزان تحمیل کنیم، چه برنامه هایی را که یک عده قادرند در مدت زمان تعیین شده تمام کنند، گروه دیگری ممکن است توان اتمام آن را در آن محدوده زمانی نداشته باشند. – برای کودکان کند ذهن وعقب مانده، باید مدارس مخصوصی تأسیس کرد تا بتوان از استعداد آنان بیشترین استفاده را برد و از وجودشان در جامعه استفاده کرد.

- برای اینکه دانش آموزان تیزهوش از رشد و تکامل سریع خود، باز نمانند لازم است مجال و فرصتهای علمی مناسب برای آنان فراهم شود.
- چون موفقیت در هر شغل به میزان هوش شخص بستگی دارد، باید دانش آموزان را برحسب میزان هوش و عقل، از لحاظ شغلی که در آینده به عهده خواهند گرفت، راهنمایی کرد. – معلم باید علت عقب ماندگی درسی کودک را مطالعه کند و میزان وابستگی آن را با ضعف هوشی یا عوامل گوناگون محیطی دریابد و به درمان صحیح آن بپردازد. معلمین و مسئولین مدارس بایستی با مطالعه استعدادهای دانش آموزان، آنان را به رشته تحصیلی خاصی که در دوره متوسطه می توانند ادامه دهند، رهبری کنند تا رشته های تحصیلی را بدون آگاهی قبلی انتخاب نکنند که این امر جز اتلاف انرژی و تضییع اوقات گرانبها نتیجه دیگری نخواهد داشت. به طور کلی، محیط خانه و مدرسه باید بهترین فرصت برای تحریک تفکر کودک باشد و

والدین و معلمین، همواره به یاد داشته باشند که هر چند استعداد تفکر و تشکیل مفاهیم در طبیعت کودک وجود دارد ولی روش تفکر و مسائلی که کودک باید درباره آنها بیندیشد کاملاً اکتسابی هستند و کودک آنها را از محیط خانه و مدرسه یاد می گیرد، لذا برنامه ها و کتابهای درسی باید چنان تهیه و تنظیم شوند که کودک همواره با مسائل قابل حل مواجه شود و از تفکر درباره آنها لذت ببرد.

ج – رشد و تکامل اجتماعی همگی این واقعیت را قبول داریم که زندگی انسان از روز اول در میان افراد دیگر آغاز شده و از همان ابتدای حیات با آنها رابطه برقرار میکند و همین ارتباط، تغییراتی در رفتار او به وجود می آورد. بدین ترتیب، یادگیری اجتماعی آغاز می شود و رفتارهای کودک رنگ اجتماعی پیدا می کنند و کودک تمام مفاهیم، احساسات، گرایشها و مهارتهای خود را در زمینه ای از زندگی گروهی کسب می کند. از این رو، پرورش استعدادهای کودک بدون تربیت ادراک اجتماعی او امکان پذیر نیست. رشد و تکامل اجتماعی کودکان از عوامل متعددی چون نصح با سلامت و بیماری، بازی، خانواده و محیط مدرسه متأثر می شود.

با پیشرفت تمدن و فرهنگ، مسئولیت اجتماعی افراد افزایش می یابد. هر چند در گفت انزوا و گوشه نشینی یا اکتفا به یک ارتباط محدود و کم وسعت برای افراد امکان ندارد و هر لحظه احتیاج است که فرد دامنه ارتباط خود را با همنوعانش این نیز جز از طریق پذیرش مسئولیت به اندازه توانایی، ممکن نخواهد بود و مدرسه بهترین مرکزی است که صلاحیت تربیت اجتماعی صحیح کودکان را دارد و تربیت اجتماعی باید مکمل یادگیری باشد. بدین جهت لازم است میان مدرسه و خانواده کودک همواره ارتباط برقرار شود. تا کودک با بهره گیری از هر دو محیط بتواند استعدادها و مهارتهای پرورش دهد و فردی اجتماعی بار آید.

برای اینکه رشد و تکامل اجتماعی کودک در خانواده، درست و انجام گیرد، باید اوضاع زیر در محیط خانواده برقرار باشند؛ - کودک یقین کند که مورد علاقه و محبت است و این احتیاج روانی به وسیله والدین، برادران و خواهران ارضا می شود و همین محبت و علاقه، پایه اساسی برای تقویت روابط درونی میان کودک و سایرین است. کودکی که در محیط ترس و اضطراب با احساس حقارت متولد گردد و زندگی کند، فردی بدبین و کینه توز بار می آید. خانواده نخستین مرکز و مجالی است که کودک استعدادها و تواناییهای خود را در رشد و پرورش می دهد. این امر از طریق بازی، شرکت در فعالیتها و تجارب همسالان انجام میگیرد و بی شک، تشویق و رقابت مطلوب در رشد این استعدادها مؤثر است. – افراد خانواده باید از سرزنش کودکان درباره اموری که نمی فهمند با انجام دادن آنها برایشان دشوار است خودداری کنند زیرا ملامت کودک در این موارد، سبب می حقیر و عاجز بپندارد و از خود مأیوس شود. – کودک در نتیجه تجارب و اطلاعات خود در خانواده، مجموعه ای از عادتهای گوناگون را

از قبیل طرز خوردن، پوشیدن، راه رفتن، سخن گفتن، نشستن، شستشو، خواب و میکند، لذا خانواده باید در تقویت هرچه بیشتر عادات پسندیده در کودک تلاش کند – طرز رفتار والدین با یکدیگر در رشد و تربیت اجتماعی کودک بسیار مؤثر است. در صورتی که کودک در میان پدر و مادر خود مهر و محبتی احساس کند، دیگر هیچ گونه نگرانی و پریشان خاطر ی از طرف آنان نخواهد داشت و در نتیجه، رشد طبیعی خود را ادامه خواهد داد.

عکس هرگاه پدر و مادر، پیوسته با هم مشاجره کنند و هرچند روز یک بار به طلاق و جدایی تصمیم بگیرند، از سرعت رشد فرزندانشان کاسته می شود.

- پایه عقاید و افکار کودک و علاقه او به تسامح یا تعصب، در محیط خانه می شود و پیروی از حق و حقیقت یا اظهار تعصب به معتقدات خود را از خانواده اش یاد می گیرد. از این رو توجه خانواده به برقراری عدالت و انصاف، معتقدات مذهبی و مسائل معنوی در محیط خانه، در روابط اجتماعی کودک تأثیر به سزایی خواهند داشت.

همان گونه که گفتیم مدرسه نیز در رشد و تربیت اجتماعی کودکان، مرکز توجهات است و باید از راههای گوناگون و بهره گیری از وسایل تربیت اجتماعی نظیر کارهای دستی، ورزش، تشکیل گروه و تدارک گردشهای علمی به این رشد کمک کند.

د ـ رشد و تکامل عاطفی سلامت روانی و عقلی شخص به سلامت عاطفی او بستگی دارد. زیرا نظر شخص نسبت به خودش، دیگران، اوضاع اجتماعی و زندگی به طور کلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وی متأثر می شود. به بیان دیگر، داوریهای هر فرد درباره خود و دیگران و مسائل اجتماعی به کیفیت عواطف او بستگی دارد و شخصی که از رشد سالم هیجانی و عاطفی بهره مند نباشد هرگز فردی واقع بین، نیک اندیش، درست کردار و در نتیجه فرد مفید و مؤثر در پیشرفت جامعه نخواهد بود. مهم در توجه به عواطف کودکان این است که بدانیم عواطف و هیجانات کودکان از چه موارد با اوضاعی نظیر، خشم، ترس، غم و ... متأثر است. اگر بتوانیم کودکان را به موقع از عواملی که موجب برهم زدن تعادل عاطفی آنان می شود آگاه کنیم و با علاقه به سازندگی و پرورش نیروهای هیجانی آنان بپردازیم، می توانیم امیدوار باشیم که در راه آرامش و امنیت روانی کودکان گامهای مؤثری برداشته ایم. سطح نضج، وضع بهداشتی، روابط خانوادگی، هوش، خستگی، محیط اجتماعی، آرمانها و آرزوها، گرایش نسبت به ارزشهای زندگی، محیط مدرسه وکلاس از جمله عواملی هستند که در رشد و تکامل عاطفی کودک مؤثرند. تربیت عاطفی کودک به عهده شخص واحدی نیست و مستلزم همکاری خانواده و مدرسه است. برخی توصیه های تربیتی در این زمینه را که می بایست در محیطهای مذکور به کار گرفته شوند، در زیر یادآور می شویم معلم مضطرب و ناراحت، هرگز نمی توان تربیت فرد سالم را انتظار داشت. – در انتخاب معلم و مربی باید بیشتر دقت شود که از لحاظ عاطفی سالم باشند زیرا از محیط خانه و مدرسه باید برای کودک قابل اعتماد و امن باشد و مربی اعم از والدین معلمین باید رفتارهای هیجانی و عاطفی وی را کاملا درک کنند.

شود. این امر اعتماد او را از خودش سلب می کند و باعث می شود که او خود را حقیر و نانس - از وادار ساختن کودک به کار و فعالیتی که از عهده اش ساخته نیست باید خودداری پندارد؛ به علاوه کسانی را که به او دستور می دهند همیشه دشمن و مخالف خود می داند

- تا حد امکان از به کار بردن کلمات و عبارات «نکن»، «تو نمی توانی»، «هنوز برای تو زور است»، «این کار تو نیست» و امثال آنها باید اجتناب ورزید. به طور کلی، والدین و مربیان نباید در این فکر باشند که عجز و حقارت کودکان را به خود ایشان ثابت کنند زیرا خود آنها به تدریج و به تجربه شخصی به میزان استعداد و توانایی خود پی می برند.

- والدین و مربیان باید کودک را همان طور که هست بپذیرند و از مقایسه او با کودکان دیگر خودداری کنند. - نباید کودک را محکوم کرد و مورد انتقاد قرار داد. همچنین، نصیحت مستقیم نیز چندان مفید نخواهد بود، بلکه بهتر است از راه داستانهای اخلاقی و اجتماعی فرد را به طور غیر مستقیم به وظایف خود آشنا ساخت. چنانچه رفتار ناشایستی از کودک مشاهده شد، در درجه اول باید به کشف علت آن پرداخت زیرا چگونگی رفتارهای وی نتیجه و محصول شرایط طبیعی یا محیطی است و در این کار نباید از منطق کودکانه آنان غفلت کرد. - تهدید سبب ناراحتی و تشویش خاطر کودک می شود و کمترین ضررش این است که در

او ترس و تردید ایجاد می کند یا او را به دفاع از خود بر می انگیزد. لذا از تهدید کودک حتی المقدور باید اجتناب کرد.

- والدین و مربیان باید همواره همدرد کودکان باشند، چه این بزرگترین آرزو و میل آنان است. کودک نیازمند است بداند که معلم به احساسات و عواطف او به همان میزان استعداد یادگیریش توجه دارد. - باید دانست که سختگیری و مجازات پاسخ هیجانها و رفتار منفی نیست بلکه به شدت و تندی آنها می افزاید. ضمناً بهتر است کودک در تعبیر احساسات و عواطف خود آزاد باشد مگر در مواقعی که برای جلوگیری از صدمه رساندن به دیگران، باید حدی بر آن قابل شد. به طور کلی باید این اصل را بپذیریم و همواره در نظر داشته باشیم که برای سلامت عواطف کودکان، وجود بدن سالم و محیط مناسب شرط اولیه و ضروری است. به عبارت دیگر، کودک وقتی هیجانها و عواطف سالم خواهد داشت که دارای بدنی سالم و نیرومند باشد و از محیط مناسب بهره مند شود. در عین حال، پدر و مادر و معلمان نیز همگی باید از عواطف سالم برخوردار باشند.

فصل یازدهم

بیماری های شایع در کودکان و برنامه های ایمن سازی

هرگاه با برنامه ریزیها و اقدامات لازم بتوان عوامل بیماری زا را کنترل کرد و در بهبود عوامل محیطی و فردی، تغییرات مثبتی داد، به احتمال زیاد بیماری حادث نخواهد شد. در این فصل که به مطالعه بیماریهای شایع و برنامه های ایمن سازی (واکسیناسیون) کودکان اختصاص دارد، ضمن بیان مختصر مشخصات و ویژگیهای این بیماریها، برنامه های مربوط به ایمن سازی نیزمطالعه و بررسی شده است .

سرماخوردگی عفونت حاد دستگاه تنفسی است که معمولاً پس از یک دوره کمون (فاصله بین تماس با یک عامل بیماری زا و بروز اولین نشانه های بیماری ناشی از آن کوتاه ۱۸ تا ۴۸ ساعته، بدون مقدمه با احساس خارش در حلق، عطسه، آبریزش بینی، حالت کوفتگی و خستگی و تب پدیدار می شود. حس بویایی و چشایی در بسیاری موارد دچار اختلال و در ناحیه کمر و دست و پاه دردهای مبهم ظاهر می شود. معمولاً بیمار احساس سرما می کند ولی به ندرت دچار لوز می شود. به تدریج مجاری تنفسی مسدود می شود. ترشحات بینی فزونی می گیرد و احساس فشردگی و ناراحتی در پشت جناغ سینه توأم با سرفه بروز می کند.

سرماخوردگی

معمولی به وسیله ویروسهای مختلفی ایجاد می شود. البته میکروبهای بیماری را نیز سبب بروز عوارض چرگی سرماخوردگی چون اونیت، سینوزیت و احتمالاً برونشیت می شوند درمان اختصاصی برای سرماخوردگی وجود ندارد، اگرچه به منظور تخفیف ناراحتی بیمار، داروی تب بر و داروهایی برای کاهش ترشحات مخاط بینی و تسکین سرفه ها تجویز می شود. برخورداری از رژیم غذایی کافی و سرشار از ویتامینها به ویژه ویتامین C و همچنین عدم تماس با شخص مبتلا در پیشگیری از بروز سرماخوردگی بسیار مؤثر است.

دل درد

از جمله دردهای شکمی بچه های کوچک، قولنجهای عصرانه، هواخوری و نفخ است غذای نقاحی است، بنابراین تعجب آور نیست اگر شکم بچه های شیرخوار زیاد نفخ میکند و اصطلاح باد دارد. علاوه بر آن، نوزادان در موقع شیر خوردن و گریه کردن، مقدار زیادی هوا می بلعند که خود سبب نفخ بیشتر شکم و دل درد می شود. با اصلاح روش شیر دادن و کمک به طفل بعد از شیر خوردن به منظور خارج کردن هوایی که فرو برده می توان تا حد زیادی از این دل دردها جلوگیری کرد. دادن شیر گاو به علت مقدار زیاد پروتئین آن و همچنین غذاهایی که هضم آن برای کودک مشکل است نیز می توانند باعث دل درد گردند. گاهی نیز علت دل درد کودکان ناشی از بیماریهایی است که کودک ممکن است بدانها مبتلا شده باشد. در هر حال اگر دل درد کودک ادامه یابد، رساندن وی به پزشک امری ضروری است.

اسهال

بزرگترین مشکل طبی کودکان در کشورهای در حال توسعه اسهال است. این بیماری اغلب در شیرخوارانی مشاهده می شود که از شیر گاو یا شیرخشک تغذیه می شوند. همچنین در خانواده هایی که تغذیه صحیح ندارند و یا از نظر مواد غذایی در فقر هستند و به اصول بهداشتی آشنا نیستند و مخصوصا در مناطق گرمسیر زندگی می کنند بیشتر دیده می شود نیز ناگهانی شروع می شود و امکان دارد چند روزی ادامه داشته باشد. اسهال ممکن است براثر عامل اصلی اسهال حاد، آلوده شدن روده به عوامل بیماری است که معمولاً بـه طـور دخالت عوامل دیگری از قبیل سوء تغذیه و انگلهای روده ای عارض شود که این قبیل اسهالها معمولاً به صورت مزمن ظاهر می شود و ممکن است هفته ها و ماهها ادامه داشته باشد. درمان بیماریهای اسهالی معمولاً از طریق جبران آب و املاح دفع شده از بدن با استفاده از مایع صورت می گیرد. قطع کردن تغذیه شیرخوار با شیر در بیماریهای اسهالی، جز در موارد استثنایی و به صلاحدید پزشک معالج، توصیه نمی شود. خوراکی درمانی 'ORS

استفراغ

عوامل متعددی می توانند سبب استفراغ شوند. در بعضی از بچه ها، استفراغ متعاقب بسیاری از حالات و هیجانات دیده می شود. مثلاً متعاقب گریه زیاد، عصبانی شدن، جیغ و فریاد کردن و یا خنده شدید. طبیعی است که پدرومادر چنین کودکی با این حالت وی آشنا هستند و از استفراغ او نگران نمی شوند. اما عوامل دیگری نیز ممکن است سبب استقراع در کودکان شوند مانند خوردن غذاهایی که هضم آنها دشوار باشد، خوردن مواد غذایی فاسد، خوردن مواد سمی نظیر نفت، حرکت زیاد و چرخش کودک و بسیاری از بیماریهای عضوی که اصولاً با استقراع شروع می شوند. در صورت ادامه استفراغ و یا بروز نشانه های دیگری از قبیل شب و مال مرد باید پزشک مراجعه شود.

یبوست

یبوست حالتی است که مدفوع بسیار سفت و نظم آن مختل می شود و اجابت مزاج بـه طـور معمول صورت نمی گیرد. علت این امر در اغلب موارد مربوط به نوع شیری که کودک از آن تغذیه می شود، فقدان مواد زاید و سفت در روده برای تحریک حرکات روده و انجام نگرفتن رفلکس تخلیه است. لیکن عوامل دیگری از قبیل استعمال بیجای شیاف و تنقیه نیز ممکن است ایجاد پیوست کنند. درمان بیماری با استفاده از داروهای ملین تحت نظر پزشک انجام می گیرد باید به مادران نگران و مضطرب درباره انجام عمل دفع کودکان خود متذکر شد که اجابت مزاج برای کودک، قانون خاص و معینی ندارد و تاخیر یکی دوروزه آن در صورتی که کودک سالم به نظر می رسد و مدفوع قرام معمولی داشته باشد کاملا بی اشکال خواهد بود و نیازی به استفاده ملین با مسهل نخواهد بود.

گوش درد و عفونتهای گوش گوش درد یکی از شایعترین مشکلات دوران کودکی است که به دلایل مختلفی می تواند بروز کند. مثلاً به طور طبیعی میکروبهای مختلف و قارچها در مجرای گوش خارجی وجود دارند. اگر رطوبت یا آب (در نتیجه زیر آب رفتن) یا جسم خارجی وارد مجرای گوش خارجی شود، سین عفونت مجرا می شود و ایجاد گوش درد میکند. همچنین عفونتهای بینی و حلق به سادگی می توانند به گوش میانی سرایت کنند و باعث انسداد مجرای اوستاش (مجرایی که گوش میانی را به عقب مجرای بینی مرتبط میکند) بشوند. اگر مجرای اوستاش به علت عفونت یا آلرژی مسدود شود سبب پیدایش مایع در گوش میانی می شود. اگر تغییر ناگهانی فشار در نتیجه زیر آب رفتن به وجود آید، سبب ترشح در گوش میانی و حتی خونریزی می شود یا اگر به علت سرماخوردگی مجاری بینی مسدود شود ترشحات میکروبی بینی از راه مجرای اوستاش به گوش میانی می رسد و ایجاد ترشح چرکی میکند. ترشحات گوش میانی ممکن است آبکی، مخاطی یا چرکی باشد. وجود این ترشحات پس از تجمع و زیاد شدن فشار آن، می تواند پرده صماخ را پاره کند و ترشحات از راه مجرای

گوش خارجی دفع شود اگر کودک کوچکترین شکایتی از گوش درد دارد باید به وسیله پزشک معاینه شود مخصوصاً اگر گوش درد توام با تب باشد، زیرا قبل از اینکه عفونت پیشرفت کند و ترشح چرگی در گوش میانی به وجود آید، درمان مؤثرتر خواهد بود. در صورت عدم درمان به موقع عفونتهای گوش، عوارض مختلفی نظیر کاهش قدرت شنوایی به وجود می آید و سلامت کودک را تهدید می نماید.

بیماریهای شایع چشمی شایعترین بیماری چشمی در کودکان، ورم ملتحمه یعنی آماس و تورم و قرمزی سطح داخلی پلکها و قسمت سفیده کره چشم است. عامل عمده در ورم ملتحمه، عفونت است لیکن آلرژی و مواد شیمیایی نیز ممکن است به بروز آن منجر شود.

میکروبهای مختلفی ممکن است ایجاد ورم ملتحمه کنند. پیدایش ترشح چرکی زد متمایل به سبز در چشم و تورم پلکها اختصاص به ورم ملتحمه میکروبی دارد، کودک پس از | مدتی خوابیدن مخصوصاً صبحها به علت ترشح زیاد در چشم، پلک و مژه هایش بهم می چسبد و کودک نمی تواند چشم خود را باز کند. کودک چشم خود را معمولاً می خاراند و خاراندن ست می شود که چشم بیشتر ورم کند.

ورم ملتحمه ناشی از آلرژی و مواد شیمیایی معمولاً درمانی لازم ندارند و خودبه خود بهبود می یابند، لیکن در موارد ورم ملتحمه میکروبی، والدین باید چشم مبتلا را زود به زود آب جوشیده ولرم بشویند تا کودک بتواند چشم خود را باز کند، سپس وی را نزد پزشک ببرند. در | رایشگاهها معمولا بلافاصله پس از تولد نوزاد، برای پیشگیری از ابتلا

به ورم ملتحمه میکروبی، از محلول نیترات نقره یک درصد در هر دو چشم می چکانند رعایت بهداشت فردی توسط کودک به ویژه شستن دستها با آب گرم و صابون و

|

خودداری از مالش چشمها، در پیشگیری از ابتلا به این بیماری بسیار مؤثر است. گل مژه و | انحراف چشم (لوچی) از دیگر موارد قابل ذکر در بیماریهای چشمی کودکان است. گل مژه تورم و | فرمزی کوچکی است که در لبه پلک در محل فولیکول مو به وجود می آید. این برجستگی معمولاً دردناک و حساس است. علت گل مژه معمولاً میکروب استافیلوکوک است. کمپرس با آب گرم در غالب موارد باعث بهبود می شود. در صورت ادامه کسالت، کودک را باید نزد پزشک موضعی تجویز می کند. رعایت بهداشت و شستشوی مرتب صورت کودک از ابتلا به این بیماری جلوگیری خواهد کرد. برد و پزشک معمولاً انحراف چشم نیز در کودکان شایع و تشخیص و درمان به موقع آن به منظوربازگرداندن قدرت دید طبیعی، بسیار حایز اهمیت است.

بیماریهای شایع پوست

چون پوست صورت کودکان همیشه در معرض هوای محیط قرار دارد و مخصوصاً بعضی از کودکان عادت دارند که به سر و صورت خود دست بزنند و حتی با بینی خود بازی کنند، بنابراین اگر بدن کودک و مخصوصاً سرو صورت او شسته و حمام نشود، میکروبهای مختلف و مخصوصاً میکروبهای بیماری زا در سطح پوست صورت، مجاری بینی و پوست اطراف آن رشد خواهند کرد. در چنین شرایطی خاراندن، خراشیدگی، ضربه ها و زخمهای سطحی پوست سبب می شود که میکروب بیماری را وارد پوست شود و شروع به فعالیت و تکثیر کند و تظاهرات مختلفی را باعث شود. جوش یا کورکهای کوچک، کورک بزرگ، آماس و تورم، خراشیدگی و زخم صورت، زرد زخم، آماس و تورم پوست، برجستگیهای کوچک زگیلی پوست، زخم و عفونت گوشه لبها، | عرق سوز (پیدایش تاولهای بسیار ریز در صورت و گردن)، قرمزی پوست قسمتی از صورت و چانه در نتیجه تحریک، پیدایش قرمزی، آماس و بثورات در محل بستن کهنه های کودک، ازجمله بیماریهای شایع پوستی در نزد کودکان به شمار می روند. در دوران شیرخوارگی کمتر اتفاق می افتد که قسمتی از پوست بدن کودک که کهنه بسته می شود، دچار قرمزی، آماس و بثوراتی نشود. برای پیشگیری، کهنه های کودک را باید زود به زود عوض کرد و آنها را خوب شست و خشک کرد، پاهای کودک را چند ساعت در روز بدون قرار داد و پاهای کودک را بعد از هر نوبت مدفوع کردن، با آب ساده پوشش در معرض هوای و گرم بدون صابون شست. ضمنا پلاستیک، لاستیک یا شورت لاستیکی را نباید به طور دایم به پاهای کودک بست مگر برای مدت محدودی که کودک به خارج از خانه یا مهمانی برده می شود غالباً شستن محل زخمها با آب گرم و صابون یا ماده ضدعفونی کننده و همچنین اا‌ستفاده از رعایت بهداشت فردی، مهمترین عامل پیشگیری از بروز بیماریهای پوستی است و درمان آنها آنتی بیوتیکهای مناسب انجام می گیرد.

بیماریهای شایع دهان و حلق برفک دهان، تبخال دهان و لبها، تبخال گلو و آفت دهان از شایعترین بیماریهای دهان و حلق در بین کودکان به شمار می روند. برفک دهان پیدایش دانهها و تکه های سفید رنگی است در سطح زبان، سقف دهان، سطح داخلی گونه ها و لبها. علت بیماری غالباً ناشی از قارچ کاندیدا آلبیکنس است و درمان بیماری با استفاده از داروهای ضدقارچ نظیر نیستاتین انجام می گیرد.

تبخال دهان به وسیله نوعی ویروس ایجاد می شود، سر زدن دندانهای کودک و زخم شدن لثه ها در نتیجه بیرون آمدن دندانها عامل مساعدی در به وجود آمدن تبخال دهان است. این بیماری معمولاً در یک تا سه سالگی بیشتر دیده می شود. این بیماری معمولاً خود بهبود می یابد لیکن شستشوی دهان با محلولهای ضدعفونی یا آب نمک طبی به بهبود زخمها کمک میکند. تبخال لبها مانند تبخال دهان علت ویروسی دارد. این بیماری نیز معمولاً خود به خود بهبود می یابد.

تبخال گلو که به وسیله ویروسهای کوکساکی گروه A ایجاد می شود، با پیدایش تاولها زخمهای جدا از هم در روی چینهای جلوی لوزه ها، قسمت عقب سقف دهان و زبان کوچک مشخص می شود. تب، بی اشتهایی، گلودرد، درد به هنگام فروبردن غذا، سردرد و دردشکم از جمله علایم این بیماری است. زخمها پس از یک هفته معمولاً بهبود می یابند. شستشوی دهان با محلولهای ضدعفونی و استفاده از داروهای تببر و ضددرد به بهبود بیماری کمک می کنند.

آفت دهان عبارت است از پیدایش زخمهای کوچک و دردناک در مخاط دهان، پشت لبها،زیرزبان و سقف دهان. این زخمها معمولاً تک تک وجود دارند. زخم آفت از ترشح خاکستری رنگ پوشیده شده است و کناره آنها کاملاً مشخص و قرمز است. پیدایش این زخمها به صورت دوره ای، یعنی عود کننده است. علل مختلف ممکن است سبب پیدایش آفت دهان شود. در میان می توان ذکر کرد. این بیماری درمان مشخص ندارد لیکن شستشوی دهان با محلولهای ضدعفونی کننده و مالیدن مواد بیحس کننده روی زخمها در بهبود مؤثر است. این علل حساسیت نسبت به نوعی غذا، واکنش به دارو، عامل عفونی و بالاخره هیجانات را بیماری عفونی حاد و خطرناکی است که عامل مولد آن باسیل و پیربوکلرا (و بیریون ویا) و در دو | اصطلاح شبه ویاست. این بیماری به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، از طریق غذا و مدفوع الرده | ر نوع دیگر عامل مولد النور یا به نوع است. یکی از آنها مولد وبای معمولی یا وپای کلاسیک است و اشیای آلوده و حشراتی چون مگس به انسان منتقل می شود. دوره کمون بیماری به طور معمول سه روز است و اشکال خفیف بیماری که تنها به صورت اسهال ظاهر می شوند، در بچه ها بیشتر شایع است. درمان بیماری براساس جبران آب و نمک دفع شده از بیمار براثر ابتلا به اسهال صورت می گیرد.

حصبه (تیفوئید)

بیماری عفونی باکتریایی حادی است که در ایران و بسیاری از کشورهای جهان با شیوع زیاد در کلیه فصلها به ویژه در ماههای گرم سال وجود دارد. عامل بیماری را یعنی سالمونلا تیفی، باسیلی است که از راه دهان و همراه با آب و مواد غذایی آلوده و با خوردن غذا با دست یا ظروف آلوده وارد بدن می شود و شخص را مبتلا میکند. دوره کمون بیماری از یک تا سه هفته متغیر است و از علایم بیماری، اسهال با پیوست، سردرد شدید، حالت بهت، تب و حساسیت شکم قابل ذکرند. در بیماری شبه حصبه (پاراتیفوئید) علایم بیماری شبیه حصبه منتهی ملایم تر و خفیف تر از آن است.

آبله مرغان

از جمله بیماریهای ویروسی است که در اثر تماس مستقیم یا به وسیله ترشحات دهان و بینی بیماران مبتلا به افراد سالم سرایت می کند و پس از حدود پانزده روز، علایم بیماری ظاهر می شود. بیست و چهار ساعت قبل از پیدایش دانهها، کودک مبتلا به تب مختصر، بی حالی و بی اشتهایی می شود. سپس دانه ها ظاهر می شود. در بعضی از کودکان علایم قبل از دانه ها آنقدر خفیف است که مادر و کودک از آن اطلاع ندارند و مادر هنگام عوض کردن لباسهای کودک می دهد، دانه ها ابتدا به صورت دانههای قرمز برجسته در سینه، شکم و پشت ظاهر می شود، در مدت چند ساعت آبکی می شود و در خلال ۲۴ ساعت پاره می شود و دلمه می بندد. دانه ها در خلال سه تا چهار روز بعد دسته دسته در همان محلها و در نقاط دیگر بدن مانند صورت، دهان، حلق و پوست سر ظاهر می شود. تعداد و انتشار دانه ها روی بازوان و ساق دانه هایی در بدن کودک می بیند یا اینکه کودک دانه هایی در بدن خود می بیند و به دیگران نشان دانه ها پا نسبت به تنه و شکم کمتر است.

اوریون

بیماری ویروسی است که در آن غدد بناگوشی متورم و بزرگ می شود. انتقال بیماری اغلب از راه قطرات آلوده و تماس مستقیم با بیمار است که پس از دوره کمونی حدود شانزده تا هجده روزه علایم بیماری در فرد ظاهر می شود. ابتدا کودک از درد ناحیه گوش شکایت می کند که این درد با جویدن بدتر می شود. پس از ۲۴ ساعت تورم و آماس در جلوی گوش ظاهر می شود. سپس این تورم به طرف جلو و پایین انتشار می یابد. تورم غده ممکن است در یک زمان در دو طرف یا ابتدا در یک طرف و پس از یکی دو روز در طرف دیگر صورت ظاهر شود. تورم و آماس معمولاً در خلال چند ساعت به وجود می آید و در خلال ۱ تا ۳ روز به حداکثر خود می رسد. به تدریج در خلال ۳ تا هفت روز از بین می رود. تورم و آماس غده معمولاً سبب می شود که لاله گوش به طرف بالا و خارج کشیده شود. در زمانی که غده بناگوشی متورم است، کودک در ناحیه گوش خود احساس درد اگر این کودک مواد غذایی ترش یا آب میوه ترش بخورد، درد شدیدی در محل تورم حس خواهد کرد. در هنگام تورم غده ممکن است کودک تب نداشته باشد یا تب او خفیف باشد و به طور نادر ممکن است تب کودک بالا و شدید باشد. در این بیماری علاوه بر غدد بناگوش، ممکن است غدد بزاقی دیگر نیز متورم شوند. تا زمانیکه تورم و آماس غده وجود دارد، کودک مبتلا به اوریون نباید با کودکان دیگر تماس پیدا کند و به مدرسه برود. اگرچه اوریون غالباً در کودکان خفیف و ملایم است، لیکن در برخی مواقع، به ویژه در بالغین، عوارضی در بیضه ها ایجاد میکند. تورم پرده های مغز و نخاع نیز ممکن است دیده شود. برای پیشگیری از ابتلا به اوریون، از واکسن این بیماری می توان استفاده کرد. "

مخملک

این بیماری میکروبی است و از طریق تماس مستقیم با بیمار و یا از قطرات، اشیا و لوازم آلوده، به فرد سالم منتقل می شود. دوره کمون بیماری حدود ۳ روز است و از علایم آن، تب، سردرد، کوفتگی، گلودرد و وجود دانه های قرمز رنگ در سطح بدن قابل ذکرند. این بیماری بیشتر در سنین مدرسه دیده می شود. درمان بیماری با تجویز آنتی بیوتیکهای مناسب انجام می گیرد. عدم درمان به موقع ممکن است منجر به عوارضی از قبیل تورم کلیه ها، روماتیسم مفصلی و قلبی در کودکان شود.

سرخک

یکی از بیماریهای شایع و واگیردار دوران کودکی است. کودک سالم این بیماری را معمولا در نتیجه تماس با کودک مبتلا به سرخک می گیرد. دوره کمون بیماری حدود ده روز و علایم اولیه شبیه سرماخوردگی است. کودک ابتدا دچار تب مختصر، سرفه های خشک و آبریزش از بینی می شود. چشمها نیز قرمز و ایکی می شوند. این علایم به تدریج شدت می یابند و تب کودک به حدود ۴۰ درجه می رسد. در این زمان نقاط سفید خاکستری به اندازه دانه های شن روی زمینه قرمز دهان بیمار در مقابل دندانهای آسیای پایین کودک (دانه های کوپلیک) به وجود می آیند. دانههای سرخک ظاهر می شود که بسته به چگونگی پیشرفت بیماری در قسمتهای مختلف بدن مانند صورت، بازوها، قسمت بالای قفسه سینه، شکم، پشت، دستها و رانها قابل مشاهده است. با انجام واکسیناسیون، ایمن سازی فعال در برابر این بیماری برای تمام کودکان فراهم می شود.

سرخجه

یکی از بیماریهای ویروسی شایع در بین کودکان سرخجه است که اکثرا در افراد پنج تا چهارده ساله دیده می شود. در این بیماری کودک ابتدا مختصری تب میکند و آبریزش مختصری از بینی خواهد داشت؛ سپس دانه هایی در بدن او ظاهر می شود. مشخصات بیماری سرخجه این است که ۲۴ ساعت قبل از پیدایش دانهها، غدد لنفاوی پشت گوش و گردن کودک بزرگ و متورم می شود. دانه ها معمولاً ریز، صورتی رنگ و مختصری برجسته است و ابتدا از صورت شروع می شود و در خلال ۲۴ ساعت به تمام بدن منتشر می شود. غیر از دانه ها ممکن است بعضی از قسمتهای بدن قرمز رنگ شود. همچنین بعضی از کودکان در دوران بیماری دچار درد و تورم مفصل مخصوصاً مفصل زانو می شوند. بیماری سرخجه ممکن است علایم ذکر شده در بالا را نداشته یا علایم آنقدر خفیف باشد که پزشک و مادر نتوانند تشخیص دهند.

این بیماری از این نظر اهمیت دارد که اگر خانم بارداری در سه ماه اول بارداری خود مبتلا به سرخجه شود، ویروس بیماری در جنین اثر می کند و سبب ناهنجاریهایی از قبیل کوری،کری، بیماریهای قلبی و مغزی در آن می شود. به منظور پیشگیری از بروز هرگونه ناهنجاری در جنین، امروزه از واکسن سرخجه در خانمهایی که قبل از بارداری به این بیماری مبتلا نشده اند استفاده می شود.

دیفتری بیماری عفونی حادی است که معمولاً حلق، حنجره، لوزه ها، گلو و حفرات بینی و به ندرت پوست، ملتحمه چشم یا دستگاه تناسلی را فرا می گیرد. میکروب معمولاً در محل عفونت تکثیر می یابد و تولید سم میکند که اصطلاحاً اگزو توکسین نامیده می شود. دوره کمون بیماری معمولاً دو تا شش روز است. از نظر بالینی سه نوع عمده دیفتری، بسته به محل ابتلا، وجود دارد که شامل ددیفترستونهای لوزه، حنجره ای و بینی است. عامل مولد بیماری، باسیلی است به نام کورین پاکتر ویوم که به باسیل لفلر نیز معروف است و راه انتقال آن به طور معمول از طریق مستقیم و به است. گلودرد، حساسیت وسیله قطرات و ترشحات گلو، بینی و پوست از بیمار و یا حاملین عقده های لنفاوی، تورم حاد و خیزگردن از جمله علایم این بیماری است که در مراحل پیشرفته به فلج مغزی و اعصاب محیطی و التهاب عضله قلب نیز می تواند منجر شود. در پیشگیری از این بیماری، واکسیناسیون در رأس همه امور قرار دارد.

سیاه سرفه

این بیماری عمدتاً بیماری دوران نوزادی یا اوایل کودکی است. این بیماری به شدت مسری است. بنابراین در شرایطی که یکی از نزدیکان کودک به سیاه سرفه دچار شود، درصد بسیار بالایی از کودکان به این بیماری مبتلا شوند. ابتلای بدون علایم بیماری اگر هم وجود داشته باشد مسلماً بسیار کم است و پس از ابتلا به این بیماری، مصونیتی طولانی یا برای تمام عمر پیدا می شود. بیشترین میزان مرگ و میر در کودکان زیر سه ماه اتفاق می افتد.

عامل بیماری باسیلی است به نام بردتلاپرتوسیس که انتقال آن عمدتاً براثر تماس مستقیم با ترشحات مخاط تنفسی افراد آلوده از طریق هوا و احتمالاً قطرات آب و دهان صورت می گیرد و پس از دوره کمونی که معمولاً حدود یک هفته است، علایم بیماری در فرد مبتلا ظاهر می شود .

این بیماری با علایمی شبیه سرماخوردگی شروع شده، لیکن سرفه های آن به جای آنکه بهبود یابد شدت می یابد، پشت سرهم می شود و بالاخره به شکل سرفه های مکرر در می آید که پس از ختم، مجدداً پس از چند دقیقه و یا ساعتی بعد تکرار می شود. سرفه ها اوایل در شب و سپس روزها نیز ادامه می یابد. در پیشگیری از بیماری، مایه کوبی بر علیه آن، با نتایجی بسیاررضایت بخشی همراه بوده است.

پولیومیلیت (فلج اطفال)

پولیومیلیت بیماری ویروسی حادی است که عمدتاً به وسیله ترشحات دهان و حلق و مدفوع مبتلایان، به خصوص ناقلان سالم و یا آنها که عفونت پنهان دارند، شیوع پیدا می کند. این بیماری در درجه نخست، عفونت دستگاه گوارش است اما در بخش بسیار کوچکی از بیماران، دستگاه عصبی مرکزی را هم گرفتار میکند. نتیجه این گرفتاری، بروز درجات گوناگونی از فلج است. در پیشگیری از بروز این بیماری، واکسیناسیون در رأس همه اقدامات قرار دارد.

هپاتیت ویروسی

این بیماری نوعی بیماری ویروسی است که باعث ایجاد اختلال در کار کبد می شود. بیماری با علایم اولیه ای چون بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، نفخ، درد شکم و تب شروع می شود و بالاخره به ایجاد زردی و سایر علایم می انجامد.

بیماری معمولا توسط دونوع ویروس که به نوع A و B معروف اند ایجاد می شوند. نوع که هپاتیت عفونی نامیده می شود، دوره کمونی در حدود ده تا چهل روز دارد و راه ورود آن به مدن از راه گوارش یا تزریق است. این نوع در کودکان بیشتر دیده می شود و دوره بیماری آن کوتاهتر، بهبودی در آن کامل و سرایت آن نیز کم است. نوع Bکه میانیت سرمی نامیده می شود، دوره کمون طولانی ۳۰ تا ۱۶۰ روز دارد و راه اصلی ورود ویروس آن تزریقات است. این بیماری به شدت مسری است و دوره طولانیتری دارد و خطرات آن نسبتاً زیاد است. علاوه بر این، انواع جدیدتری از هپاتیت وجود دارند که معمولاً با بیش از یک ویروس ایجاد می شوند، نظیر هپاتیت غیر A و B که یک شکل مجزای سرم شناسی از هپاتیتهای ویروسی A و B به شمار می رود رعایت اصول بهداشت فردی، بهداشت محیط و مواد غذایی، استریل کردن سرنگها و در صورت امکان، استفاده از سرنگهای یک بار مصرف، و ایمن سازی، از اقدامات بسیا مهم در پیشگیری از این بیماری است.

سل

این بیماری براثر عفونت با میکوباکتریومها ایجاد می شود. گونه های متعددی از این ارگانیسم وجود دارند که از لحاظ سیمای بالینی و روشهای انتشار بیماری با یکدیگر متفاوت اند و در بین آنها، گونه های میکوباکتریوم توبرکولوزیس و میکوباکتریوم بوویس از لحاظ بیماری زایی در انسان مهمترند که گونه اولی اهمیت نسبی بیشتری دارد. میکوباکتریومها در مقام مقایسه با سایر باکتریها حالت خاص یا غیرعادی دارند زیرا تکثیر آنها به کندی صورت می گیرد و در مقابل عوامل نامساعد محیطی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. این باکتری می تواند به

صورتی خوابگونه سالیان دراز در داخل یا خارج از بدن به حیات خویش ادامه دهد. عامل مولد بیماری معمولاً از طریق هوا در اثر مواجه شدن با میکروبهای سلی که در ذرات خلط بیماران مبتلا به سل آلوده کننده وجود دارد منتقل می شود. همچنین از طریق حیوانات، در اثر استفاده از شیر و گوشت آلوده امکان سرایت وجود دارد. میکروب سل ممکن است به هر یک از اعضای بدن حمله کند ولی بیشتر از همه به ریه ها هجوم می برد. بدیهی است برحسب اینکه میکروب در کجا لانه کند، علایم جداگانه ای خواهد داشت. مثلا در پوششهای مغز ایجاد مننژیت سلی و در

استخوانها سل استخوانی. اما شایعترین ملها، سل ریه است. پس از تاثیرگذاری بیشتر باسیل سل بر نسج ریه و تشکیل کانونهای عمومی | و توسعه ضایعه، وزن بیمار به نحو فاحشی کاهش می یابد. سستی و خستگی، احساس کسالت عرق کردن، سرفه های ناشی از ضایعات حفره ای ایجاد شده در نسج، خلط چرکی توأم با رگه های خونی، درد قفسه سینه، تنگی نفس و صدای خشن و دورگه، در بیمار مبتلا ظاهر می شود. علایم بیماری در کودکان، غالباً با خواب آلودگی، خستگی، کاهش وزن و کم شدن اشتها همراه است. در پیشگیری از این بیماری، رعایت اصول بهداشت فردی، بهسازی محیط و مایه کوبی از جمله اقدامات اساسی به شمار می رود.

کزاز

این بیماری عفونی توسط باسیل کلستریدیوم نتانی ایجاد می شود. باسیل کزاز در لایه خارجی خاک و به صورت ساپروفیت در روده انسان و برخی حیوانات یافت می شود. این باسیل غالباً در نواحی پرجمعیت، در آب و هوای گرم و مرطوب و خاک غنی از نظر مواد آلی دیده می شود. امکان آلودگی برای زخمهایی که با اجسام تیز ایجاد می شوند و یا زخمهای نکروتیک چرکی زیاد است ولی با توجه به انتشار وسیع و جهانی میکروب احتمال آلودگی زخمهای بسیار | تمبر هم وجود دارد. از علایم بیماری، بی قراری، تحریک پذیری، سردرد، انقباض عضلات و قفل شدن فکها، اختلال در اعمال تنفسی و آسیب سیستم عصبی مرکزی را می توان ذکر کرد.

بیماریهای انگلی وجود انگل در روده کودک ممکن است مشکلاتی از قبیل از بین رفتن مواد غذایی اصلی به وسیله انگل و ابتلای کودک به سوء تغذیه، از دست رفتن مقداری از خون بدن کودک، اختلال در اعمال حیاتی و حتی انسداد روده ها به وجود آورد. کرمک (اکسیور) یکی از شایعترین انگلهایی است که کودکان را مبتلا می سازد. کرمی

است بسیار کوچک و شبیه به یک تکه نخ سفید. طول کرم تر حدود ۳ میلی متر و ماده آن قریب یک سانتی متر است. خروج کرم از مخرج و حرکت آن در ناحیه باسن، ایجاد تحریک و خارش میکند و سبب بی خوابی، بی قراری، عصبانیت و برخی عوارض دیگر در کودک می شود. آسکاریس انگل دیگری است که کودکان را مبتلا می سازد. طول کرم ماده در حدود ۲۰ تا | ۳۵ سانتی متر با قطر تقریبی ۵ میلی متر و کرم تر در حدود ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر با قطر تقریبی ۳ میلی متر است شایعترین شکایت کودک مبتلا، درد شکم است. بیمار ممکن است دچار حالت هوع، بی اشتهایی، لاغری، از دست دادن وزن، سوء تغذیه، بی خوابی و تحریک پذیری در هنگام خواب شود. اگر تعداد کرمها زیاد باشد، می توانند سبب انسداد روده نیز شوند. حتی عبور لاروهای گرم آسکاریس از ربه ممکن است علایم ریوی و همچنین حساسیت مانند کهیر و اسم به وجود آورد.

ژیاردیا نیز در زمره انگلهای روده ای است که هرچند در موارد زیادی آلودگی به آن ماعلایم بیماری همراه نیست ولی وجود دردهای شکمی در کودکان، پیدایش اسهال و پیوستهای مزمن و مکرر، ضعف و تاخیر در رشد، نفخ شکم، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، تب مستمر و سبک، با آلودگی به این انگل توأم بوده است.

اساس پیشگیری از انگلهای روده ای، بر رعایت اصول بهداشت فردی و محیط از قبیل وجود آب سالم، استفاده از توالتهای بهداشتی، دفع صحیح فاضلاب و مواد زاید و عدم استفاده از مدفوع انسانی به عنوان کود استوار است.

ایمن سازی در کودکان در قاموس علم پزشکی حاضر، جلوگیری از اشاعه بیماریهای واگیر در سه جهت اساسی انجام می شود. نخست مبارزه با بیماری یعنی درمان بیمار و پاکسازی محیط از راه مداوای حاملین سالم عامل بیماری؛ دوم مسدود کردن راههای انتقال و انتشار بیماریهای واگیر؛ و سرانجام افزایش مقاومت فردی در قبال بیماریهای واگیر با ایمن سازی (واکسیناسیون).

مقاومت و ایمنی

قدرت مقاومت هر جاندار دربرابر ابتلا به بیماری را ایمنی گویند که در دو نوع طبیعی و اکتسابی قابل مطالعه و بررسی است.

۱ـ ایمنی طبیعی ایمنی طبیعی مربوط به ویژگیهای ساختاری و فیزیولوژیک جاندار بوده و بر چند نوع است: الف ـ ایمنی نژادی: ایمنی بعضی از نژادهای یک نوع جاندار را نسبت به یک عامل بیماری زا، ایمنی نژادی می گویند. مثلاً در میان نژادهای انسان، سرخپوستان آمریکایی در برابر سل حساستر از سفیدپوستان اروپایی اند و با کلیه سیاه پوستان آفریقایی و هفتاد درصد از سیاه پوستان آمریکایی نسبت به بیماری مالاریا مقاوم اند.

ب - ایمنی گونه ای، حساسیت یا مقاومت نسبت به یک عامل بیماری زا، از گونه ای به گونه دیگر تفاوت میکند. کلیه عواملی که در پیدایش ایمنی گونه ای دخالت دارند هنوز به درستی شناخته نشده اند ولی اختلاف در متابلیسم، فیزیولوژی و ساختار تشریحی گونه ها بدون شک از عوامل مؤثر در این مورد هستند. مثالی که می توان بدان اشاره کرد حساسیت انسان نسبت به بیماری مقاربتی سوزاک است که سایر جانوران در برابر آن مقاوم اند.

- ایمنی فردی در میان افراد یک گونه، مقاومت یک فرد در برابر یک بیماری با مقاومت فرد دیگر یکسان نیست. مثلاً برخی مرتباً سرما می خورند ولی عده ای دیگر هرگز به سرماخوردگی دچار نمی شوند. یا در میان اطفال یک خانواده ممکن است فقط یکی به بیماریهایی مانند سرخک و آبله مرغان دچار شود. این نوع مقاومتها را مقاومت فردی می گویند. این تفاوت در حساسیت به میکروارگانیسمها، به سن، شرایط فیزیولوژیک بدن، عوامل وراثتی و محیطی و تغذیه ارتباط دارد. طبق یک قاعده کلی، بیماریهای عفونی، اعم از میکروبی و ویروسی و غیره، در سالهای آغازی و پایانی زندگی انسان با شدت بیشتری پدیدار می شوند

۲- ایمنی اکتسابی ایمنی اکتسابی مصونیتی است که موجود زنده پس از ورود میکروارگانیسمها با ترکیبات آنها به بدنش به دست می آورد. از آنجا که ایمنی اکتسابی در برابر میکروارگانیسم یا ماده سمی . حاصل می شود، آن را غالباً ایمنی ویژه نیز می گویند. این نوع ایمنی در دو نوع زیر قابل بررسی است.

الف - ایمنی اکتسابی طبی ایمنی اکتسابی طبیعی خود به دو نوع فعال و غیر فعال تقسیم می شود. در نوع فعال آن، بدن براثر ابتلا به بیماری، با فعالیت زیستی خود، پادتن می سازد. ساختار شیمیایی جسم میکروارگانیسم یا تراوشات آن برای میزبان بیگانه است و پادگن محسوب می شود. این مواد بدن میزبان را برای تهیه پادتن تحریک میکنند و پادتن پس از ساخته شدن و ورود به پلاسما، پادگن را خنثی میکند. نتیجه این عمل، بهبودی تدریجی بیماری است. برحسب نوع میکروارگانیسم بیماری زا، پادتن مدتی یا برای همیشه در بدن میزبان باقی می ماند و ایجاد ایمنی موقت یا دایم میکند.

در ایمنی اکتسابی طبیعی غیرفعال، بدن از راه طبیعی ولی بدون فعالیت زیستی، پادتن ساخته شده را دریافت میکند، مثل نوزادانی که همواره مقداری پادتن مادر را، از راه جفت در دوران جنینی دریافت می دارند و یا از راه شیر مادر، مقداری از پادتن او را به خود منتقل میکنند. این نوع ایمنی دوام زیادی ندارد و پس از چند ماه از بین می رود.

ب - ایمنی اکتسابی مصنوعی: در این نوع ایمنی، تولید پادتن براثر وارد کردن عمدی و مصنوعی پادگن در بدن صورت میگیرد، بدون اینکه شخص بیمار شود. این نوع ایمنی نیز خود به دو شکل فعال و غیرفعال تقسیم می شود. در شکل فعال آن، پادگن ضعیف و بی اثر شده بیماری را عمداً وارد بدن شخص سالم میکنند تا سیستم ایمنی او را تحریک کنند. در این حالت، شخص بدون اینکه بیمار شود، پادتن بیماری را می سازد و در بدن خود نگه می دارد. در آینده چنانچه عوامل بیماریزای فعال همان بیماریها وارد بدن او شوند، با مقاومت رو ببرد می شوند و از بین می روند. واکسیناسیون بر علیه بسیاری از بیماریهای ویروسی و باکتریایی، براساس این نوع ایمنی استوار است. در ایمنی اکتسابی مصنوعی غیر فعال، شخص مصنوعا و بدون فعالیت زیستی، پادتن دریافت میکند، به این صورت که از سرمهای پادتن دار پیش ساخته استفاده می شود. در حال حاضر، وارد کردن پادتن آماده به بدن کمتر از گذشته مورد استعمال دارد و از آن فقط در موارد به خصوص کمک گرفته می شود.

برنامه واکسیناسیون کودکان با توجه به شرایط بهداشتی ایران در مورد زمان شروع واکسیناسیون، فاصله بین نوبتهای مختلف واکسنها، مواردی که از انجام واکسیناسیون باید خودداری شود، ضمن آنکه اصول کلی مشترکی در سرتاسر جهان وجود دارد، ممکن است در بعضی موارد در برنامه ریزی کشورها تفاوتهایی وجود داشته باشد. در حال حاضر در سرتاسر ایران، تمام ارائه کنندگان خدمات بهداشتی – درمانی ملزم به رعایت برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مورد هستند. اگرچه ممکن است در آینده برحسب شرایط اپیدمیولوژیکی و پیشرفتهای عملی و برنامه های تحقیقاتی، تجدید نظرهای لازم در این زمینه، همانند تغییرات مکرری که تا به حال داشته ایم، به عمل آید،

۱ واکسنهای سه گانه، کزاز و دوگانه در مقابل یخ زدگی تغییر ماهیت می دهند که در این صورت از مصرف آن باید جدا خودداری شود

۲- کلیه واکستها باید تا لحظه تجویز در حرارتهای ذکر شده نگهداری شوند.

۳- حلال واکسنهای سرخک و ب ث ژ، در واحد مصرف کننده باید در یخچال نگهداری شود.

فصل دوازدهم

اختلالات رفتاری در کودکان

کودکی که سالم به دنیا می آید، در بهترین حالت خود آفریده می شود. وی آمادگی و ظرفیت آن را دارد که به شایسته ترین وجهی پرورده شود و به برترین کمالات دست یابد. کافی است عادی به دنیا بیاید و خانواده و محیطی مناسب در اختیارش باشد تا ببالد و رشد و نما کند و جای ارجمند خویش را در این جهان بیابد.

اما زندگی خانوادگی و محیط بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از مردم جهان چنان است که دستیابی به چنین مقصودی را دشوار و گاه امکان ناپذیر می سازد. مشکلات رفتاری کودکان نیز که نتیجه اجتناب ناپذیر فقر، بیماری، جهل، بدرفتاری و نابسامانیهای خانوادگی و کاستیهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است، شدیداً مانع رشد و بالندگی و وصول آنان به کمالاتی است که در خلقتشان مقدر شده است. با توجه به اهمیت خاص موضوع، این فصل از کتاب به بررسی مشکلات رفتاری در کودکان اختصاص یافته و سعی شده است رایجترین اختلالات رفتاری کودکان و راههای پیشگیری و درمان آنها مورد بحث و گفتگو قرار گیرند.

۱ـ مشکلات کنترل ادرار و مدفوع بی اختیاری دفع ادرار در کودکان معمولا پس از سه تا چهار سالگی، زمانی که انتظار می رود کودک استفاده از توالت را آموخته باشد، مورد توجه قرار میگیرد. این مشکل در شب شایعتر از روز و در بین پسران بیش از دختران دیده می شود. اغلب اوقات بی اختیاری ادرار را چنانچه اختلالات دستگاه ادراری در میان نباشد، نشانه ناراحتیهای عاطفی یا روانی می دانند. گاه نیز بی اختیاری ادرار، نشانه اختلالات عصبی است.

بی اختیاری در دفع مدفوع یکی دیگر از مشکلات دوران کودکی است و به وضعی گفته می شود که فرد، بدون داشتن علت عضوی، در لباس یا سایر محلهایی که از نظر اجتماع پسندیده نیست دفع مدفوع کند. درباره ستی که بی اختیاری در دفع مدفوع اختلال شناخته شود، همچون مورد بی اختیاری ادراری، توافقی وجود ندارد، لیکن به طور تقریب چنانچه کودک پس از ۳ سالگی قادر به کنترل مدفوع خود نباشد، می توان آن را نوعی مشکل در رفتار طبیعی کودک دانست. ضمناً رقمی که در اکثر موارد گویای رواج بی اختیاری در دفع مدفوع در میان کودکان باشد ۵/۱ درصد برآورد شده است.

درباره علل بی اختیاری دفع مدفوع، نظرهای مختلفی وجود دارد. برخی این امر این امر را نتیجه نارساییهای رشدی در ساخت و کار مکانیسمهای فیزیولوژیکی و تشریحی مورد نیاز برای کنترل روده می دانند. عده ای آن را به تعارضهای عمیقتری نسبت می دهند و گروهی بر نادرست بودن روند آموزش استفاده از توالت تأکید دارند.

درمان بی اختیاری دفع مدفوع، نسبت به بی اختیاری دفع ادرار، توجه کمتری به خود معطوف داشته است. شیوه طبی درمان بی اختیاری دفع مدفوع بر استفاده از داروها تکیه داشته است، حال آنکه در شیوه های رفتاری، رفتارهای صحیح استفاده از توالت و تشویق و تنبیه مد نظر است. در این روش استفاده صحیح از توالت و داشتن شلوار تمیز، مثبت تلقی می شود و برعکس، خراب کردن شلوار، حذف امتیازهایی از کودک را به عنوان تنبیه به دنبال دارد. موفقیت و طول مدت برنامه به پای بندی والدین در اجرای دقیق آن بستگی دارد و در صورت وجود رابطه صحیح بین والدین و کودک، نتیجه کار رضایت بخش خواهد بود.

۲ـ اختلالات مربوط به خوابیدن خواب بر اثر فشارهای روانی و مشکلات عاطفی فرد، بلافاصله دچار اختلال می شود. دیدن کابوسهای ترسناک، وحشت زدگی شبانه، راه رفتن در خواب، فشردن دندانها در خواب و گفتار در

خواب از اهم این اختلالات به شمار می روند. اغلب اختلالات خواب با تغییر مشکلات محیطی طرف می شوند. مثلا، استفاده از چراغ خواب برای کودکانی که از تاریکی هراس دارند، تأمین | آرامش خاطر کودک، در نظر گرفتن وقت مناسب برای استراحت کودک و پوشش نرم و سبک با حرارت مطبوع، از جمله مواردی هستند که در درمان اختلالات خواب مفید و موترند.

۳ـ اختلالات تکلم و زبان زبان وسیله ورود انسان به دنیای داد و ستد متقابل است. تکلم و زبان از ابزارهای مهم انسان برای دریافت پدیده های جهان هستی و نیز وسیله ای است برای انتقال تفکرات، احساسات و عواطف انسان به دیگران. تکلم و زبان حاصل مجموعه ای از کنشهای پیچیده و متقابل تواناییهای ذهنی و محرکهای محیطی و نیز توانایی دریافت با شنیدن و همچنین توانایی بیان یا استفاده از دستگاه گویایی پیشرفته انسان است.

مشکلاتی چون تأخیر در تکلم و لکنت زبان، عمده ترین اختلالاتی هستند که کودکان ممکن است به آن دچار شوند. تأخیر در تکلم. این اختلال به علل مختلفی از قبیل پایین بودن بهره هوشی، فلج عضلانی، نقایص شنوایی، انحرافات و ناهنجاریهای دستگاه تکلم و نیز امراض و ضایعات دیگر مغا بروز میکند و چنانچه بیش از سه و نیم سالگی طول بکشد غیر عادی تلقی می شود و می بایست برای کشف علل و نیز درمان آن اقدام کرد. لکنت زبان: لکنت زبان عبارت است از مکث در بیان واژه ها و تکرار آنها. شخص مبتلا به لکنت به کسی می ماند که بر اثر ترس و یا ذوق زدگی زبانش گرفته باشد. فردی که لکنت زبان دارد، گاهی در بیان هر گونه واژه ای در می ماند و سپس با کسب آرامش و برطرف شدن انقباض ماهیچه ها، چندین واژه را به تندی بیان میکند و بار دیگر کلام وی قطع می شود. چگونگی لکنت زبان در افراد گوناگون و حتی در خود فرد در زمانهای گوناگون متفاوت است. این بیماری در اکثر موارد با عواملی چون تشویش، عدم اعتماد، عقده ها، اختلالات روانی و غیره مرتبط است.

درمان لکنت زبان شامل دو مسئله می شود. مسئله اول، روان درمانی است که بتواند مشکل اصلی کودک را برطرف کند. مسئله دوم، درجه ای از درمان کلامی لازم است تا شخص طرحهای به غلط آموخته شده را از دست بدهد. درجه موفقیت هر یک از این دو روش فرق می کند اما لازم است که هر دو روش را با یکدیگر به کار برد. بعضی از کودکان با تمام روشهای درمان روانی و درمان کلامی، باز هم تحت تأثیر حالات هیجانی، مختصری لکنت زبان در آنها باقی می ماند در حالی که لکنت زبان بعضی از کودکان با این روشهای درمانی به کلی اصلا ۴- دستکاری قسمتهای مختلف بدن شرایط نامساعد محیطی گاهی موجب می شود که کودکان به دستکاری قسمتهای مختلف بدن بپردازند. این کودکان ممکن است قسمتهای مختلفی از بدن را برای دستکاری انتخاب کنید که مهمترین آنها عبارتند از: مکیدن انگشت، جویدن ناخن، دستکاری بینی و آلت تناسلی، حاق شرایط نامساعد محیط و کاهش فشارهای عاطفی و روانی کودکان و همچنین پر کردن اوقات فراغت آنان با فعالیتهای مفید و سرگرم کننده، ممکن است نتایج رضایت بخشی در درمان این ناهنجاری داشته باشد.

۵- اختلالات تغذیه ای با توجه به ارتباط مهمی که بین غذا و هیجانات کودک موجود است، برخی مشکلات تغذیه ای ناشی از این امر، نظیر بی اشتهایی روانی و چاقی، ممکن است نزد کودکان مشاهده شود بی اشتهایی روانی در کودکان یا امتناع مداوم از خوردن غذا عوامل متعددی دارد دوگانگی عاطفی کودک نسبت به مادر، ضایعات هیپوتالاموس، وسواس، افسردگی، مجبور کردن کودک به خوردن و رعایت انضباط خشک بر سر میز غذا، تداعی و تلقین نسبت به غذاها از جمله این عوامل هستند. در درمان این مشکل، توصیه می شود که ضمن همکاری با پزشک، والدین از تغذیه اجباری کودک خودداری کنند و با ایجاد محیط شاد و سالم پر سر میز غذا و تنوع در انواع غذاها، در سالم سازی شخصیت و رفع عوارض عصبی وی بکوشند.

برخلاف تصور پرخوری و چاقی را نشانه سلامتی می دانستند، پژوهشهای اخیر نشان داده است که این امر با مشکلات تندرستی متعدد و پی آمدهای اجتماعی و روانی نامطلوب همراه است. لذا می بایست جلوی این ناراحتی کودکان نیز گرفته شود.

۶- فرار از مدرسه منظور از فرار از مدرسه این است که کودک به قصد مدرسه رفتن از منزل خارج می شود. ولی به جاهای دیگری غیر از مدرسه می رود و یا پس از ورود و گاهی پس از ماندن مختصری در مدرسه، از آنجا بیرون می رود. این ناراحتی با بزرگتر شدن کودکان، بیشتر جنبه مشکل و ناسازگاری پیدا میکند. بسیاری از این گونه کودکان احتمالا متعلق به خانواده های از هم گسیخته یا دارای والدین و خواهر و برادر بزهکار هستند، تعدادی نیز بر اثر تغییر مکرر مدرسه و با رد شدن و تکرار کلاس، از مدرسه بیزار می شوند. این مشکل که در پسران بیش از دختران مشاهده می شود، نشانه ای است از وجود اشکال در برنامه های مدرسه و همچنین دلالت بر ناسازگاری کودک دارد. لذا درمان آن نیز مستلزم اقدام در هر دو زمینه مذکور خواهد بود.

7- هراس از مدرسه هراس از مدرسه با گریز از مدرسه تفاوت دارد. مدرسه گریزان معمولا به تناوب از مدرسه غایب می شوند و پدر و مادرشان از موضوع اطلاعی ندارند، حال آنکه در هراس از مدرسه، کودک و ماندن وی در خانه آگاهی دارند. همچنین مدرسه گریزان بر عکس کودکانی که از مدرسه هراس معمولا به طور پیوسته و طی دوره های طولانی به مدرسه نمی رود و والدین از نرفتن به مدرسه دارند، معمولاً شاگردانی تنبلند که رفتارهای ناهنجاری چون دزدی و دروغگویی نیز دارند. برآوردها نشان می دهد که هراس از مدرسه در کمتر از یک درصد کودکان مشاهده می شود. رایجترین تصوری که درباره هراس از مدرسه وجود دارد این است که مادر و کودک به گونه ای شدید به یکدیگر وابسته اند. وابستگی شدید کودک، این نرس را در وی به وجود می آورد که امکان دارد برای خود با مادرش اتفاقی روی دهد لذا ماندن کودک در خانه، نیازها و اضطرابهای هر دو را برطرف می سازد. درباره نقش پدر در این فرایند، اطلاعات اندکی در دست است. آنکه رایجترین توضیح برای هراس از مدرسه، اضطراب جدایی است، احتمالاً به رغم عاقلانه نیست که در تمام موارد این اختلال را ناشی از آن بدانیم چرا که برخی از متخصصین بر ترس واقعی کودک از مدرسه تأکید می ورزند. در درمان این مشکل، سعی در کاهش اضطراب جدا شدن از مادر یا اضطراب ناشی از محیط واقعی مدرسه، در رأس فعالیتهای درمانی است.

۸- کمرویی و انزواطلبی کمرویی و انزواطلبی یکی از جدیترین مشکلات کودکان است. انزوا و دوری از دوستان و همسالان در اوایل زندگی، کودک را در معرض خطر مشکلات سازگاریهای بعدی قرار می دهد. این نوع کودکان هرچند برای والدین و مربیان خود هیچ گونه ناراحتی ایجاد نمی کنند ولی به سب رنج ناشی از احساس ناامنی و بی کفایتی در خود، پیوسته به دنیای درون خویش پناه می برند و به مرور از اجتماعی شدن فاصله می گیرند و چه بسا گروهی از آنان نیز به بیماریهای روانی دچار می شوند.

کودک منزوی نیاز دارد که احساس کند عضو با ارزش یک یا چند گروه است. او هرگاه در فعالیتهای زندگی واقعی ارضا شود، نیازی به عقب نشینی به میدان رویاهای خویش برای ارضای | خواستهای اساسی اش نخواهد داشت. از این رو در درمان این مشکل، معلمین و والدین کودک | بایستی توجه داشته باشند که کودک کمرو و منزوی نیز دارای تواناییها و شایستگیهای ویژه ای | است که با راهنمایی و تشویق می توان آنها را ظاهر ساخت و این خود در اجتماعی شدن کودک | ستن به جمع دوستان و دوری از انزوا تأثیر خواهد داشت.

۹- زودرنجی و حساسیت فوق العاده حساسیت میرم کودک به تایید و تکذیب اجتماعی از سوی افراد مختلف به ویژه والدین همسالان و معلمان، زودرنجی را در او پدید می آورد، زودرنجی یکی از مشکلات رفتاری رایج بین کودکان دبستانی است. روان شناسان نقطه اوج حساسیت پسران را سن ۱۱ سالگی و دختران را تا دوره بلوغ می دانند.
زودرنجی تا حدودی مربوط به تمایلی زیاد کودک به پذیرفته شدن از جانب اجتماع است، گرایشی که او را شدیداً در معرض نگرشهای بزرگسالان و اعضای گروه همسن خود قرار می دهد. علاوه براین، زودرنجی و حساسیت شدید، شیوهای مؤثر برای جلب موافقت و تسلیم والدین است. کودک خیلی زود کشف می کند که برای رسیدن به هدف خویش، دعوا و مرافعه و منفی گرایی، سلاحهای نامناسبی هستند و کمتر نتایج مطلوبی به بار می آورند. در حالی که زودرنجی و حساسیت بیش از حد، موجب می شود تا والدین از اینکه کودک خویش را آزرده اند، احساس ناراحتی کنند و در نتیجه بکوشند تا کارها را بر وفق مراد او انجام دهند. مادام که کودک بتواند از این طرح در مواجهه با موقعیتهای تعارض انگیز سود جوید، زودرنجی باقی خواهد بود و از آنجا که بیشتر کودکان اغلب خود از این شگرد آگاهی دارند، از زودرنجی و حساسیت فوق العاده خویش، تنها در خانه استفاده می کنند. .

۱۰- حسادت حسادت واکنشی است که کودک نسبت به از دست دادن محبت واقعی، فرضی و یا تهدید به آن از خود نشان می دهد. در کودکان حسادت یک تجربه عاطفی معمولی است که غالباً از تولد خواهر یا برادر جدید سرچشمه می گیرد. حسادت به ویژه هنگامی که کودک نخستین فرزند خانواده است و بین دو تا پنج سال دارد، بیشتر دیده می شود. گاهی نیز حسادت در نتیجه تفاوت سنی خواهر و برادر به وجود می آید. کودک کوچکتر نسبت به امتیازات کودک بزرگتر و کودک بزرگتر به محبت و توجه فوق العاده نسبت به کودک کوچکتر حسادت می ورزد. گاه کودک نسبت به یکی از والدین به ویژه پدر حسادت می ورزد. این احساس احتمالا به خاطر تماس دایم با مادر و احساس تملک او به وجود می آید، حتی زمانی که کودک به مدرسه می رود و به خارج از محیط خانه گرایش می یابد، حسادت نسبت به خانواده الزاماً کاهش نمی یابد، زیرا کودک نگران است که مبادا خواهر با برادر کوچکتر او در خانه تمام محبت مادر را در غیبت او به خود اختصاص دهد. در بین کودکان کوچکتر، واکنش حسادت مستقیم و با غیر مستقیم است. واکنش مستقیم عبارت است از پرخاشگری که شامل لگد زدن، گاز گرفتن، ناخن کشیدن و کنک در رقیب و یا شخصی است که کودک آرزوی جلب توجه و محبت بیشتر او را دارد.

واکنش غیر مستقیم معمولا شامل بازگشت به رفتار کودکانه چون شب ادراری، مکیدن انگشتان، حلب توجه با ترسهای تازه، دل به هم خوردگی، خرابکاری، بدزبانی و فحاشی و گاه ابراز محبت غیر عادی است.

در بین کودکان بزرگتر پاسخهای حسادت امیر متنوعتر و غیرمستقیم تر است. برخاشگری در مدرسه و در زمین بازی، آزار رساندن به بچه های کوچکتر و حیوانات، خرابکاری، مخالفت گردنه بد خلقی، بی ادبی، شکایت کردند، نادیده گرفتن دیگران، دروغگویی، نقلیه به کار بردن کلمات زشت و بدگویی دیگران از جمله واکنشهای احتمالی این قبیل از کودکان به شمار می رود حسادت اغلب محصول موقعیت خانوادگی، به ویژه نگرش مادر و روشهای انضباطی او است. لذا مادرات باید از توجه بیش از حد نسبت به فرزندان خویش احتراز جویند و از به کار گرفتن شیوه های انضباطی ناهماهنگ و ناهمخوان که هر دو از عوامل تشدید کننده حسابت هستند بپرهیزند

۱۱- ترس ترس کودک از پدیده های مختلف به عواملی چون، سن، جنس، تجارب گذشته، میزان رشد ذهنی، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی که کودک از والدین و همسالان خویش آموخته و بالاخره درجه امنیتی که کودک از آن برخوردار است، بستگی دارد. در اوایل کودکی ترس جنبه موقعیتی دارد. افراد، اشیا، حیوانات و تاریکی ممکن است سبب ترس او شوند. در حالی که در سالهای پیش از نوجوانی، ترس، بیشتر جنبه تعمیمی دارد، یعنی کودک زمانی از چیزی ترسیده است و از آن به بعد آن را تعمیم می دهد. این نوع ترس غالباً با اضطراب و نگرانی همراه است. در درمان این مشکل، معلم یا والدین باید از شیوه ها و وسایل مختلف برای کمک به

کودکان در غلبه بر ترس خود استفاده کنند. برای از بین بردن ترس کودکان، نخست باید شی، یا موقعیت ترسناک را با دیگر حالات تفریحی و خوشحال کننده کودک همراه کرد. مثلا کودکی که ترس مرگباری از گربه دارد، باید به تدریج و در شرایطی که احساس امنیت و شادی کند و دور از هرگونه تهدید باشد، در نزدیکی و مجاورت گربه قرار گیرد. کودکی که از معلم با امتحانات به طور کلی می ترسد، به تجارب موفقیت آمیز در امتحانات و با معلمان نیاز دارد. به طور خلاصه باید به کودک کمک کرد تا مهارت و شایستگی لازم را کسب کند و در موقعیتهای ترسناک، شیره های عملی مناسب بیاید و آنگاه به تجربه فعال دست بزند.

۱۲ نگرانی

نگرانی گونه ای ترس خیالی است که با انگیزه های موجود در محیط کودک رابطه مستقیم ندارد منشا نگرانی کودکان ممکن است تصور پدیده ها و موقعیتهایی باشد که در صورت تحقق زبان آور و خطرناک هستند، نگرانی ممکن است از شنیدن با خواندن داستانها و شنیدن و دیدن برنامه های رادیویی و تلویزیونی ناشی شود. نگرانی در مراحل خردسالی وجود ندارد و تنها پس از آن که کودک توانایی به تصور آوردن پدیده ها و موقعیتها را به دست آورد، در آنان مشاهده می شود.

سه احتمالی از سوی والدین است. دیر رسیدن به سر کلاس، آسیه با سرزنش آمر کار، گزارشی مسائل خانوادگی و تحصیلی از عمده ترین علل نگرانی در بین کودکان به شمار می روند فراگیر ترین مسائل خانوادگی که نگرانی کودکان را سبب می شوند، بیماری افراد خانواده و فکر مدرسه، شکست در امتحانات و عقب ماندن از همکلاسیها از اموری هستند که در مدرسه موجب نگرانی کودکان می شوند. افزون بر اینها، از علل دیگری که موجب نگرانی در کودکان می شوند، می توان به موضوع تندرستی یا بیماری، تخیل مردن پاکسته شدن، نداشتن شایستگی شخصی و اجتماعی و مشکلات اقتصادی اشاره کرد. ایجاد انگیزه برای یادگیری مهارتهایی که به هنگام نگرانی به کار کودک بیاید و سعی در کشف تمایلات و استعدادهای وی و استران خاطرش از امور نگران کننده، از جمله اقدامات موثر در مبارزه با این نوع مشکل رفتاری است

۱۳ - اضطراب زمانی که نگرانیهای فرد شدت یابد، فرد دچار اضطراب می شود. اضطراب ناراحتی دردناک ذهنی درباره پیش بینی یک تهدید و یا ناخوشی در آینده است. از جمله ویژگیهای اضطراب، ترس و ناراحتی و پیش بینی مهلکه ای است که فرد راه فرار از آن ندارد و دریافتن چاره و راه حل احساس درماندگی می کند. با آنکه اضطراب از ترس و نگرانی ناشی می شود، ولی تفاوتهای آن دو دارد، اضطراب از ترس مبهم تر است و برخلاف ترس که از یک موقعیت در زمان حال ناشی می شود و براساس یک موقعیت پیش بینی شده به وجود می آید، فرد مضطرب اغلب از علت اضطراب خویش آگاهی ندارد و نمی داند که اضطراب، ناشی از احساس ناامنی در درون است و یا از موقعیت خارجی است که وی ترس خود را در آن می افکند. اضطراب مانند نگرانی بیشتر معلول تخیل است ولی در عین حال از دو جهت با نگرانی تفاوت دارد.

از یک جهت نگرانی مربوط به موقعیتهای خاص می شود مانند امتحانات و مشکل مالی و غیره، در حالی که اضطراب یک حالت عاطفی تعمیم یافته است. از جهت دیگر، نگرانی در مورد مشکلات عیسی است، حال آنکه اضطراب ناشی از یک مشکل ذهنی است.

اضطراب ممکن است به صورت رفتاری چون افسردگی، حساسیت شدید و عصبانیت، ناآرامی و بی قراری، زود عصبانی شدن بی خوابی و خراب ناراحت ظاهر شود و در موارد شدیدتر به صورت احساس گناه تجلی کند یکی از علایم مشخصه فرد مضطرب، پرکاری و یا کم کاری است. اضطراب بی شک نشانه مقدماتی عدم سازگاری در فرد است.

۱۴ـ لجاجت و کج خلقی سرکشی و لجبازی کودکان از حالات و رفتارهای ناسازگارانه ای است که در بسیاری از کودکان به چشم می خورد و نوعی نمایش احساس نفرت و خصومت نسبت به والدین و اطرافیان است

کودکان اجازه سرکش و عصبانی هستند و در برابر خواسته های والدین خود حالت ی و مقاومت نشان می دهد به هنده سایت ممکن است پاهای خود را بر زمین مقصرند و باعث رحمت وی شدهانی به مدت اشک بریزند و یا در دل خود را بر سر دیگران و یا اشتبا و اسباب بازی خود در آورند. این . گونه کودکان اغلب می کوشند خود را بر گناه جلوه دهند و عملا نشان دهند که والدین با اطرافیان بسیار است و وقت معلوم نیست که به عاملی او را به سوی عصیان سوق می دهد شدید جستجو کرد در عین حال باید اعتراف کرد که موارد ناشناخته در زندگی کودکان لجباز در درمان و جلوگیری کودکان از رفتار نابهنجارشان، مهمترین امر این است که نخست در مواردی می توان ریشه لجبازیها و سرکشیها را در تضاد عواطف هیجان بر اضطراب دریابیم چه عاملی سبب پیدایش این لجبازیها در آنها شده است؟ زمان پیدایش این حالات کی و چه هنگامی بوده و چه ساعات و مواردی تشدید می شود کودکان به خاطر چه امری بیشتر عادی می شوند و به امری آنها را از این حالات دور خواهد داشت و در کل چه باید کرد که این حالات در آنان تکرار نشود؟

دلیل اصرار به شناخت ریشه ها، عقل و انگیزه های این کجروی آن است که در حالتی نیاز به تصمیم گیری خاصی دارد که ممکن است در موارد دیگر کارآیی چندانی نداشته باشد

۱۵- بددهنی کودکان بددهن و ناسزاگو افرادی هستند کم حوصله، حساس و زودرنج که به اندک بهارهای خود را می بازند و هرچه در دل دارند به صورت فحش و ناسزاگویی بیرون می ریزند، مطالعه و بررسی درباره حالات و رفتار این نوع کودکان حاکی از این مسئله است که به دهنی می تواند نشانی از بیان خشم، تحقیر و تمطر دیگران، انتقام، عقده گشایی، شرارت و بدکرداری در آنان باشد این مشکل در کودکانی که در خانواده های نابسامان تربیت می شوند، با اطرافیان و کسان کودک بددهی و ناسزاگو هستند، همچنین در کودکان عصبی، بی قراره ضعیف السنیه و کم توان

بچه هایی که با دوستان بده من معاشر هستند بیشتر دیده می شود از نظر تربیت این گونه کودکان، ضروری است جلو بددهنی آنان گرفته شود و پدران و مادران در این رابطه هشیاری و آگاهیهای لازم را داشته باشند. آموزشهای لازم در طریق صحبت و معاشرت، کنترل دیدهها و شنیده های کودک، دادن اعتماد به نفس به وی، بی اعتنایی به کودک و خودداری از خنده در مواقعی که ناسزاگویی و بددهنی می کند، ابراز خشم، ممانعت از معاشرت کودک با دوستان نالایق و بالاخره انتظار و تهدید از جمله راههای اسلام این گونه کودکان است.

۱۶ـ خشم برخی از کودکان گاهی دچار حملات خشم می شوند و به طور ناگهانی واکنشهایی نظیر جمع زدن، لگد زدن، گاز گرفتن، خودزنی، خود را بر روی زمین پرتاب کردن، پرتاب اشیا و شک آنها از خود بروز می دهند. برخی محرکهایی که منجر به واکنشهای خشم آلود می شوند عبارتند از ایجاد محدودیتهای جسمی و حرکتی برای کودک، خواه وسیله دیگران یا بر اثر ناتوانیهای خود او، جلوگیری از انجام فعالیتهای جاری او، ایجاد مانع در رسیدن او به خواستها، برنامه ها و هدفهایش و بالاخره مجموعه ای از ناراحتیهایی که موجب ناکامی کودک می .. از آنجا که تکرار خشم موجب عادت می شود، بهتر است تا حد ممکن از انگیزه هایی که موجب می شوند، پرهیز کرد. باید به کودک آموخت چه هنگام خشمگین شود و چه هنگام خشم خود را فرو نشاند. بنابراین شیوه درست برخورد با خشم، در خود نگاه داشتن و به هیچ طریق آشکار نکردن آن نیست، بلکه می بایست آن را به مجراهای مناسب انداخت و با خودداری از رفتارهای نامناسب بر عادت خشم غلبه کرد.

17- پرخاشگری پرخاشگری در کودکان، چنانچه تحت کنترل صحیح نباشد، می تواند به صورت هیجان از هم پاشیده ای درآید. پرخاشگری بیش از حد طبیعی، نشان می دهد که کودک در یادگیری رفتارهای مطلوب در مواجهه با محرکهایی که خشم او را بر می انگیزد، شکست خورده است. صاحبنظران معتقدند که پرخاشگری ممکن است به علت ناکامیهای بنیادی یا وجود مدلهای پرخاشگرانه در محیط کودکان باشد. هر اندازه والدین در خانه پرخاشگرانه تر عمل کنند، فرزندان آنان بیشتر پرخاشگر خواهند شد. همچنین اعتقاد براین است که برخی از انواع پرخاشگریها در خانواده هایی که اجازه هر نوع پرخاشگری داده می شود و هرگز به طور جدی این رفتارها نهی نمی شوند، ریشه می دواند. هرگاه نیاز به تربیت و تعدیل پرخاشگری کودکان احساس شود، انجام اقداماتی چون آگاهی دادن به کودک در مورد حقوق دیگران، اقدام به رشد فکری کودک، آگاهی دادن به حفظ زشتی امر، رفع ناکامیها، ایجاد محیط صمیمی، ایجاد سرگرمی و اشتغال، دور نگه داشتن کودک از بدآموزیها و بها ندادن به لجبازیهای او در این زمینه مفید و مؤثر خواهند بود.

۱۸- دروغگویی تا سه یا چهار سالگی دروغ به مفهومی که برای بزرگسالان مطرح است در کودکان وجود ندارد. بنابراین، هرگاه در این سنین واقعیات به طور وارونه یا منحرف ارائه شود، هدف کودک کسب متیاز و قریب دیگران نیست اما از سن چهار سالگی به بعد تدریجاً بر اثر دخالتهای عوامل محیطی و تربیت نادرست، دروغ و دروغگویی در کودک شکل می گیرد و گاه انقدر شدید می شود که به صورت مرضی در می آید.

این قبیل کردکان به علت جلب تحسین و تمجید، قرار از تنبیه با نارضایتی والدین مخصوصا نسبت به کارهای مدرسه، متوسل به دروغ می شوند. همچنین احساس ناامنی در منزل و فقدان محبت والدین، سخنگیریهای زیاد و مشکلات خانوادگی نیز از جمله عواملی هستند که به دروغگویی کودکان کمک میکنند. به طور کلی بیشتر دروغها به سبب ترس از مجازات و نیز مورد مخالفت و استهزا واقع شدن گفته ، می شود.

درمان دروغگوییها در توجه به تربیت صحیح کودکان نهفته است. اگر والدین فرزندان خود را با اصول مهر و مودت پرورش دهند، اگر خانواده کانون عطوفت و مهربانی باشد، اگر اولیا کودکان به وظایف شرعی خود در قبال فرزندان عمل کنند و همواره راستی و صداقت محور توجهات قرار گیرد، بچه ها در برابر تخلفات خود به دروغ متوسل نمی شوند و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

۱۹- تقلب

تقلب رفتاری است غیر صادقانه، غیرشرافتمندانه و نامشروع، اینکه علل و انگیزه های تقلب کدامند و چرا کودک تن به تقلب می دهد، پاسخهای متعددی دارد که روش تدریس، بد نمره دادن معلم، سختی آزمون، بی نظمی در جلسه امتحان، ایجاد ترس از مردود شدن، عدم درک مسئولیت، تسلی و تن پروری، وسوسه ها، کثرت سرگرمی و حفظ آبرو از آن جمله اند. برای پیشگیری از تقلب، می توان از قبل زمینه سازی کرد و موجبات آن را در کودکان از بین برد. به عنوان مثال، آموزش ضوابط و مقررات، القاء ارزش کار شرافتمندانه، تضعیف خیانت و

تقلب، تدریس خوب، تذکر و پند، مراقبت و نظارت صحیح بر اعمال کردکان از جمله مواردی هستند که در اصلاح و پیشگیری از این کجروی می توانند به نحو بارزی مؤثر افتند.

۲۰- دزدی نزدی در کودکان کمتر از چهار تا پنج ساله نسبتاً نادر است. اما از هنگامی که مفهوم «مالکیت» و المجسین مفهوم «من» و «تو» یعنی جدایی از دیگری برای کودک معنا می یابد، دزدی نیز تدریجاً | به وجود می آید. گاه دزدی برای تملک اشیا و به ویژه هنگامی که شخص به آنها نیاز داشته باشد، صورت می گیرد، اما در بسیاری از موارد دزدی یک عمل انتقامی است و ممکن است اصولاً سازی به شی دزدیده شده نباشد. گاه نیز دردی برای کسب وجهه و ریاست کردن بر عده ای دیگر صورت می گیرد. . به لحاظ آنکه دزدی معمولاً با اختلالات دیگر رفتاری نیز همراه است، لذا برای درمان آن باید به شخصیت کلی و محیط تربیتی کودک توجه و دقت کافی کرد و در جهت رشد شخص و سازگاری هرچه بیشتر وی با محیط، اقدامات لازم را به عمل آورد.

روشهای درمانی در اختلالات رفتاری به طور کلی روشهای درمانی رفتارهای ناهنجار به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول درمانهای جسمی است که کوششی است در جهت کاهش یا برطرف ساختن نشانه های ناهنجاری، به ویژه جنبه هایی از رفتار که در عملکرد اجتماعی، حرفه ای و ذهنی بیمار اختلالاتی ایجاد کرده است روشهایی چون ایجاد ضربه الکتریکی، جراحی مغز و دارو درمانی که به وسیله آنها می توان با دخالتهای فیزیکی یا فیزیولوژیکی، در رفتار بیمار تغییراتی ایجاد کرد، در این گروه قرار دارند. گروه دوم روان درمانی است که کوشش میکند تا با ایجاد تغییراتی در شخصیت بیمار، دررفتار او تغییر دهد. هدف، بهبود کیفی سازگاری کلی بیمار به وسیله ایجاد یک سازماندهی بهتر در عوامل شخصیتی و محیطی اوست. این روش درمانی برحسب نوع مشکل فرد، میزان شدت آن و حاصلی که از روان درمانی عاید می شود، می تواند فرآیندی ساده یا بسیار پیچیده باشد. فنون شرطی کردن کلاسیک و شرطی کردن عامل که سعی در جایگزین کردن پاسخهای عاطفی مناسب به جای پاسخهای نامناسب و استفاده از پاداشها و برنامه های تقویت به منظور شکل دادن به رفتار بیمار دارد، از جمله روشهایی هستند که در رفتار درمانی کاربرد وسیعی دارند.

فصل سیزدهم

حوادث شایع در کودکان

طبق آمار موجود، مرگ و میر سالانه ناشی از سوانح دوران کودکی، به مراتب بیش از سایر علل و بیماریها در این دوران است. از این رو سوانح و حوادث را باید از مهمترین علل مرگ و میر در بین کودکان به حساب آورد. منزل، به ویژه آشپزخانه، خطرناکترین مکانی است که در آن، غالب حوادث دلخراش دوران کودکی، قبل از سن دبستان اتفاق می افتد که در اکثریت موارد، نتیجه ناآگاهی، بی دقتی، فراموشکاری و غفلت والدین است. مسائلی از قبیل نوع ساختمان و فضای پیرامون آن، تعداد جمعیت ساکن در خانه، کمبود فضای بازی، نوع دربهای شیشه ای، نبودن وسایل آتش نشانی و استفاده نکردن از وسایل ضد حریق، فقدان وسایل کشف دود و آتش، نوع سیم کشی ساختمان، زاویه های تند و تیز، نبودن درهای خروج اضطراری، وضعیت لوله کشی ساختمان، نوع راه پله ها، روشنایی ناکافی، فاصله زیاد نرده ها و یا محکم و ثابت بودن آنها، پنجره های بدون حفاظ و ... در نوع و ایجاد شدت سوانح تأثیر زیادی دارند. در فصل پایانی کتاب که به بررسی مختصر حوادث شایع در کودکان اختصاص دارد، به ذکر اهم موارد در این زمینه می پردازیم و برخی از راههای پیشگیری و کمکهای اولیه را نیز یادآوری خواهیم کرد.

سوختگی بسیاری از وسایل موجود در منزل برای کودکان خطرناک اند و ممکن است سبب پیدایش سوختگی به وسعت و شدت مختلف در آنها شوند. چای، قهوه، غذا و روغن داغ، چراغ خوراک پزی، بخاری، بخار آب داغ، وسایل الکتریکی بدون روپوش و ... در انتظار طفل معصوم و کنجکاری هستند که تازه به راه افتاده است. گاهی سوختگی با آب گرم حمام، بازی کردن با کبریت، عوامل شیمیایی و الکتریسیته، ممکن است سبب مرگ کودکان شود.

با کمی دقت و نظم می توان از بسیاری از سوختگیها جلوگیری کرد و کودکان را از خطرات زیادی دور نگه داشت، رعایت نکات زیر از آن جمله اند:

- در اتاقی که آتش روشن است هرگز کودک را تنها نگذارید.

- کبریت و چراغ را دور از دسترس کودکان قرار دهید. - ته سیگار خود را همیشه خاموش کنید زیرا ممکن است کودک سیگار روشن را بگیرد یا خاکستر گرم و داغ سیگار روی بچه بریزد و سبب ناراحتی اش بشود. مواظب کتری آب جوش باشید. مطمئن شوید که بر اثر وزش باد، آتش به پرده ها سرایت نکند.

- از رومیزیهایی که لبه آنها زیاد آویزان باشد استفاده نکنید، زیرا ممکن است کودک گوشه آویزان آن را بکشد و در نتیجه محتویات روی میز را به روی خود بریزد. - خطر سوختگی ناشی از انفجار دیگ زودپز و پریموس، چراغ گاز معمولی و پیک نیکی چراغ علاءالدین و ... را نباید از نظر دور داشت. دقت لازم در استفاده صحیح از آنها و در نظرگیری کلیه جوانب ایمنی، شرط اساسی است. - لباسهایی را برای کودک انتخاب کنید که قابلیت اشتعال کمتری داشته باشند. - وقتی کودک در بغل است، هرگز مایعات داغ ننوشید زیرا ممکن است بر اثر تکان خوردن و یا حرکت کودک بریزد و وی را بسوزاند. - هرگز بخاری برقی در حمام نگذارید و کودک را تنها در حمام رها نکنید.

- قوری برقی، قهوه جوش یا اطو برقی را از دسترس کودکان دور نگه دارید. - سیم وسایل برقی را پس از اینکه کارتان تمام شد جمع و از دسترس و میدان دید کودک دور کنید.

- به محض پوسیده شدن سیمها، آنها را تعویض کنید. - در محل خروج سیم برق از روکشهای ایمنی استفاده کنید تا کودک نتواند با انگشت خود یا چیزهای دیگر خطری را متوجه خود کند.

برای درمان سوختگیهای عمیق که با تاول همراه است، همچنین در مواردی که کودک انش گرفته و در حال سوختن است، بلافاصله پس از خاموش کردن آتش با پیچیدن کودک در تو، پالتو، ملافه و نظایر آنها، بایستی کودک را سریعاً به مراکز درمانی انتقال دهید. به یاد داشته خطرات سوختگی را بیشتر می کند. باشید که کودک در حال سوختن، هرگز نباید بدود زیرا جریان هوا در ایات آتش می افزاید و در سوختگیهای سطحی و حقیف که وسعت آن زیاد باشد، می تواند پماد مسکن سوختگی روی زخم بمالید و آن را پانسمان کنید. شما برای کنترل ناراحتی و بی قراری و مرده برحسب سن و وضع کودک، از داروهای مسکن می توان استفاده کرد.

سقوط از بلندی سقوط از بلندی غالباً از بالای تخت، میل، صندلی، پله ها، نردهها، پنجره، پشت بام و درخت اتفاق می افتد. شیوع صدمات ناشی از سقوط و پرت شدگی، به ویژه در کودکان شش ماهه تا سه ساله، فوق العاده زیاد است. علت اساسی و مهم این حوادث، تا حد زیادی، بی توجهی و عدم دقت کافی والدین است. در جهت پیشگیری از سقوط و پرت شدن کودکان، رعایت نکات زیرضروری به نظر می رسد نردبان و چیزهای دیگری را که کودک می تواند از آنها بالا برود، از دسترس او دور نگه تنها رها نکنید.

کودک پر جنب و جوش را هرگز در کالسکه اش – بدون مانع مخصوصی که از افتادن کودک جلوگیری میکند او را در تختخواب یا روی میز، حتی برای یک لحظه تنها نگذارید.
اگر کودکی در حضور شما می خواهد از نردبان یا پلهای بالا برود، یکی از دستهایتان را حتی المقدور به منظور گرفتن او در مواقع لزوم آزاد بگذارید.
همیشه از نردبان دو طرفه که ایمنی بیشتری دارد استفاده کنید.
هرگز به کودکان خود اجازه ندهید که روی پله ها بازی کنند. – اگر کودک به تازگی قادر به بالا و پایین رفتن از پله ها شده است، بهتر است نگذارید اشیایی با خود حمل کند.
در ورودی پشت بام را بهتر است میشه بسته نگه دارید. – پله ها بایستی به نرده های محافظ مجهز باشند. – پنجره اتاقها باید در ارتفاع مناسبی نصب شود تا کودک نتواند آن را باز کند و در نتیجه به بیرون پرت شود. – وقتی کودک بزرگتر شده و قادر است از گهواره به بیرون بپرد، باید وی را در تختخواب استخوانها و یا اظهار درد در صورت سقوط کودک از بلندی، زخمی شدن و یا شکستگی و ناراحتی شدید، لازم است او را به مراکز درمانی انتقال داد. در چنین مراکزی وظیفه پزشک است که از کودک مصدوم، معاینات فیزیکی کامل و دقیق به عمل آورد و وی را حداقل شش ساعت بعد از پرت شدگی و گاهی ۴۸ تا ۷۲ ساعت در مواقع احساس خطر، برای پروسی تغییراتی که در حالت هوشیاری و علایم عصبی موضعی، پدید می آید تحت نظر دقیق قرار دهید

مسمومیت
هر سال میلیونها نفر در سراسر دنیا دچار مسمومیت می شوند که بیشترشان را کودکان زیر پنج سال تشکیل می دهند. در این میان بسیاری از مسمومین تلف می شوند و بسیاری دیگر جان سالم به در می برند. شماری از مسمومین نیز پس از رهایی از مرگ به ناتوانیهایی نظیر آسیبهای کندی یا کلیوی یا آثاری که بر دستگاه عصبی مرکزی برجای می ماند مبتلا می شوند. همه این تلفات و عوارض از مواردی هستند که به راحتی می توان از آنها پیشگیری کرد. بسیاری از مسمومیتهای کودکان از غفلت و سهل انگاری پدر و مادر ناشی می شود. پدران و مادرانی که از مسیر رشد فرزندان خود بی خبرند از نهادن مواد مختلف در محل امن و مناسب غفلت می ورزند، یا مواد دارویی مختلف را در دسترس خردسالان قرار می دهند. در بین انواع مسمومیتها، آنچه بیش از همه شایع است، مسمومیت ناشی از خوردن
موادشیمیایی با دارویی است. چنانچه کودکی سمی خورده باشد یا دارویی را پیش از اندازه مجاز مصرف کرده باشد، خارج کردن فوری دارو یا سم از دستگاه گوارش کودک و پاک کردن آن به وسیله شستشو و دادن داروهای پادزهر از اهم اقداماتی است که در مراکز درمانی انجام می گیرد. بدیهی است تا رساندن کودک مسموم به مراکز درمانی، چنانچه بیمار را به استفاغ واداریم ممکن است مقدار زیادی از سم را بتوانیم خارج کنیم و اثرات عامل مسمومیت را کاهش دهیم استفاده از شربت ایپکاک برای واداشتن کودک به استفراغ یکی از روشهای مؤثر و مطمئن برای خالی کردن معده است. این داروی قی آور باید بی درنگ پس از خوردن سم به کودکی که در حالت بیداری و هشیاری است، به اندازه یک قاشق سوپخوری خورانده شود. در صورتی که تا بیست دقیقه استفراغ د دست ندهد، دارو باید تکرار شود. در صورت عدم دسترسی به شرت اینکاک، می توانید بی درنگ به کودک یک لیوان شیر یا آب ولرم بخورانید و با انگشت، حلق کودک را تحریک کنید و وی را سر پایین نگه دارید تا استفراغ کند و این عمل را چندین بار تکرار کنید.
لازم به یادآوری است در کودکان مبتلا به تشنج، اطفالی که در حال نیمه اغما با اعمای | کامل هستند و یا در مواردی که مسمومیت ناشی از مواد نفتی از قبیل نفت و بنزین و گازوئیل و یا مواد اسیدی و قلیایی باشد، از وادار کردن کودک به استفراغ، مصرف شربت ذکر شده و دیگر داروهای قی آور باید اجتناب ورزید.
در جهت پیشگیری از بروز مسمومیتهای شیمیایی و دارویی، چنانچه هشدارهای زیر مورد توجه قرار گیرند، از خطرات بسیاری از مسمومیتها می توان در امان بود.

هیچگاه به کودک نگویید که دارو چیز خوشمزه و خوردنی است، زیرا ممکن است باور کند و در غیاب شما مقادیر زیادی از آن را مصرف کند.
- در مورد مصرف داروها، دقیقاً دستورات پزشک را رعایت کنید.
- هرگونه اشیایی مانند مایع ظرفشویی، حشره کشهای مختلف، نفت، بنزین، گازوئیل، پودر ظرفشویی، مواد سفید کننده و غیره را باید از دسترس کودکان دور نگه دارید. - مواد سمی با قابل اشتعال را در طروف و نظریهای مربوط به مواد خوراکی قرار ندهید. - داروهای کهنه را دور بریزید و مطمئن شوید که حتی قوطی یا شیشه حالی آنها به دست کودک نیفتد. - هرگز غذایی را در جایی که در آن به تازگی حشره کش پاشیده اید قرار ندهید
- از مصرف مواد غذایی مشکوک و آلوده جدداً خودداری کنید. - هیچ گاه نفت، بنزین با سموم دیگر را در شیشه نوشابه نگه ندارید، زیرا ممکن است کودکان آنها را بنوشند.
- هرگز دارویی را در تاریکی بخورید و به دیگران نخورانید. - به کودک اجازه ندهید تا به کودک دیگر دارو بدهد
- تمامی مواد دارویی باید کاملاً سربسته و برچسب داشته باشند. - قبل از مصرف هر دارو باید دوباره برچسب آن را خواند و مقدار آن را بر حسب دستور پزشک با دقت هر چه تمامتر تعیین کرد. - لوازم و مواد آرایشی و رنگ مو و مواد مشابه را هرگز در دسترس و دید کودکان قرار ندهید
- توجه داشته باشید که بعضی از داروها را پس از آنکه قسمتی از آنها به مصرف رسید این نکته به خصوص در مورد نمی توان نگه داشت. این گونه مواد دارویی را بایستی دور ریخت، داروهای مایع بیشتر صدق می کند. - اگر روی ماده به خصوصی برچسب «سعی» زده شده است، آن را در جای قفل شده به طور جداگانه، دور از دسترس همگان، نگه دارید. - تاریخ فاسد شدن دارو را باید روی برچسب نوشت؛ بعضی از مواد دارویی بعد از مدتی خاصیت اصلی خود را از دست می دهند و پاره ای نیز ممکن است فاسد شوند و تولید مسمومیت کنند.
اجسام خارجی در بدن گاهی اجسام خارجی ب به عللی وارد بدن کودک . ند و عوارض مختلفی را موجب می گردند. مهمترین اعضایی که اجسام خارجی ممکن است در آنها وارد شود عبارتند از:

جسم خارجی در اعضای عضلانی: جسم خارجی ممکن است چوب، براده فلزات سنگ ریزه، شن یا سوزن و سنجاق و میخ باشد. ابتدا عضو ضایعه دیده را با دقت با یک مسلول ضد عفونی بشویید. اگر جسم خارجی سطحی است آن را در آورید و محل زخم را پس از شستشو پانسمان کنید. اگر سوزن یا ستحاق در بدن فرو رفته است دقت کنید که نشکند زیرا خارج کردن سوزن شکسته از بدن مشکل است و باقی ماندن آن نیز ممکن است تولید عوارض شدید کند. نظر به اینکه سوزن و سنجاق شئ خارجی اند و ممکن است آلوده به میکروب باشند.

امکان تولید عفونت نیز بیشتر می شود. لذا نو را بیمار را به پزشک برسانید تا هرچه زودتر سوزن را خارج کند. در مواقعی که سوزن یا سنجاق شکسته ولی قسمتی از آن بیرون است، به آرامی آن را بیرون بکشید. فراموش نکنید که تزریق سرم صد کزاز در این موارد بسیار ضروری است. جسم خارجی در چشم: اشیای خارجی ممکن است در روی کره چشم یا قرنیه بمانند یا آن را سوراخ کنند و داخل چشم شوند. وارد شدن کوچکترین شی در چشم باعث ناراحتی زیاد می شود. اگر اشیایی مانند شبشه، فلز و چوب باعث زخمی شدن چشم شوند و در آن فرو روند تنها راه، رساندن سریع مصدوم به مراکز درمانی است. در مورد اشیای خرد که روی پوست داخل پلک قرار گرفته باشند، می توان آنها را با دقت خارج کرد. برای این کار مریض باید از مالیدن چشم خودداری کند. اگر شی خارجی در پلک پایین است آن را با گوشه دستمال با قطعه پنبه وب می توانید خارج کنید. اگر شی در قسمت داخلی پلک بالاست، در حالی که بیمار به پایین نگاه م پلک بالا را به طرف بالا برگردانید با در حالی که مریض به بالا نگاه میکند، پلک را به طرف پایین بکشید تا شئ خارجی به وسیله اشک روی پلک پایین بیاید و خارج شود. اگر به این طریق جسم از چشم خارج نشد، با یک لیوان آب ساده، چشم را از طرف گوشه داخلی بشویید تا فشار آب، شئ خارجی را بیرون آورد.

بدین ترتیب نیز نتیجه نگرفتید، بیمار را به پزشک برسانید. اگر مواد شیمیایی وارد چشم شده باشد، خطر سوختگی، عفونت و کوری، بیمار را تهدید ی کند. در چنین مواقعی پس از شستن چشم با آب فراوان و باندپیچی آن، برای درمان اساسی، مصدوم را به مراکز درمانی برسانید.

جسم خارجی در گوش: در صورتی که کودکی اجسام فلزی کوچکی را داخل سوراخ گوش خود کرده باشد معمولا با شستشوی مجرای گوش خارجی، پزشک می تواند جسم خارجی را خارج کند ولی هرگز نباید برای موادی از قبیل دانه حبوبات که ممکن است جذب طوبت کنند، از این طریق اقدام کرد زیرا بر اثر جذب آب، متورم و خارج ساختن آنها مشکلترمی شود.

اگر حشره ای وارد گوش شده و زنده باشد، غالب اوقات کافی است منبع نور شدیاری در جلوی سوراخ مجرای گوش خارجی قرار دهید تا حشره به طرف روشنایی بخرد و به طرف خارج پرواز کند. می توانید چند فطره الکل، روغن زیتون، روغن بادام و یا پارافین در گوش بچکانید و پس از چند دقیقه سر را به سوی دیگر برگردانید به طوری که گوش به طرف پایین قرار گیرد. بدین ترتیب ممکن است مایع و حشره مرده از گوش بیرون آید.

اگر با اقدامات فوق حشره خارج نشد، مصدوم را باید به مراکز درمانی رسانید. توجه داشته باشید که هرگز برای خارج ساختن اجسام از گوش، از سنجاق با چیزهای نوک تیز استفاده شود جسم خارجی در بینی: این ضایعه معمولا در کودکان خردسال دیده می شود. در این گونه موارد بهتر است پدر و مادر از دستکاری حفره بینی خودداری کنند. چنانچه مادری متوجه شود که از سوراخ بینی طفلش، ترشحات غلیظی خارج می شود و یا بینی کودک بوی تند و زننده و متعفنی همراه با ترشحات غلیظ دارد، باید فوراً جریان را به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی اطلاع دهد تا جسم خارجی بیرون آورده شود. در بسیاری از موارد احتیاج به عکس برداری از بینی است. در صورتی که کودک جسم خارجی را داخل بینی خود کرده باشد و والدین زود متوجه شوند ممکن است چند عطسه سبب بیرون راندن جسم خارجی شود. در غیر این صورت پزشک با وسیله مناسبی، پس از آرام و گاهی بیهوش کردن کودک، جسم را بیرون می آورد.

جسم خارجی در گلو: گاهی لقمه غذا، سکه، حلقه انگشتر و اجسام خارجی دیگر در گلو گیر می کند و کودک دچارکبودی، تنگی نفس و سرفه می شود. در این حالت با ایجاد سرفه یا زدن به پشت کودک بین دو شانه، در حالی که سر پایین قرار است، ممکن است این اشیا به بیرون پرتاب شود. اگر جسم خارجی به این ، از گلو خارج نشود و بیمار طفل باشد، مچ پای او را بگیرید و بالا نگاهدارید و با دست به پشت او بزنید تا شئ خارج شود. در بیمار بزرگتر، اگر ماده غذایی یا لقمه در گلو گیر کرده باشد، در حالی که دهان بیمار باز و زبانش پایین است، در پشت او قرار بگیرید و دو دست خود را دور کمرش حلقه کنید و در ناحیه معده فشار محکمی از پایین به طرف بالا وارد کنید. این عمل باعث بالا رفتن پرده دیافراگم در داخل شکم شده و فشار قابل ملاحظه ای به هوای ریه و های وارد می کند و باعث خارج شدن لقمه غذا می شود چنانکه جسم خارجی با اقدامات خارج نشد، پاک کردن دهان و گلو از اجسام را به عنوان آخرین گام آزمایش کنید و در صورت عدم موفقیت، بیمار را سریعاً به مراکز درمانی برسانید. و تنگی نفس شود و قبلا هیچ گونه ناراحتی جسم خارجی در دستگاه تنفس: در صورتی که کودکی به طور ناگهانی دچار خس خس نداشته باشد باید به فکر جسم خارجی در دستگاه تنفس او بود به خصوص اگر سرگرم خوردن پسته، فندق یا نخود بوده است و یا با اجسام کوچک و گرد بازی می کرده است. در این گونه موارد غالباً نیاز به عکس برداری از ریه هنگام دم و بازدم و همچنین احتمال برونکوسکپی بعد از بیهوش کردن کودک هست. بنابراین، متخصص اطفال و گوش و حلق و بینی را با خبر سازید.

جسم خارجی در دستگاه گوارش: چنانچه جسم خارجی بلعیده شده در اندازه های کوچک باشد به نحوی که بتواند از مری به درون معده عبور کند و فاقد هرگونه تیزی و برندگی باشد، معمولاً به آسانی از روده ها عبور میکند و همراه مدفوع خارج می شود. لیکن خارج ساختن اجسام نسبتاً بزرگ و نوک تیز نیازمند مراجعه به پزشک و گاهی اعمال جراحی است. جسم خارجی در مهبل: در خیلی از موارد، کودک به علت کنجکاوی با خارش و یا بصورت استمنا ممکن است جسمی را وارد مهبل خود کند. در این گونه موارد، در صورتی که مدتی از آن گذشته باشد، ترشحات غلیظ و متعفنی به وجود می آید که بهتر است سریعاً توسط پزشک معاینه و بررسی و جسم خارجی بیرون آورده شود

خفگی علاوه بر ورود اجسام خارجی در مجاری تنفسی که می تواند به خفگی کودکان منجر شود. عوامل دیگری نظیر مسمومیت با گازهای سمی، خفگی بر اثر غلطیدن روی کودک، پیچیدن طناب یا کش به دور گردن نیز ممکن است باعث خفگی شوند. مسمومیت با گازهای سمی شایعتر است. در صورت بروز چنین حادثه ای، لازم است سریعاً بیمار را در هوای آزاد قرار دهید و یقه، کمر و لباسهای او را شل کنید. در صورت نیاز، به تنفس دهان به دهان بپردازید و پزشک . مطلع سازید. در جهت پیشگیری نیز، رعایت نکاتی را به شرح زیر می توان یادآور شد: - وسایل گازسوز را به طور مرتب بازدید کنید که معیوب و نشتی نداشته باشند.

- نواقص سیلندر، رگولاتور، شیلنگ، اجاق گاز و دیگر وسایل گازسوز را هرچند هم جزئی باشند، نادیده نگیرید و سریعا در رفع آنها بکوشید.
- به کودکان خردسال و افراد ناوارد اجازه ندهید از وسایل گازسوز استفاده کنند. – بخاری و آبگرمکن گازی و نفتی باید مجهز به دودکش باشند، به این مهم همواره توجه کنید.
- هیچ گاه آبگرمکن گازی را در حمام نصب نکنید. – همواره دقت کنید تا شعله گاز بر اثر وزش باد و سر رفتن غذا، خاموش نشود و جریان گاز نشت نکند.
- همیشه از لوازم استاندارد و مورد اطمینان برای اتصال قطعات وسایل گازسوز به یکدیگر استفاده کنید
- - برای حصول اطمینان از نشت نکردن گاز، پس از نصب سیلندر به دستگاه گازسوزه
- محل خطر ناک و اتصالات مربوطه را باکف صابون آزمایش کنید (به کار بردن کبریت برای این منظور مطلقاً ممنوع است). هنگام احساس بوی گاز، از زدن کبریت و فندک و روشن و خاموش کردن وسایل برقی خودداری کنید، فوراً شیر گاز را ببندید و پنجره ها را باز کنید. به علت اینکه وزن مخصوص گاز
- مایع سنگینتر از هواست، در صورت نشت گاز، سعی کنید دریچه های پایینی محل انتشار باز و از آن محل، گاز را خارج کنید. - تعمیر وسایل گازسوز را فقط به افراد متخصص بسپارید. - اجازه دهید کودک تنها بخوابد و او را در تختخواب خودش آزاد بگذارید.
- خردسال را نباید در تختخواب والدین خواباند زیرا والدین در ضمن خواب ممکن است روی او بغلطند و او را خفه کنند.
- - اتاق کودک باید تهویه مناسبی داشته باشد لذا باز گذاشتن در اتاق، - هنگام زمستان از ضروریات است... کلاه گوشی از نوعی که بند آن محکم زیر گلوی نوزاد بسته می شود، ممکن است هنگام خواب سبب خفگی نوزاد شود. از گذاشتن چنین کلاههایی به سر نوزاد پرهیز کنید. - خطر دیگری که ممکن است از طرف مادر، کودک را تهدید کند، به خواب رفتن مادر هنگام شیردادن است. چه بسیار دیده شده است که مادر در خواب، روی دهان کودک خود افتاده و او را خفه کرده است. سعی کنید هنگام شیر دادن به نوزاد، بیدار باشید. - هرگز به کودک خردسال اجازه ندهید طناب یا کشی را به عنوان وسیله بازی، دور گردن خود بپیچد
- خطررفتن به یخچال یا کمد و امثال آن و بستن در آن، نباید فراموش شود کودک ممکن است این کار را در مورد کودک دیگر م دهد. لذا دقت نظر والدین در این مورد نیز بسیار مهم است.
- حوادث ناشی از وسایط نقلیه سوانح ناشی از وسایط نقلیه در مورد اطفال و کودکان خردسال، غالباً مربوط به داخل ماشین یا ضمن تصادف آن رخ می دهد در حالی که در سنین بالاتر، کودکان رهگذر بیشترین خطرات و متحمل می شوند. در میان رهگذران پیاده، بیشترین حادثه در بین کودکان پنج تا نه ساله آن در بین جوانان هجده تا نوزده ساله به چشم می خورد. در پیشگیری از سوانح مربوط به رهگذران پیاده، بهبود رفتار رانندگان، بهسازی راهها و پیاده روها و وسایط نقلیه، رعایت قوانین رانندگی و منع استعمال نوشابه های الکلی و ... بسیار مؤثر است. همچنین آموزش به کودکان و تأکید بر جلوگیری از خروج خودسرانه و بدون همراه آنان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال، خطر دویدن در وسط خیابان برای گرفتن توپ را باید به کودک گوشزد کرد. کودک ممکن است پشت ماشین بدود که در صورت ترمز کردن ناگهانی و یا عقب آمدن آن، همواره امکان خطر وجود دارد. شدت تصادفات در داخل وسیله نقلیه و یا به بیرون افکنده شدن سرنشین از آن، بستگی به سرعت وسیله نقلیه و وسایل داخل آن و نوع و مسیر حرکت دارد. قبل از شروع به رانندگی لازم است از سالم بودن ماشین به ویژه لاستیکها و ترمز و قفل دربهای ماشین و همچنین همراه داشتن وسایل ایمنی لازم مطمئن بود.
- در طراحی ساختمان ماشین، وسایل داخلی آن مثل رادیو، ساعت و غیره چنان باید طراحی و ساخته شده باشند که در تصادفات و ترمزهای ناگهانی و برخورد کودکان به آنها، آسیبهای کمتری را موجب شوند. نوع ماشین ، زمان مسافرت (شب یا روز) و یا روزهای مختلف هفته و طول فاصله محور جلو و عقب ماشین در میزان و شدت تصادفات و آمار مرگ و میرهای ناشی از آن مؤثرند.
- برنامه ریزان و خبرگان علاقه مند و متعهد به تندرستی مردم، باید پیوسته در بهبود طرح
- ساختمان ماشینها و بهسازی جاده ها و آموزش سرنشینان و رهگذران کوشا باشند. بدیهی است تدوین مقرراتی از قبیل کاهش میزان سرعت مجاز رانندگی، افزایش سن مجاز برای دریافت گواهینامه رانندگی، محدود کردن ساعات رانندگی در روزهای شلوغ هفته و ملزم کردن رانندگان به استفاده دایم از کمربند ایمنی نیز در کاهش حوادث ناشی از وسایط نقلیه کمک مؤثری هستند.

- غرق شدن در آب هرگاه کسی که شنا بلد نیست در آب بیفتد معمولا دچار هیجان و دستپاچگی می شود و به همین علت از کمک به خود عاجز می ماند و پس از مدتی نیز خسته می شود و به کلی از پا در می آید. غرق شدگی عبارت است از فرو رفتن کامل مجاری تنفسی در آب. غرق شدگان معمولاً به دو علت می میرند. یک خفگی (کمبود اکسیژن) و دیگر وارد شدن آب در ریه ها.
- در مورد نجات کودک غریق، دادن تنفس مصنوعی و اقدام به ماساژ خارجی قلب با کمپرس سینه (چنانچه قلب کودک ضربانی نداشته باشد) بسیار مهم است.
- با توجه به اینکه در بسیاری از حوادث از قبیل خفگی، برق گرفتگی، استنشاق گازهای خطرناک و همچنین غرق شدن در آب، ممکن است تنفس شخص متوقف شود و قلب هم ضربانی نداشته باشد، اقدام به تنفس مصنوعی و ماساژ خارجی قلب ممکن است جان مصدومی را نجات بخشد. از این رو، در این قسمت روش تنفس مصنوعی دهان به دهان و ماساژ خارجی قلب را مختصراً یادآور می شویم
- ر شرعی دهان به دهانه نفس مصنوعی دهان به دهان به راههای مختلفی انجام میشود که عملی تر، ساده تر و مفید ترین آنها تنفس مصنوعی دهان به دهان است که شرح داده میشود
- کودک را به پشت بر روی میز یا هر جای دیگری که به نظر شما ممکن است راحت تر بود بخوابونید. با انگشت خود به آرامی دهان و گلو را از مخاط و غذا و چیزهای دیگری که مانع تنفس میشود تمیز کنید.م سر کودک را به عقب و پایین بکشید تا چانه اش به طرف بالا قرار گیرد. سپس آرواره زیرین را به طرف جلو بکشید. با خم کردن سر به عقب، مجرای هوا از راه دهان به گلو باز می شود و با باز کردن دهان و کشیدن خانه به جلو (چون زبان به فک پایین چسبیده است) راه گلو بیشتر باز و در نتیجه بیمار برای تنفس دهان به دهان آماده میشود.
- هنگام جری تنفس مصنوعی نباید سر بیمار بالاتر از شانه هایش قرار گیرد. در صورت مکان بهتر است با گذاشتن بالش یا پتوی تا شده در زیر شانه های بیمار، سر او را کمی پایینتر از شش قرار دهید –
- با دهان باز لبهای خود را طرفین لبهای کودک قرار دهید و به آرامی نفس خود را در دهان کودک بدمین تا ریه هایش از هوا پر شود. چون صورت طفل کوچک است، می توانید در بینی و دهان او تواماً بدمید، ولی در بزرگسالان، بینی مصدوم را با یک دست ، گیرید و هوای موجود در ریه های خود را به شدت به دهان او می دمید تا بالا آمدن سینه او را حس کنید. سعی کده های عمیق حداقل دو ثانیه در دهان کودک بدمید دلیهای خود را از روی دهان کودک بردارید و بگذارید ریه ها جمع شود و هوای دمیده شده را خارج کند. در عین حال با دست آزاد خود فشار ملایمی روی شکم کودک بین ناف و دنده هایش وارد آورید و به این ترتیب نگذارید معده اش پر از هوا شود. متوجه ریتم تنفس باشید (۱۶ تا ۲۰ بار در دقیقه). اضطراب و نگرانی است شما را به تسریع وادارد و کار را بی نتیجه بگذارد –
- با تنفس عمیق ریه های خود را از هوای آزاد پر کنید و مجدداً دهانتان را روی دهان مصدوم بگذارید و در آن بدمید و این کار را تا برقراری تنفس بیمار ادامه دهید.

ماساژ قلب: هدف از ماساژ قلبی آن است که با فشار عمودی دستها بر استخوان سینه، قلب را که بین استخوان جناغ سینه و مهره ها قرار دارد بفشارند و عمل انقباض طبیعی قلب را به طریق مصنوعی ایجاد کنند. به عبارت دیگر فشاری که به کمک دستها بر استخوان سینه وارد | می آید، موجب فشردگی و حرکت مجدد قلب می شود. بهتر است ماساز قلبی همراه با تنفس مصنوعی باشد .

برای کمپرس سینه کودکان فقط از یک دست استفاده کنید؛ هر کمپرس باید استخوان سینه را حدود ۵/۲ تا ۵/۳ سانتی متر فرو ببرد. در مورد نوزادان و کودکان خردسال، استفاده از دو انگشت کافی است. در این حالت هر کمپرس بایستی استخوان سینه را حدود 1ونیم تا 2ونیم سانتی متر فرو ببرد.

در مورد کودکان ، هر دوره باید به مدت ده تا دوازده ثانیه به طول انجامد (دو تنفس و پانزده ماساژ در مدت ده تا دوازده ثانیه). بنابراین هر دقیقه شامل پنج یا شش دوره کامل می شود. درباره اطفال کوچک، مدت زمان هر دوره باید بین هشت تا نه ثانیه باشد (دو تنفس و پانزده ماساز در زمان هشت تا نه ثانیه)، بنابراین هر دقیقه شامل شش تا هفت دوره کامل خواهد شد. به هر حال اجرای دو تنفس پشت سرهم و پانزده ماساز پی در پی در هر دوره الزامی است.

در مورد پیشگیری از غرق شدن کودکان در آب، رعایت نکات زیر توصیه می شود: - به کودکان خود هرچه زودتر شنا بیاموزید.

استفاده از وسایل ایمنی شنا را هرگز فراموش نکنید .به مقررات شنا احترام بگذارید. به علایم و پرچمهای دریایی در رابطه با شنا، دقیقاً توجه کنید.

- هرگز به کودک خود اجازه ندهید بدون جلیقه نجات در قایق سرپا بایستند. - هنگام شنا کردن کودکان خود، هرگز آنها را به حال خود رها نکنید. - کودک را از شنا کردن در مناطق ناآشنا و محلهایی که عمق آن بیش از قد کودک است

برحذر دارید در محلهای مجاز که مأمور نجات غریق داشته باشد، شنا کنید..

گزش حیوانات و حشرات

مارگزیدگی، گاز گرفتن سگ و نیش حشراتی چون زنبور و عقرب از جمله مواردی است که گاهی منجر به تلفات جانی در کودکان می شود. در مورد اقدامات اولیه تا رساندن بیمار مارگزیده به مراکز درمانی، می توان بالا و پایین محل مارگزیدگی را بست، مقداری یخ روی گزیدگی گذاشت و بیمار را به پزشک رسانید. شکاف دادن محل مارگزیدگی و مکیدن محل نیش نیز اگر بلافاصله پس از گزش مار باشد مؤثر خواهد بود. در مورد گزش عقرب، اقدامات معمولا مشابه مارگزیدگی است.

در مورد گازگرفتگی توسط سگ،که احتمال ابتلا به بیماری هاری در فرد مصدوم می رود، لازم است محل گازگرفتگی را با آب و صابون و در صورت امکان با الکل بشوییم و هرچه زودتر بیمار را به مراکز درمانی انتقال دهیم.

در زنبورزدگی باید نیش زنبور را، که در محل مانده است، با دقت بیرون کشید و جای آن محلول ضدعفونی کننده زد در صورت شدید بودن درد، می توان از داروهای مسکن استفاده کرد

در جهت پیشگیری از مارگزیدگی و نیش عقرب، احتیاطات چناری را می بایست به کودکان یادآور شد، از جمله این که در جاهایی که امکان وجود مار هست، کفشهای ساق بلنده وین با چکمه پوشند زیرا احتمال مارگزیدگی در پاها بیش از سایر قسمتهای بدن است. از راه رفتن در تاریکی بر روی آلوارها بی هیزند و همچنین از فرو بردن دست در سوراخهای زمین در مورد خطرات ناشی از گازگرفتگی توسط سگ نیز باید به کودکان آموخت سنگ را هرگز عصبانی نکنند زیرا ممکن است آنها را گاز بگیرد. در محلی که سگ در آن هست داخل نشوند، مگر اینکه صاحب سگ در آنجا باشد. هنگامی که سگ مشغول غذا خوردن است با او بازی کند. اگر سگی آنها را گاز گرفت، فورا خبر دهند و سعی کنند سگی که آنها را گاز گرفته است، نشان دهند تا سالم با مریض بودنش معلوم شود.

حوادث ناشی از تغییرات دما

الف – گرمازدگی گرمازدگی نوعی واکنش بدن نسبت به گرماست که با ازدیاد فوق العاده درجه حرارت بدن و اختلال مکانیسم تعریق مشخص می شود. گرمازدگی یک فوریت است که زندگی را به مخاطره می اندازد و باید به سرعت برای رفع آن اقدام شود. هنگام گرمازدگی کودک، سریعاً وی را به سایه خنک ببرید و در صورت امکان لباسهای او

را بیرون آورید. ملافه ای دور بدنش بپیچید و مرتبا آن را خیس کنید. در صورتی که کودک بهوش باشد می توانید آب خنک و مخلوط قند و نمک به وی بخورانید. در صورت بیهوشی، از آنجا این عمل خودداری کنید و سریعا بیمار را به پزشک برسانید.

برای پیشگیری از گرمازدگی کودکان، رعایت نکات زیر مفید به نظر می رسد: - تا حد امکان باید از گردش در آفتاب شدید به خصوص در اواسط روز اجتناب کرد و کودک را در نقاط سایه و یا سرپناه نگاه داشت. – استعمال کلاه لبه دار با چتر افتابی در مواقع آفتاب شدید ضروری است. – هرگز کودک را در اتومبیلی که زیر آفتاب قرار گرفته است، به مدت طولانی نگه ندارید.

-هرگز به کودک، لباس بیش از حد نپوشانید.

ب – سرمازدگی بر خلاف گرمازدگی، اقدام اصلی در مداوای کودک سرمازده، گرم کردن هرچه بیشتر و سریعتر بدن و به ویژه انتهاهای سرمازده است. لذا لازم است کودک سرمازده را به محل گرمی انتقال داد و پس از در آوردن لباسها، اگر خیس باشند، وی را کاملا بپوشانید و بخوابانید. عضو سرمازده را می توانید با قرار دادن آن در داخل آب گرم یا پیچیدن پتو یا ملافه گرم به دور آن به سرعت گرم کنید. در صورت امکان از سرمازده بخواهید با حرکات آرام، عضو آسیب دیده را به تمرین وادارد و حرکت دهد. در صورت لزوم کودک سرمازده را به مراکز درمانی انتقال دهید.

زخمی شدن و شکستگی استخوانها بر اثر حوادث

حوادث اغلب منجر به پیدایش زخم در بدن می شوند. این زخمها گاهی در نقاط حساس بدن به وجود می آیند و سبب ایجاد عوارض مهمی میشوند و گاه در نقاط کم اهمیت بدن ایجاد می شوند، ولی در هر دو حال زخمها به مراقبتهای خاصی نیاز دارند. هنگام بروز سانحه و ایجاد زخم و خونریزی، لازم است سریعاً از خونریزی جلوگیری کنید و در صورت شدت جراحات،کودک را به مراکز درمانی انتقال دهید. بهترین روش بند آوردن خونریزی این است که ابتدا پانسمانی روی محل خونریزی بگذارید و سپس با دست به طور مستقیم به روی آن محل فشار وارد کنید. در تمام مواردی که زخم باز دست، گردن، بازو و یا ساق پا، دچار خونریزی شده است، عضو مجروح را باید در سطحی بالاتر از سطح قلب قرار دهید تا خونریزی به حداقل برسد. در این مورد، استثنایی وجود دارد و آن شکستگی عضو است. در این حالت به هیچ وجه عضو شکسته را نباید حرکت داد.

در مورد بند آوردن خون دماغ نیز می توانید بیمار را روی صندلی بنشانید و سرش را کمی به جلو خم کنید تا خون انتهای بینی به حلق وارد نشود. کلیه لباسهای تنگ او را آزاد کنید. با ریختن آب سرد، سر او را خنک کنید. پارچه سرد (حوله ای که در آب خیس و فشرده شده باشد) یا کیسه یخ به پشت گردن و روی پیشانی او بگذارید. بیمار را وادارید که پنج دقیقه با انگشتان خود، پره های بینی را محکم بگیرد، تا با فشار بر وریدهای آن قسمت که اغلب باعث خونریزی می شوند، به خون فرصت لخته شدن را بدهد. سپس لوله ای از پنبه آغشته به وازلین را در داخل دو مجرای بینی قرار دهید.

در موارد شکستگی استخوانهای کودک که بر اثر ضربه، تصادف، سقوط از بلندی، افتادن جسم سنگین بر روی استخوان و غیره ایجاد می شود، استخوان ممکن است در یک نقطه با چند نقطه بشکند؛ ممکن است سر استخوان شکسته داخل بافتها و عضلات بماند (شکستگی بسته) یا گوشت و پوست را پاره کند و به خارج آید (شکستگی باز). در هر حالت، کودک درد دارد، محل شکستگی متورم است و بیمار از حرکت دادن آن عضو بیم دارد. در چنین مواردی نیز لازم است ضمن بی حرکت کردن عضو شکسته و بستن آن با تخته بند یا آتل و رفع شوک، کودک را سریعاً به مراکز درمانی منتقل کرد.

پایان